

黄帝内经十二经脉

揭秘与应用

祝华英 著

揭示十二经脉运行奥秘
还原古圣脉口人迎诊法



中医古籍出版社

Publishing House Of Ancient Chinese Medical Books

黄帝内经十二经脉 揭秘与应用

祝华英 著

中医古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黄帝内经十二经脉揭秘与应用/祝华英著. - 北京: 中医古籍出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5152 - 1383 - 5

I. ①黄… II. ①祝… III. ①《内经》- 研究②十二经脉- 研究
IV. ①R221.09②R224.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 303800 号

黄帝内经十二经脉揭秘与应用

祝华英 著

责任编辑 孙志波

封面设计 张雅娣

出版发行 中医古籍出版社

社 址 北京东直门内南小街 16 号 (100700)

印 刷 三河市华东印刷有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13.75 彩插 17 幅

字 数 177 千字

版 次 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

印 数 0001 ~ 6500 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5152 - 1383 - 5

定 价 48.00 元

**揭示十二经脉运行奥秘
还原古圣脉口人迎诊法**

内 容 提 要

作者将数十年研究《黄帝内经》的所得公诸众，首次向世人揭示了十二经脉运行的奥秘，打破了几千年来世人对十二经脉运行的固有认识，并将以此为理论基础的脉诊、针灸、按摩、遣方用药等临床诊疗经验总结贡献出来，供中医中药界人士、人体科学界人士、养生及自然疗法爱好者阅读和参考。

本书为《黄帝内经十二经脉揭秘与应用》第三版，在前两个版本的基础上，修订完善了部分内容，调整了章节次序，使书的内容条理更清晰、更符合读者的阅读习惯。

前 言

《黄帝内经》的精髓是十二经脉理论，经络学中最本原、最重要的基础理论亦是十二经脉理论，故十二经脉理论既是中医学说的基础知识，又是学习研究中医的最高深的核心理论。但是，各类医学书籍为避免以偏概全，历代少有完整论述。又由于这一理论的创立和认识都存在着体悟的特殊性，故几千年以来，十二经脉理论几乎为秘密，鲜有依书而得者。

贫道出生于湖北省公安县埠河镇义和乡一个农民家庭，因家中亲人有病而发奋自学中医。20 世纪 60 年代初期，在学习研究古代医学经典《黄帝内经》的过程中，被十二经脉、经别、经筋、经络及奇经八脉等错综复杂的经脉路线和分支路线导入了茫茫之境。据经文记载，黄帝与岐伯都是得道通天之人，才发明了经络学说，而经络学说中之无形无象最奥妙的玄机乃十二经脉理论。贫道认识到，只有通过自身修养体证开悟，才能明白十二经脉的真相，故此边学习边投身修道。修行不久，由于机缘巧合，大小周天开通运行进而达到胎息的境界时，才明白“人体十二经脉是阴阳双向、左右对立的正负机能运行”。自此以后，再研究经络学说便不费力，且以前在学习中的难题均迎刃而解。为了更精确地了解十二经脉的玄机，后贫道投身于道教圣地武当山出家修道。历经 30 余年的潜心钻研，将所得十二经脉理论反复应用于临床进行验证，发现其疗效非凡，确诊并治好了许多疑难病证。

经络学说是我国古代先圣研究人体解剖、生理、病理、诊疗的理论核心，是指导中医临床诊疗的基础知识，是祖国医学的精华。虽然后世医家利用十二经脉理论在临床中起到了一定的作用，但贫

道认为如不明白十二经脉正负运行的机理，就不能发挥十二经脉可能及的高效调治作用，并难免失误。无形的十二经脉之正负运行真相，被道家视为不可泄露的天机，故著《素问》《灵枢》的先圣没有将十二经脉的运行机理详尽说出，只简略地阐述了人体一个侧面的正运机理，而隐藏了另一个侧面的负运机理，导致后世许多学者不明这个左右圆通的十二经脉的完整运行机理，而秉持死板教条的经络学说。为了促进祖国中医学发扬光大，使之将来能配合现代高科技进行临床诊疗，解除病人的疾苦，贫道不惜冒我道家之忌讳，将所发现和研究十二经脉的成果毫无保留地贡献给人类的健康事业。

本书对十二经脉的理论给予了详尽论述，在脉诊方面多从《灵枢》中的诊脉法形容脉象，结合本人的脉诊心得，特别注重脉口、人迎之阴阳脉象的盛衰差别，并注重阴阳动脉的寸部与尺部之强弱，以确诊阴阳经脉之正负运行的太过和不及，所以不可与其他脉学中的脉象相提并论。书中有关十二经脉理论的医学名词，如“机理”“脉波”“经气”“机能”“正负运行”“出入升降”等，都是贫道根据人体之内无形无象而又实际存在的人体能量活动而特定的。

由于十二经脉的运行无形无象，其叙述的道理是贫道在三十余年所获得的神识体验，理虽简括，义极高深，望读者细心体察、默识神会。今贫道有限的知识水平，恐难形容这个视之不能见、听之不能闻的十二经脉运行真相，然贫道所表达的是“神识微细实体”之描述，只能近似于十二经脉运行的真相，确有只可意会不能言传之憾。愿读者能以贫道所述十二经脉之正负运行的机理为纲领，掌握十二经脉的能量盛衰规律，以期展拓其临床诊疗的实用价值。

祝华英（通愚道人）

2016年3月于武当山

道即是生命而生命即
是道故世人应该学道
悟道守道修道行道切
切莫要背道而驰

武当山通愚道人撰并书



祝华英道长题字

祝华英道长：您好，蒙惠赠
 贵书十二经脉图大作，谢谢！
 足下徒之功级炼中体会十
 ：经之运行，经过医疗实践
 取得较好的效果，说明你的
 体会不虚。希望道长继续
 研究下去，继续充实大作
 再版推广，有益于医林，有
 利于患者，是所祝禱。此复祝
 道安

邓铁涛 书
 一九九一年七月十九日

邓铁涛教授给祝华英道长的信



祝华英道长为外国患者诊察人迎脉



祝华英道长和嫡传弟子祝勇



2014 年武当山第四期学习班学员合影



祝华英道长



祝华英道长为患者诊察脉口脉



祝华英道长为患者诊察人迎脉

第1版序

道教，中国土生土长的唯一宗教，是世界上独一无二的养生教。它是中国人的神仙信仰和长生思想系统化，把生命的永久保持即长生不死作为基本教义和最高追求的宗教。

“道人，有道术之人也。”——唐·颜师古注《汉书·京房传》。“人行大道，号为道士……身心顺理，唯道是从，从道为事，故称道士。”——《太霄琅书经》。后世谓道人即指有奇方异术之人，也即先秦的神仙家。

湖北省武当山道教协会道医祝通愚，就是一位有奇方异术之人。在其所作《黄帝内经十二经脉揭秘与应用》修身炼性方悟真谛里言道，他于炼午功的咽津服气之时出现了先天呼吸（胎息），经多年修炼终于悟出了十二经脉运行的真相玄机，以及炼精化气运行大小周天而达到天人合一的练功效应。这里涉及一个人们对气功与经络的关系，传统气功家认为：经络学的发现发展，可能与气功修炼实践有关。因为通过练功充实加强了元气，作为元气的一部分经气在经络内循行，因显得活泼有力而被练功家感知；有些功法更是通过凝神入气穴，结合返观、内视身内机体情况（气功中称内景者）更易被体察到。因此，可以说气功家于针灸按摩中发现和完善了经络学说。持此观点者如明·李时珍，他在《奇经八脉考》中强调：“内景隧道，惟返观者能照察之，其言必不谬。”近人余纯在《针灸指南》中也主张：“学习针灸者，必先自愿练习……静坐功夫，则人身内经脉之流行及气化之开阖，始有确实根据，然后循经取穴、心目洞明。”祝道医所论修身炼性开悟十二经脉运行之谈当属无误，也可谓心目洞明。

再者传统中医理论认为，血气津液在经脉中循行如环无端、周而复始地畅通着。但李时珍引署张紫阳的《八脉考》中的话说：“凡有此八脉（奇经八脉）俱属阴神，闭而不开，惟神仙（练功家）以阳气冲开，故能得道。”这是指当人出生后即属后天，后天的奇经八脉是关闭的（包括祝氏所说胎息关闭），只有通过练功家在内在气旺盛的情况下，才使它们重新通行。并认为：人能通此二脉（任、督）则百脉皆通，自然周身流转，“无有停壅之疾，而长生久视之道断在此矣”。祝道医的周天功法，或叫内丹术大概也是指此而言。一般以内气在任、督脉上周流循环者叫小周天，再扩大到其他十二经脉上为大周天。祝道医通过经年修身炼性静化身心的周天功法修炼，亲身体悟出十二经脉运行的真谛。

一、强调十二经脉是阴阳双方左右对立的机能运行，或叫十二经脉的运行呈现左右对立的“双向正负运行轨道”，就像玄门太极阴阳☯往返旋转一样的运行。任、督二脉是由两条经脉合并的，也有左右各自不同的升降往返机能，督脉与足三阳经运行相反，任脉与足三阴经运行相反，证明奇经八脉的机理全是“中和力”以协调十二经脉运行。说明任、督二脉与十二正经的运行全是对立性反作用，及十二经脉根结溜注的见解。

二、强调并倡导人迎、脉口双诊并用及具体诊法操作，以期充实脉诊的准确可靠性。

三、强调十二经脉阴阳双向正负运行的观察辨证指导的方药、针灸、按摩疗法及临证验案，并由此认为是人体之内生命活力的真能量之道等，经验老迈，见仁见智。

而今经络学说研究，乃至针灸、气功诸学科的研究工作，实际是自古至今都受到不同国籍、不同文化、不同学科的学者志士潜心研究，毕其精力于一役者也不乏其人。比如现代对气功原理学的研究中就有气功的生理效应（呼吸生理、心血管生理、神经生理），气功的心理效应，得气感是一种心理与生理的综合效应，意守是一

种人体的自我反馈过程，自发功是一种心理顺从和心理放大效应，组场练功和带功报告的研究，外气治疗的心理暗示，以及气功的生化、免疫效应，还有气功的生物物理和物理效应，包括人体红外线辐射、人体声波、人体磁场、人体光学、练功过程的辐射场效应等。探玄钩沉，实非易事。

祝道医能以道家之颖悟，修身炼性静化身心，内具周天之功法，外兼传统医学之理论，近观、内视经脉之轨迹，养生长命济世活人之灼见，诚乃一家之真言，以期付梓。

谨步唐·吕纯阳诗云：

精养灵根气养神，
理法方药趣义真；
神仙诚然说分明，
启济千千万万人。

杨澄宇

1997年9月9日午夜

第 2 版序

中医学是中华民族源远流长而又富于生命活力的文化宝藏，针灸经络学是中医学的重要组成部分。武当道医祝老先生历经数十载研究与临床实践撰写的《黄帝内经十二经脉揭秘与应用》一书，参照古贤与同道的临床经验，追求资料完备、观点新颖、水平领先，兼具学术性与实用性的目标，经过长年修炼，较好地体悟出了十二经脉运行的真相玄机，在多姿多彩的世界科学之林中独秀一枝，唯其极具民族医学特色。

全书共分 37 个章节。根据祖国的“医学理论”和道家的“道学理论”相同，都是以“天人合一”的观点，以针灸医学的核心理论经络学说、经络辨证诊治为主线，八纲、脏腑、气血等辨证诊治方法贯穿其中。比较全面地诠释了人体内十二经脉及其玄妙的运行规律，系统论述了诊疗以脏腑阴阳之十二经脉的表、里症状作辨证基础；从脉口、人迎以辨别左右、阴阳、上下的虚实作指南；并根据以上两类理论体系相结合，注意患者之阴、阳动脉的盛衰演变现象，从而拟定出调整阴、阳经脉平衡的方法，以契合古圣先哲有原则性的阴、阳辨证施治。文中基础指导临床，理论联系实际，体例严谨规范，层次井然有序，内容丰富多彩，实用指导并重，对于广大从事针灸临床、教学、科研人员以及在校医学生学习、掌握针灸临床辨证诊治方法和技巧具有较高的实用价值。

任何学科都有其逐步发展的过程，因而相对就存在一定的局限性，针灸经络学亦不例外。“黄帝内经十二经脉”由于产生于我国古代，限于当时的社会、历史条件，只能是相互的、自发的，因而有其笼统和直观的局限的可能性，不能全面地、深刻地提示复杂的

生命现象和病理现象。因此，只能在科学的辩证唯物主义的思想指导下，用现代的科学技术、方法、知识去充实发展经络学说，我们才能使之对人的正常的生命现象和疾病的认识更接近于客观真理，并有效地运用于实践，为人类医疗保健事业的发展作出贡献。道医祝老先生正是顺应这一时代需要而动，在《黄帝内经十二经脉揭秘与应用》原书的基础上，根据练功的体验，进一步强化了十二经脉的运行能量，使之能够更便捷地帮助读者从错综复杂的病证中探寻针灸辨证诊治的规律性和灵活性，体悟出十二经脉运行的真谛，从而提高诊治病证的分析能力。

《黄帝内经十二经脉揭秘与应用》是一本既有理论性又有实用性和创建性的道家诊疗专著，本书的再版是件很有意义的事，承作者所托，故乐之为序。

刘家瑛

2013 年 12 月

于北京中国中医科学院



目 录

第一章 十二经脉运行理论矛盾之谜	(1)
第一节 十二经脉与天地阴阳之道	(1)
第二节 十二经脉是人体生命之本	(2)
第三节 十二经脉运行理论的四个矛盾	(3)
第二章 道体探玄方悟十二经脉运行真谛	(7)
第一节 道体探玄方悟真谛	(7)
第二节 《黄帝内经》中有关十二经脉的一切论述不到一个 呼吸的分析	(10)
第三章 解释十二经脉运行理论的四个矛盾	(12)
第一节 解释出井入合矛盾	(12)
第二节 解释根结矛盾	(13)
第三节 解释根溜注入矛盾	(19)
第四节 解释经脉生理矛盾	(24)
第五节 一隅三反得十二经脉全璧	(24)
第四章 十二经筋与十二经脉	(29)
第五章 十二经络与十二经脉	(31)
第六章 奇经八脉与十二经脉	(34)
第一节 概述	(34)
第二节 对奇经八脉的治疗分析	(37)



第三节	奇经八脉生长衰老过程	(37)
第七章	五脏六腑与十二经脉	(44)
第一节	十二经脉的运行机能	(44)
第二节	脏阴腑阳互相为用	(48)
第三节	五脏六腑与十二经别的开阖机能	(49)
第四节	五脏六腑混元统一论	(50)
第八章	脉口、人迎对比诊法	(53)
第一节	脉诊的诊法	(53)
第二节	古圣人诊候脉口、人迎出入升降的例证	(56)
第三节	阴阳两性的脉象诊断	(59)
第四节	对脉口、人迎动脉之一倍二倍三倍的分析	(61)
第五节	对阴阳动脉的认识及阴阳双诊的优点	(63)
第六节	关于人迎脉的诊法	(66)
第七节	对缓急大小滑涩六脉的认识	(68)
第八节	脉诊中的现实情况	(70)
第九章	脏腑辨证与十二经脉	(71)
第十章	六淫致病与十二经脉	(81)
第十一章	运用十二经脉理论进行针灸治疗	(87)
第一节	概述	(87)
第二节	临床典型病例	(89)
第三节	针灸调治小结	(100)
第十二章	运用十二经脉理论进行推拿按摩治疗	(105)
第十三章	运用十二经脉理论进行药物治疗	(108)
第一节	古代名方与药物归经	(108)
第二节	中药治疗病例	(121)



第三节	注射药物治疗病例	(164)
第四节	西药治疗的病例	(169)
第五节	用药物治病的心得	(170)
第十四章	运用十二经脉理论替代手术治疗	(177)
第十五章	略论动静功健身法	(182)
第十六章	运用十二经脉理论的心得体会	(184)
第一节	诊疗疾病的心得体会	(184)
第二节	中医辨证的心得体会	(186)
第十七章	十二经脉理论是契合中西医的桥梁和诊疗指南	(190)



第一章 十二经脉运行理论矛盾之谜

第一节 十二经脉与天地阴阳之道

祖国医学发源于《黄帝内经》，这部中医经典从始至终都贯穿着天人合一的理论观点。贫道根据练功的体验认为，发现经络学说是古圣人通过养身修道达到与宇宙的大自然之道合体之时所取得的中医理论——十二经脉理论。祖国医学理论虽玄，却是通过自身反应内观证得，故是十分科学实用的，所以数千年来一直指导着人类疾病的治疗与预防。

祖国的医学理论和我们道家的道学理论相同，都是天人合一的观点，认为宇宙有无形无象之三阴三阳的循环轨道场在运行五运六气，产生春、夏、秋、冬四季的变迁；人体之内有无形无象之三阴三阳的循环轨道场（即十二经脉）在运行五脏六腑，产生春季脉弦、夏季脉钩、秋季脉浮、冬季脉石的脉象变迁。在宇宙间若没有自然大道的运行能量，日月星辰即不能有规律地运行，万物也不能生长；在人体内若没有十二经脉的运行能量，人就没有生命；所以，人体的十二经脉运行之道至关重要，又非常玄妙。

（《灵枢·经别》）黄帝问于岐伯曰“余闻人之合于天道也，内有五藏，以应五音、五色、五时、五味、五位也；外有六府，以应六律，六律建阴阳诸经而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者，此五藏六府之所以应天道”，又如《素



问·气交变大论》以天人相应的观点说“肝应岁星（木星），心应荧惑星（火星），脾应镇星（土星），肺应太白星（金星），肾应辰星（水星）”，说明宇宙是个大天地，人体是个小天地。前圣曰“人乃天地之精灵”，可以说人体即是天体的一个缩影，太阳系的天体结构在人体内都有，但却隐藏着，因而许多修行人在修炼到一定程度时（有日月会合境界），就能返观内照见到太阳、月亮、星辰，故我们道家说“大道在自身，身外无道”，也说明我们的人体已具备天地之全璧，应予珍惜修养。

第二节 十二经脉是人体生命之本

《灵枢·经别》曰：“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起，学之所始，工之所止也。”明代医学家张介宾注释道：“经脉者，脏腑之枝叶；脏腑者，经脉之根本；知十二经脉之道，则阴阳明、表里悉、气血分、虚实见，天道之逆从可察，邪正之安危可辨。凡人之生，病之成，人之所以治，病之所以起，莫不由之。故初学者必始于此，工之良者，亦止于此而已。”这充分说明，十二经脉理论虽然是中医理论体系的组成部分，但在诊疗疾病上却联系着阴阳五行、脏腑气血、表里虚实、邪正安危，故非常重要。

《灵枢·经脉》云：“经脉者，所以能决死生，处百病，调虚实，不可不通。”说明经络学说在中医的诊疗上有至关重要的地位，初学祖国医术者怎能不从这个简捷的十二经脉机理入手，如想求得医之精深者，又怎能舍却十二经脉的真理而他求呢？

明代马元台在《灵枢·注证发微》中说“此言十二经脉……实学者习医之第一要义，不可不究心熟玩也。后世能言不识十二经



络，开口动手便错，而于此懵然，惜哉”，说明不明十二经脉道理治病，其错误难免。

所以，贫道平生劳心费神地挖掘古圣经络学说的隐秘，期望揭开十二经脉机理，使之真相大白而服务于健康事业。贫道通过多年来的研究探讨，确认十二经脉阴阳正负的灵机运行能量是枢转不息的，所以古圣著作针经而定名为《灵枢》，即明确地指示我们人体内有这个视之不能见、听之不能闻的灵机（或称元神）在枢转，这个阴阳正负无止息的运行灵机一直到人死亡时才告终结。

贫道的临床经验：人在死亡之时，不是先绝于阴面即是先绝于阳面，因而相对立之后绝的一面就不能够孤立地存在，随之脱形而出，故阴阳神机离体人即死亡，所以为医者在拯救危症之时，当特别关注拯救其薄弱的一面，贫道认为是非常重要的。

第三节 十二经脉运行理论的四个矛盾

祖国医学中的十二经脉理论，出自于《素问》《灵枢》。人体五脏六腑的十二经脉各有两道经脉，一道位于左侧，一道位于右侧，而《灵枢》中对十二经脉的论述仅一个侧面而已。贫道认为，若研究人体十二经脉的运行机理，必须将《灵枢》中有关十二经脉的一切论述综合起来研究，才能悟出真谛。如果仅凭《灵枢》中某一章节片面的论述来分析，即形成种种不可理解的矛盾。例如经云“手之三阴从胸走手，手之三阳从手走头，足之三阳从头走足，足之三阴从足走腹”，数千年以来，中医界人士都遵循这一教条传承至今，如果手、足的经脉一直是按照以上的规律之道循行，即形成自我矛盾。



一、井、荥、输、经、合的出入矛盾

《灵枢·本输》曰“手太阴肺经，出于少商为井木，溜于鱼际为荥，注于太渊为输，行于经渠为经，入于尺泽为合”，又经云“手之三阴，从胸走手”，如果手太阴肺经全是从胸走到手，那么从少商穴出是合乎运行道理的，但入于尺泽穴即形成经气倒流的矛盾现象，何以手太阴肺经在走过的路线中而入呢？此为手三阴经之入合穴的自我矛盾现象。

《灵枢·本输》曰“手阳明大肠经，出于商阳为井金，溜于二间为荥，注于三间为输，过于合谷为原，行于阳溪为经，入于曲池为合”，又经云“手之三阳，从手走头”，若手阳明大肠经一直是从手走到头，那么入于曲池穴是合乎运行道理的，但出于商阳穴就矛盾了，商阳穴位于手指端，为何从手阳明经的起点而出？又为何所出之商阳穴反处于所入的曲池穴之后呢？此为手三阳经之出井穴的自我矛盾现象。足三阳经与足三阴经之“出井、入合”的矛盾，亦按以上道理推论，足三阳经的“入”呈矛盾现象，足三阴经的“出”呈矛盾现象。

二、根、结矛盾

《灵枢·根结》云“太阳根于至阴，结于命门。阳明根于厉兑，结于颧大。少阳根于窍阴，结于窗笼。太阴根于隐白，结于太仓。少阴根于涌泉，结于廉泉。厥阴根于大敦，结于玉英，络于膻中”，又经曰“足之三阳从头走足，足之三阴从足走腹”，若联系以上足三阳经与足三阴经之走向来推理阴阳根、结的居点，足三阴经的根、结居点是合乎循行规律的，因为足之三阴从足走腹，故应根在足而结在胸上。若是将足三阳经的根、结居点来对照足三阴经的



根、结居点定理，足三阳经的根当在头而结当在足，为何足三阳经的根反在足而结反在头呢？此乃根、结矛盾。

三、根、溜、注、入矛盾

《灵枢·根结》云“足太阳根于至阴，溜于京骨，注于昆仑，入于天柱、飞扬也。足少阳根于窍阴，溜于丘墟，注于阳辅，入于天容、光明也。足阳明根于厉兑，溜于阳谷，注于下陵，入于人迎、丰隆也。手太阳根于少泽，溜于阳谷，注于小海，入于天窗、支正也。手少阳根于关冲，溜于阳池，注于支沟，入于天牖、外关也。手阳明根于商阳，溜于合谷，注于阳溪，入于扶突、偏历也”，据以上足三阳经与手三阳经的根、溜、注、入走向，若结合手之三阳从手走头、足之三阳从头走足的道理分析，其手三阳经之根、溜、注、入的循行路线是合理的，它是随着手之三阳从手走头的路线而根、溜、注、入的，但是足三阳经的根、溜、注、入路线就不符合道理了，不但不能从头走足来根、溜、注、入，为何反而从足走头而根、溜、注、入呢？此乃根、溜、注、入矛盾。

四、经脉生理的矛盾

黄帝曰“经脉者，所以决死生，处百病，调虚实，不可不通”，《灵枢·经脉》中所描述的只是人体阴阳十二经脉的循行路线及分支路线，绝不是人体阴阳十二经脉之内在的机能机理。因为《灵枢·经脉》所表达的循行路线，确实是一条单向循行出入而进行阴阳交接的路线，阴阳交接之处均在手、头、足、腹。按照此理论，那些切除了四肢的患者们，手足处的阴阳交接就应该没有了，按理说会影响他们身体上十二经脉的阴阳交接和人体左右联系，但为何这些患者的生命还依然存在，那么这些患者体内的阴阳十二经脉的内



在机能又是怎样进行阴阳交接的呢？此乃经络生理的矛盾。

诸如以上十二经脉的出井入合、根结、根溜注入及经脉生理等经脉循环迂回的矛盾，从古至今著书者众说纷纭，皆附和着经典的理义注释而已，均没有指出十二经脉之内在所形成的各种矛盾，而难圆其说。



第二章 道体探玄方悟十二经脉运行真谛

第一节 道体探玄方悟真谛

贫道初学十二经脉的循行路线，犹如乱丝难以理顺，历代医家对经络学说的见解各持己见，未能获得十二经脉运行的奥秘，面对前面所列出的种种矛盾百思不解。

《黄帝内经》之天人合一整体观念，与道家天人合一的思想宗旨相同，著《黄帝内经》的黄帝、岐伯都是得道通天之人，有关经络循环运行的机理，应是古圣人在养生炼道中自身显示体证出来的玄机奥秘，所以虽然著出《素问》《灵枢》于世，却藏头去尾深隐保密，如未经真师口传心授，实难解释其真谛。

为了解开数千年没有解开的十二经脉运行矛盾之谜，贫道于 20 世纪 60 年代开始修身炼性、静化身心，按子午卯酉四时静坐。修炼不久，由于机缘巧合达到胎息的境界，终于悟出并亲身体验到十二经脉运行的真谛，从而揭开了千古之谜。其秘和玄门太极阴阳往返旋转的运行一样，十二经脉也是呈现左右、阴阳对立共振的双向正负运行。根据其阴阳对立共振的双向运行，使以前研究十二经脉的四个矛盾得到了合理的解释。

十二经脉在脏腑、表里相配合的阴阳共振对立运行是小循环运行，贫道能清楚地用文字表达出来，在后面解释根、溜、注、入矛盾章上详述，而每一个侧面有三道大循环运行，但因隐隐约约、恍



惚杳冥，且比小循环运行更深奥、更玄妙，所以无法用语言文字来形容表达，故只提示一下而已。

附：手足三阴三阳的动态现象

贫道有一次在炼午功的咽津服气之时，明显感觉吞下一个清凉的圆团降入下丹田，随即停止了后天的鼻息，同时在下丹田出现了先天呼吸（胎息），即觉得身心非常凉爽明静，周身的气血似停若滞，仅清晰地感觉到脐部（下丹田）处，有约3cm的透明圆球在微微地、缓慢地正反、往来地周旋着。约10分钟后，明确感觉到四肢的内、外侧各有三条经脉路线一致地运行着。原来手足之内侧的三阴经与手足之外侧的三阳经以同速反向运行着，即内侧手三阴经向指端运行时，外侧手三阳经则向肩部方向运行；同时，外侧足三阳经向足趾方向运行时，则内侧足三阴经向腹部方向运行。但是，身体另一侧的手足之三阴经与三阳经的运行，分别与之相反，即左侧的手三阴经向指端运行时，则右侧的手三阴经向腋窝方向运行；其余的三阴三阳逆行经脉类推。

这左右两侧相对立往返无休止的三阴三阳同速运行，使贫道亲身体验到十二经脉的运行是呈现双向正负运行规律的。可是，手三阴经与手三阳经的双向回旋运行不过肘，足三阴经与足三阳经的双向回旋运行不过膝。这种阴阳正负运行，便是贫道悟开十二经脉奥秘的关键所在。

贫道处于这种胎息的状态历时较长，故清晰地觉察到：

1. 左手之手三阴经的机能正运行至手指的同时，左手之手三阳经即正运行至头，左足之足三阳经即正运行至足，左足之足三阴经即正运行至腹。同时，右侧之足三阴经即负运行至足，右侧之足三阳经即负运行至头，右侧之手三阳经即负运行至手，右侧之手三阴经即负运行至胸中。再接着，右侧正运，而左侧就负运；左侧正



运，而右侧就负运。正常人每行 1 个呼吸之时，其左侧约正运行 2 次、负运行 2 次，右侧亦正运行 2 次、负运行 2 次，十二经脉的内在机能始终都是正负无休止的升降、进退运行。（表一）

表一 胎息发现左右手足十二经脉正负运行方向表

左侧正运右侧负运表		右侧正运左侧负运表	
左侧手三阴	从胸→手	右侧手三阴	从胸→手
左侧手三阳	从手→头	右侧手三阳	从手→头
左侧足三阳	从头→足	右侧足三阳	从头→足
左侧足三阴	从足→腹	右侧足三阴	从足→腹
右侧足三阴	从腹→足	左侧足三阴	从腹→足
右侧足三阳	从足→头	左侧足三阳	从足→头
右侧手三阳	从头→手	左侧手三阳	从头→手
右侧手三阴	从手→胸	左侧手三阴	从手→胸

2. 人体中线的督、任二脉是两条经脉相合并的，也有左右各自不同的升降、往返运行机能。

3. 足三阳经和足三阴经、手三阳经和手三阴经之别络穴处的阴阳机能交合，是人体表里、阴阳经脉交换最奥秘的联系之所，这一现象在后章解释根、溜、注、入矛盾时详述。

4. 头部的两侧亦有左右各自不同的升降、进退运行机能，只是运行路线复杂，感觉不太分明，仅感觉其复杂的经脉升降运行机能由头部至项部而止。

5. 胸腔和腹腔内的脏腑也有类似的阴阳、进退运行机能，但因



脏腑的位置分散而难以分辨清楚。如果依据手足四肢的三阴经和三阳经之明显对立的运行规律，对头部和脏阴腑阳的经脉运行也能够推理而得到解释。

在胎息的状态历时达4小时之后，由于一点思维念头略心，陡然间贫道恢复了后天呼吸，周身由凉转温，手足之三阴三阳经脉的运行机能也消失。这次胎息的体验，使贫道多年研究十二经脉所遇到种种不可理解的矛盾获得了解释。因此，将研究十二经脉的收获贡献于世，以供爱好研究十二经脉的同人们验证落实，使祖国医学发扬光大。

第二节 《黄帝内经》中有关十二经脉的一切论述不到一个呼吸的分析

《素问·灵兰秘典论》云“至道在微，变化无穷，孰知其原！窘乎哉，消者瞿瞿，孰知其要！闵闵之当，孰者为良！恍惚之数，生于毫釐，毫釐之数，起于度量，千之万之，可以益大，推之大之，其形乃制”，以上说明我们人体之五脏六腑十二经脉的生化能量无形难辨，但是古圣人在阐述五脏六腑之十二经脉的机理起源时，是从很微小、很短暂、一刹那、一瞬间而不到一个呼吸的往返运行为起点，再沿着这一个微小呼吸，由一呼脉行三寸、一吸脉行三寸的推移来推之大之，演化出一秒、一分、一刻、一时、一日、一月及一年的五运六气阴阳运行。

所以，大道理是从微小道理产生的。贫道研究后认为，《灵枢》对有关十二经脉运行过程的论述，都未达到一个呼吸的时间，论述最多的章节实只达到半个呼吸的运行时间，论述最少的章节只有一个呼吸之四分之一的的时间。



例如，论述“手之三阴，从胸走手；手之三阳，从手走头；足之三阳，从头走足；足之三阴，从足走腹”，只说出了人体一个侧面十二经脉的正运机理；论述手三阳经的根、溜、注、入之运行，也只说出了人体一个侧面之手三阳经的正运机理；论述足三阳经的根、溜、注、入之运行，亦只说出了人体一个侧面之足三阳经的负运机理；以上都不过只说到一个呼吸之四分之一的十二经脉运行时间。

又例如，论述十二经脉的别正、六合运行，乃是一个侧面之正负运行的阴阳交合，故有一往一来的运行时间。

再例如，论述足三阴经与足三阳经的根、结，其运行机理从根运行到结、由结运行到根，亦只有一升一降的往返时间。

以上3例，都只是论述到一个呼吸二分之一的十二经脉运行时间，所以说《灵枢》中有关人体十二经脉的全部论述，确实没达到人之一个呼吸的所有循环过程。古圣人发现的经络学说是非常玄微深奥的，但是这个最微、最小、最简捷的十二经脉道理之中，却包含着最浩大的天地宇宙之理。



第三章 解释十二经脉运行理论的四个矛盾

第一节 解释出井入合矛盾

上一章阐述了十二经脉的正负运行机理，根据这种阴阳正负运行的机理，对第一章所提出的十二经脉运行的四个矛盾就能够进行合理的解释。当手太阴经脉正运外出时，其经气运行到井穴；手太阴经脉负运内入时，其经气运行至合穴。手阳明经脉正运上行时，其经气运行到合穴；手阳明经脉负运下行时，其经气运行至井穴。这便证明，手三阴经与手三阳经的进退、伸缩机理，确是不超过肘关节的机能运行。

（《灵枢·本输》）黄帝问于岐伯曰：“凡刺之道，必通十二经络之所终始，络脉之所别处，五输之所留，六腑之所与合，四时之所出入，五脏之所溜处，阔数之度，浅深之状，高下所至。愿闻其解。”岐伯曰：“请言其次也。肺出于少商，少商者，手大指端内侧也，为井木；溜于鱼际，鱼际者，手鱼也，为荥；注于太渊，太渊，鱼后一寸陷者中也，为腧；行于经渠，经渠，寸口中也，动而不居，为经；入于尺泽，尺泽，肘中之动脉也，为合，手太阴经也……大肠上合手阳明，出于商阳，商阳，大指次指之端也，为井金；溜于本节之前二间，为荥；注于本节之后三间，为输；过于合谷，合谷，在大指歧骨之间，为原；行于阳溪，阳溪在两筋间陷者中也，为经；入于曲池，在肘外辅骨陷者中，屈臂而得之，为合，



手阳明也……”《灵枢·本输》在论十二经脉的开端，就典型提出这五脏的井、荥、输、经、合五输穴，六腑的井、荥、输、原、经、合六输穴，并详细说明了手足三阴经的井、荥、输、经、合五穴，与手足三阳经的井、荥、输、原、经、合六穴的位置，但对周身其他穴位不讲，可证明五脏的五输穴与六腑的六输穴是调治阴阳经脉的重要穴位，也是调治一切疾病的重要穴位。

由于五脏的井、荥、输、经、合五输穴和六腑的井、荥、输、原、经、合六输穴，都处于肘膝以下，是阴阳经气交换的重要场所，根据贫道胎息时的体验，在手足四肢三阴三阳经脉最明显的出入运行机能，都是手不过肘、足不过膝，就认为阴阳经气的交换重点是在手足四肢。虽然头颈之上、脏腑之内亦存在阴阳经气相互交换，但是次于手足四肢之处的，故手足四肢之肘膝以下的输穴，能调治五脏六腑、各经脉的有余或不足，是处治百病的常用穴位。

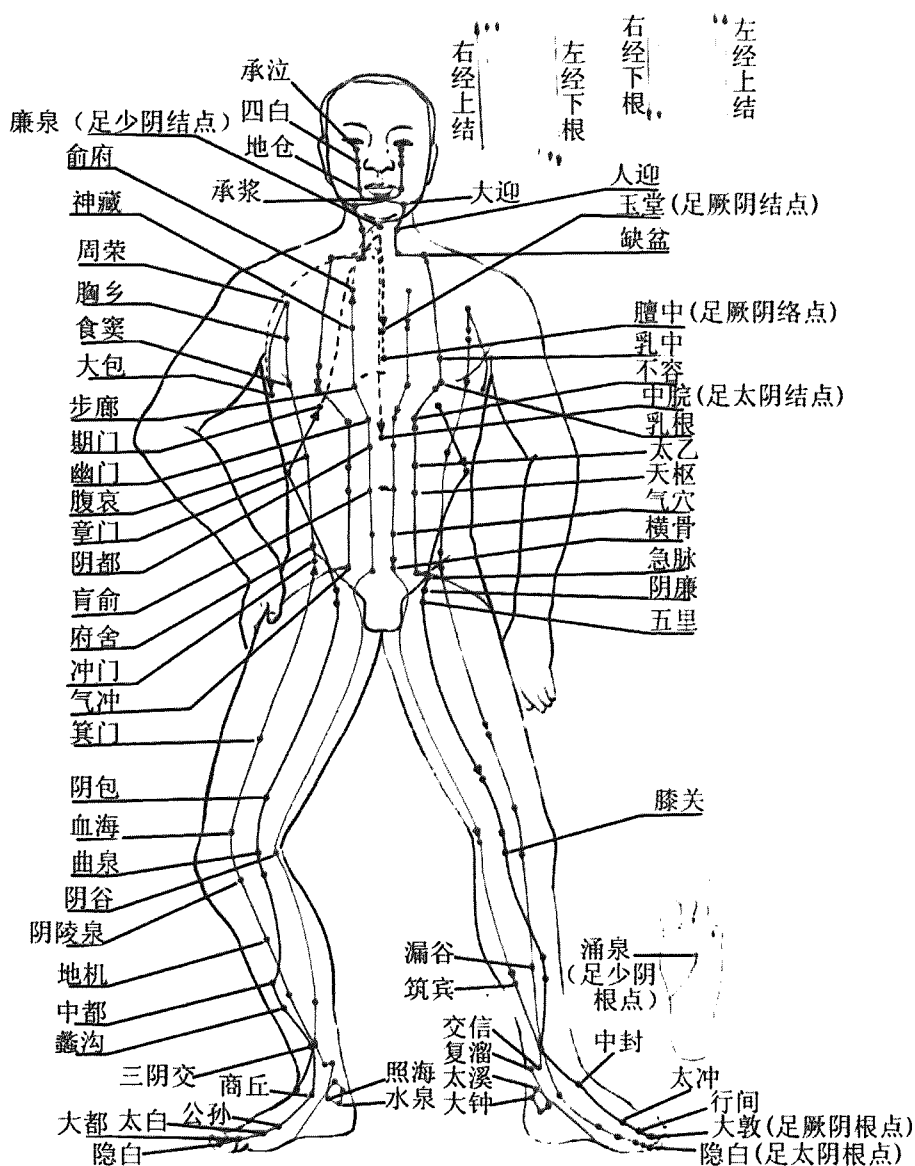
例如，《灵枢》中论治疗疾病时常云“取之足少阴、取之足太阳”等等，凡是言取之某经而没有指明某穴位者，全都是指取手足四肢之肘膝以下的穴位。（《灵枢·九针十二原》）黄帝曰：“愿闻五藏六府所出之处。”岐伯曰：“五藏五腧，五五二十五腧；六府六腧，六六三十六腧。经脉十二，络脉十五，凡二十七气，以上下，所出为井，所溜为荥，所注为腧，所行为经，所入为合。二十七气所行，皆在五腧也。”这就说明，调治各脏腑、阴阳经脉的一切疾病，主要是采取四肢肘膝以下的 122 个穴位，以调整十二经脉的阴阳气机，所以特别地阐述于《灵枢》的首位。

第二节 解释根结矛盾

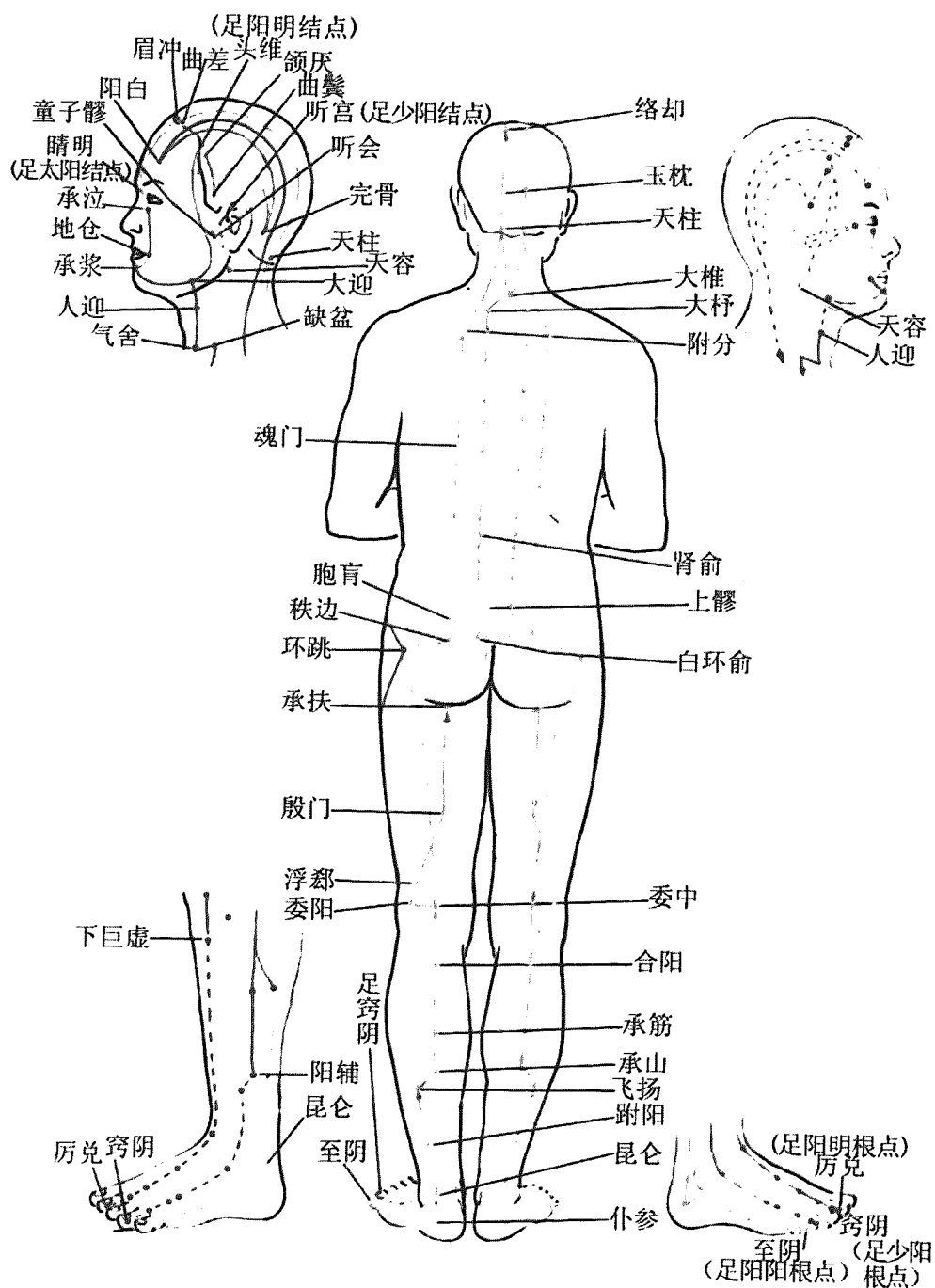
当足三阴经正运上升之时，足三阴经气运行至结穴；足三阴经



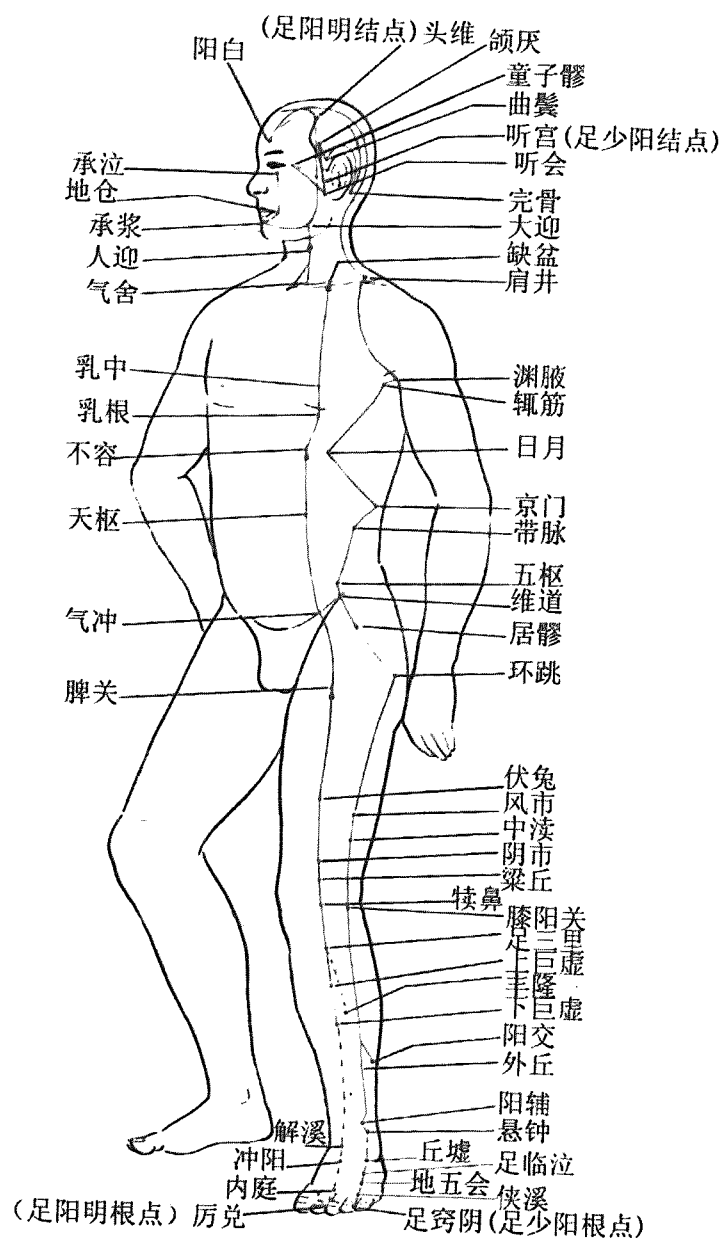
负运下降之时，足三阴经气运行至根穴。(图一、图二、图三)



图一 根结总图 1



图二 根结总图 2



图三 根结总图 3



当足三阳经正运下降之时，足三阳经气运行至根穴；足三阳经负运上升之时，足三阳经气运行至结穴。所以，足三阴、足三阳都是与它相表里的阴阳经无间断地根结着。如阳经在根，阴经就在结；如阴经在根，而阳经就在结。

如果用针灸调治疾病，首先当诊察上下、左右、内外、阴阳之正负根结机能的盛衰，才能做到有的放矢地去调和十二经脉。

《灵枢·根结》曰“奇邪离经，不可胜数，不知根结，五藏六府，折关败枢，开阖而走，阴阳大失，不可复取。九针之玄，要在终始，故能知终始，一言而毕，不知终始，针道咸绝”，以上足以说明这根结机能正负活动的始终机理，能够挽回五脏六腑折关败枢、阴阳大失的危症，所以明白十二经脉的根结机理，该是何等的关键、何等的重要啊！

调治根结的实质，并非是指其固定的根结腧穴，而是指这左右上下阴阳神气的升降、往返之活泼泼的机能。

人体的某一道阴阳经脉路线，好比火车道，其腧穴犹如火车站，其经气犹如火车，如果没有火车运行往来，火车道和火车站也没有作用。故人死了，经络、腧穴仍在，却没有阴阳神气往来，如果用针刺亦没有感觉，所以也无作用。《灵枢·九针十二原》曰“所言节者，神气之所游行出入也，非皮肉筋骨也”，此处明确表达出所注重的是体内这个出入游行的灵动之神气。根结经气失调所造成的疾病，就如火车不能运行到终点站，或是由终点站不能回到起点站。折关败枢、开阖而走、阴阳大失的危急重症，就如火车将要产生越轨而发生生命危险，故施针灸者当及时按照十二经脉的阴阳、正负机理施法救治。



附：典型病例

患者：熊某某，女，71岁，公安县人，于1979年3月25日夜诊。

症状：患者夜间忽然发病昏倒不省人事，经二位医生治疗无效而请贫道医治。患者当时双目紧闭，面色微红，口不能言，上气喘息，喉间痰鸣辘辘有声，手温足凉，两手能动而两足不能动弹。

脉候：左右脉口、人迎的动脉，阴阳双方全显寸部脉大而尺部弱小，呈现二倍脉象，浮候有余而沉候下虚不足，脉显阴阳双方浮越戴阳于上。

治疗：据患者两手能动，可排除中风之病，分析原因为下焦真阴空虚不能纳阳，导致阴阳双方浮越欲脱，其病源在肾。因足少阴肾经主下行，其经脉循行上挟舌本，故形成以上诸症，诊断为足少阴肾经的下元亏虚所导致阴不能纳阳而形成类中风痲之证。法当固本培肾但却无药物救急，情急之下唯有按十二经脉的根结机理施治。遂取玻璃瓶盛满温水置于患者的两足下涌泉穴处，用温热传感以导引足少阴肾经的经气归根，同时按压两足的内庭、昆仑穴，以导阳经的经气下达。经过30分钟传热及按摩导引，患者的两足转温，舌能言，喘平，痰下而安。

体会：《素问·阴阳应象大论》云“阴胜则阳病，阳胜则阴病”，所以在临床上治病可以阳病阴治，阴病阳治。如因阳虚不能治阴而导致阴盛的，则阳虚为本、阴盛为标，当益阳以消阴，即所谓“益火之源，以消阴翳”。若阴虚不能潜阳而导致阳亢的，则阴虚为本、阳亢为标，当滋阴以潜阳，即所谓“壮水之主，以制阳光”。所以诊疗此患者，要采取滋阴以潜阳而“壮水之主，以制阳光”的法则。贫道诊疗此病的时期，对人体十二经脉的机理认识还比较肤浅，由于见有疗效就以为在处置方面十分正确，在后来的研

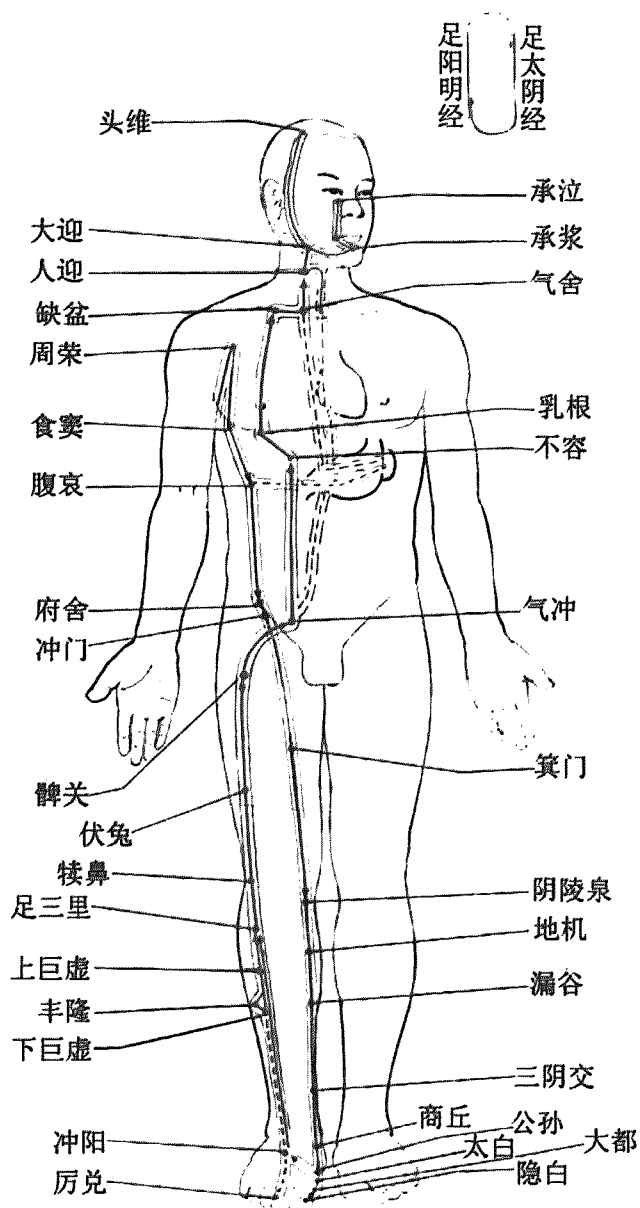


究中则不以为然。根据十二经脉的机理认为，患者在当时所获得的疗效完全是温熨左右涌泉穴的效果，故温熨涌泉穴能济阴以潜阳是十分合理的调治方法。配合按摩患者的内庭、昆仑穴在当时自认为很正确，后来对人体十二经脉的机理钻研进一步深入才认识到，当时应采取按摩患者的后溪、合谷穴为妥。所以，十二经脉之阴阳根结的运行机理，可作一切疾病辨证施治的指南。

第三节 解释根溜注入矛盾

足三阳经与手三阳经的根溜注入的机能运行，应区别足三阳经与手三阳经不同的运行道理。足三阳经是负运行之时产生根溜注入的，手三阳经是正运行之时产生根溜注入的。只举足阳明胃经和手阳明大肠经为例：正当足阳明经负运而经气上行之时，在足的足阳明经气即由厉兑穴处退缩而上行溜流于冲阳穴，继续上注于下陵穴；同时，颈部的足阳明经气即从人迎穴处上升运行至颞大穴而终结；与此同时，还分支一道经气进入人迎穴。进入人迎穴的别行经气进入何所呢？因此时足太阴脾经的经气在负运至足，故上部的脾经散舌下经脉气空虚，所以足阳明经气是由人迎穴入贯舌中，与足太阴脾经的散舌下之脉相吻合，即形成如环无端的阴阳交合机能。同时，足太阴脾经负运而经气下达至足大趾的隐白穴，还分支一道经气由公孙之别穴外出与足阳明的经气相吻合，便形成如环无端的阴阳交合运行机能。（图四）

当足阳明经正运下行之时，在头部的足阳明经气即由颞大穴下降至人迎穴处；同时，处于下肢的足阳明经气即由下陵穴下降至厉兑穴而终止；与此同时，还分支一道经气由丰隆之别穴进入足太阴经与之相吻合。这说明，十二经脉不论正运与负运，都是如环无端

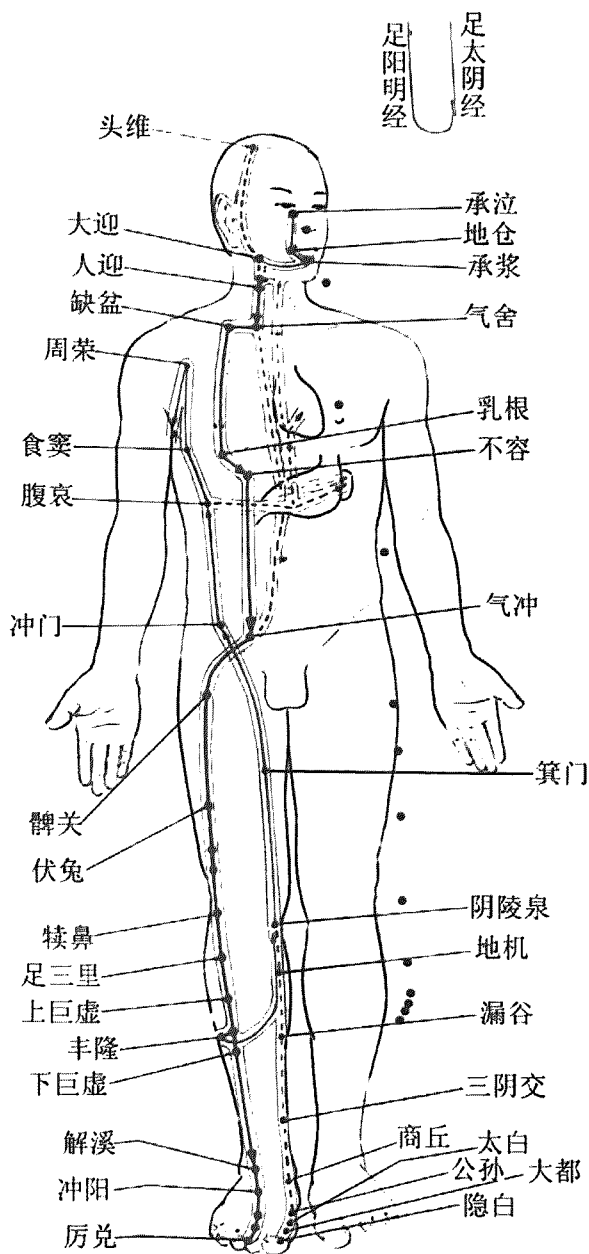


图四 足阳明胃经负运根溜注入图

的运行机能。《灵枢·根结》云“足阳明根于厉兑，溜于冲阳，注于下陵，入于人迎、丰隆也”，所谓“入于人迎、丰隆也”，是言足阳明经气根溜注入负运上行时，该经气由人迎之别穴而入，正运下



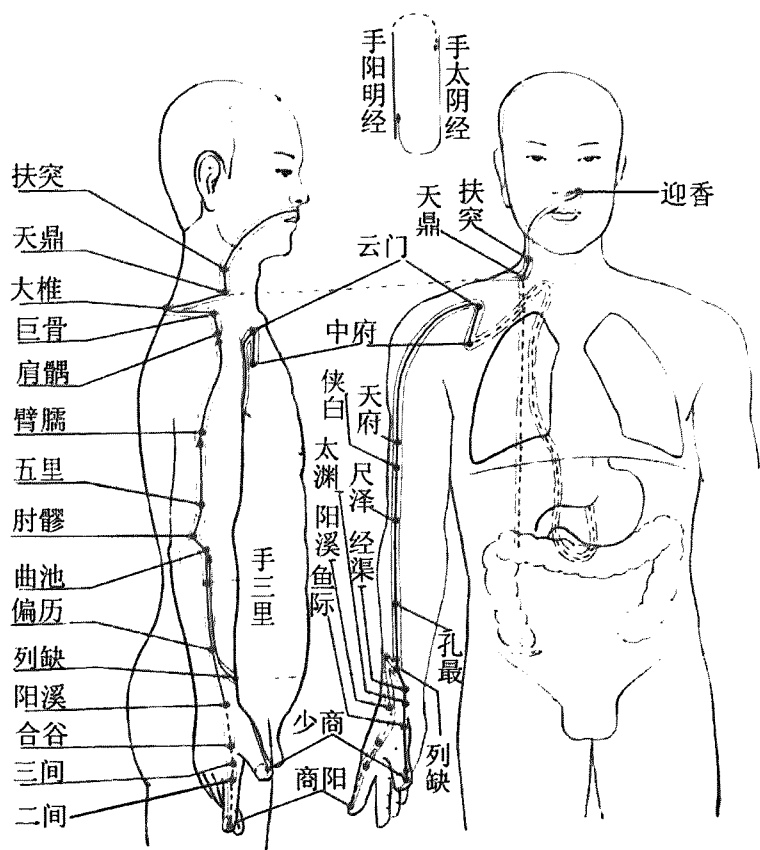
行时，该经气从丰隆之别穴而入。(图五)



图五 足阳明胃经正运根溜注入图



当手阳明经正运而经气上行时，在手的手阳明经气即由商阳穴处退缩而上溜流于合谷穴，继续向上注于阳溪穴；同时在颈部的手阳明经气即由扶突穴处向上运行至迎香穴而终；与此同时，还分支一道经气别行而进入扶突穴内。进入扶突穴的别行经气又进入何处呢？是经过扶突穴入喉咙至缺盆与手太阴肺经的循喉咙之脉相吻合，即形成如环无端的阴阳交合机能。（图六）

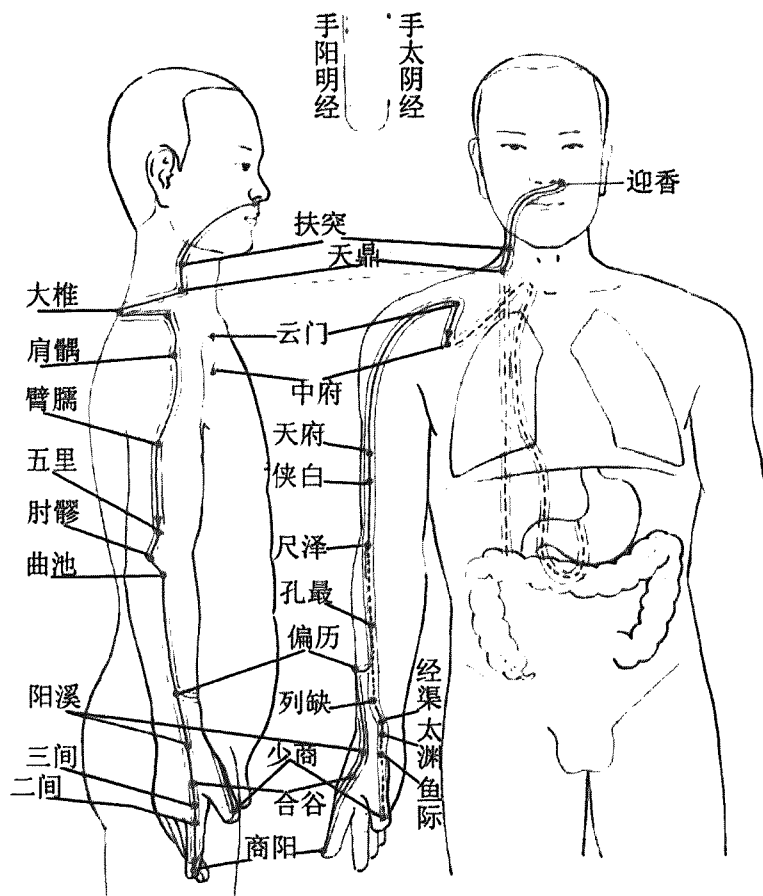


图六 手阳明经与手太阴经正运图

当手阳明经负运而经气下行时，在头部的手阳明经气由迎香穴向下运行至扶突穴处；同时在手部的手阳明经气即从阳溪穴向下运行至商阳穴而止；与此同时，还分支一道经气由偏历别穴而进入手



太阴经与之相吻合，即形成如环无端的阴阳交合机能。（图七）



图七 手阳明经与手太阴经负运图

《灵枢·根结》云“手阳明根于商阳，溜于合谷，注于阳溪，入于扶突、偏历也”，所谓“入于扶突、偏历也”，是言手阳明经根溜注入正运上行时该经气由扶突别穴转入手太阴肺经，负运下行时该经气从偏历别穴而转入手太阴肺经。在阴经经气退缩的同时，其阳经的经气来占领；在阳经经气退缩的同时，其阴经的经气来占领；也就形成了阴消阳长、阳消阴长的循环不息功能，手足三阴三阳的十二经脉就这样如环无端往返不息地运行着。



《灵枢·官能》曾云“明于五输，徐疾所在，屈伸出入，皆有条理”，故此章之根溜注入的阴阳、出入、升降、屈伸条理是十分重要的，学习经络者当心领神会。

根据手足三阴三阳之肘膝以下的阴阳、进退、伸缩机能，可证明肘膝以下之井、荥、输、经、合之五处穴位调治疾病是非常重要的。应当注意，十二经脉路线及穴位是固定不移的，但各阴阳经脉的经气是有规律地升降、出入而上下运输，以灌注阴阳机能的交合，因而为医者当诊察这灵活往返的阴阳经气，从而随机应变、合情合理地调治。

第四节 解释经脉生理矛盾

贫道所发现的人体内左右、阴阳、正负、升降灵活往返的机能机理，能够合理解释经脉生理的矛盾。如果切除了脏、腑和四肢，那么切断之处就为阴阳出入的止点，依然合理地进行着阴阳经气的交接，待伤口愈合后更能正常地运行阴阳经气的交接，如此才能有生命的存在，这也解释了《灵枢·经脉》人体生理机能的矛盾问题。

第五节 一隅三反得十二经脉全璧

根据前面足阳明经与手阳明经根溜注入的运行机理，结合研究《灵枢·根结》之原文，再来一隅而三反之，才能获得十二经脉的全璧。

经曰“足阳明根于厉兑，溜于冲阳，注于下陵，入于人迎、丰隆也”，按这句经语来研究分析，实际上只说出了足阳明经在负运



上行之时，其经气由人迎别穴而入内，可是并没有说出足阳明经在正运下行之时，其经气由丰隆别穴内入，只以一句上下文不相衔接的句词“丰隆也”而了之；更没有说出正当足阳明经气负运上行的同时，与其相配合阴阳运行的足太阴脾经此时正在负运下行至隐白穴而止；与此同时，还分支一道经气由公孙之别穴外出交会于足阳明胃经。以上还只说出了此一侧的足阳明经与足太阴经的运行规律，同时还要了解到彼一侧足阳明经与足太阴经的运行规律，却与此侧相反。因此，当一隅而三反之，才能获得各阴阳经脉之左右两侧的完整机理。古圣人对十二经脉之内在的正负运行机理非常保密，仅只说出了一隅之词。贫道若不是在功态中发现本体之左右、正负的经脉运行，也难以悟出左右四肢阴阳对立的经脉正负运行机理之真谛，此是中医学中最玄奥高深的道理，亦是将来促进中医升华的理论之一。

附：治疗厥逆病证的典型病例

患者：黄某某，男，69岁，武当人。

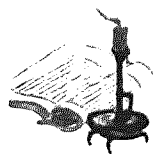
症状：患者于1996年1月20日早上就发病，昏厥休克，手紧，牙紧，小便自遗失禁，急救复苏，经用西药、输液治疗一星期无效后转送我处诊治。其前额两旁头痛头昏，心烦上气，面目浮肿，小便频数，膝以下至足寒冷，小腿悸动，酸软无力，饮食极少，每日下午不能进食并痰涎上冒发生呕吐。

脉候：两脉口脉沉，关、尺部有脉而寸部无脉，负运时两尺部的脉波显然，正运时两关部的脉波衰于两尺部脉波。两人迎脉浮，见三倍宽度的盛大脉象，特别是寸部盛大搏指，显上宽下窄脉象。

治疗：脉、证综合诊断为足阳明胃经厥逆症。厥逆症的病机病理比较复杂，主要由表里、阴阳升降失调而形成。厥逆病辨证，一定要联系十二经脉的正负运行规律，才能辨清阴阳机能失调的内



因。《素问·厥论》曰“阳气盛于上，则下气重上而邪气逆，逆则阳气乱，阳气乱则不知人也”，该患者足阳明胃经产生厥逆上盛，主要是因为足阳明胃经的负运机能过盛，加上足太阴脾经的负运机能盛过正运机能所致，即是相表里的阴阳经气升降失调，阴阳两方面之“机能并凑”所形成的厥逆病机。因为当足太阴脾经负运行时，脾经的经气由公孙别穴输出而入于胃经超量，又因足阳明胃经负运太强，故足太阴的经气合并着足阳明的经气上逆而厥。何谓“阳气盛于上，则下气重上而邪气逆”呢？此有二义：①“阳气盛于上”是指足阳明经既成厥逆，其上气必盛；②“则下气重上而邪气逆”是指上面所说的，足太阴脾经负运之反冲经气，又合并着足阳明胃经的负运经气上行，故曰“阳气盛于上，则下气重上而邪气逆”。由于“阳气盛于上”，故患者才产生头痛、昏厥、吐逆、面肿、烦心等上盛症状。根据患者两脉口的负运脉波盛于正运脉波，就证明足太阴脾经在正运行时缺少能量。脾土正运不足，则升清之功用不及，即统摄失职并形成反馈机能，故导致患者小便频数，这是脾经正运不足造成的不良反应。但足太阴脾经在负运行时能量有余，可间接地测知足太阴脾经之足部的公孙别穴是常开放着而未关闭，故使足太阴的经气从公孙别穴外输过量，并占领了足阳明经之膝以下的经脉路线，才导致该患者的下肢寒冷。《素问·厥论》云“故阴气胜，则从五指至膝上寒，其寒也，不从外，皆从内也”，这说明厥逆病证如阴气太盛，则引起从足部五趾至膝上寒冷，并又进一步说明，这从足至膝之寒冷感的由来，并不是因外界侵入的寒凉之气，而是从相表里的阴经之内所转运出来的阴寒之气，此即是患者下肢寒冷的原因。由于患者的足阳明经既形成厥逆，故在负运行中易于充盛上部，但在正运行中却不能够向下运行至足，而只能向下运行至膝关节部而还回（因此处被足太阴脾经负运外出过盛的阴



寒之气所占领)，所以患者的膝以下寒是由阴阳两方促成的。以上说明，足阳明的经气不能够下运至足而至膝已还，是因为足阳明经的丰隆别穴是常关闭着未开放，所以足阳明经在正运之时，经气不能由丰隆之别穴输入足太阴经。由于足阳明胃经的温热不能够向下转入足太阴脾经以行阳气，即导致足太阴脾经金属一般的阴寒之气，故经云“其寒也，不从外，皆从内也”。厥逆病证不但只是与相表里的阴阳升降有关，而且与阴阳经脉的别穴之处也是非常有关的，故患者的下肢寒冷是多种原因形成的，以上是各种原因造成厥逆病证的病机病理。《灵枢·终始》曾云“刺寒厥者，二阳一阴”，说明应取足阳明经 2 穴、足太阴经 1 穴。针刺足阳明经以丰隆、冲阳、陷谷、内庭 4 穴轮换，每次选取 2 穴；足太阴经以地机、阴陵泉、血海 3 穴轮换，每次选取 1 穴。约 5 分钟行针 1 次，留针时间以针感得气有明显感应时出针。针疗后静息 10 分钟，复查患者两脉口的脉波有增，但两人迎之寸部的动脉还较旺盛，故再次用针刺法取左右人迎穴泻之。如以上针刺法治疗 5 次，患者的呕吐止，饮食增加，其他各症均减一半。经 5 次针疗调治后，由于诊察患者两脉口的寸部已出现脉搏，诊察两人迎的寸部旺盛脉力已减，故第 6 次用针治疗，只取足阳明经 2 穴、足太阴经 1 穴，取穴留针方法同上，共用针刺治疗 9 次而诸症痊愈。复查患者两脉口与两人迎的动脉显象，其左右阴阳脉波的升降往来已达平衡。

体会：笔者未明十二经脉道理之前，对于各经的厥逆病证因症状各异，又不明脉诊脉口与人迎的阴阳动脉差别，故对厥逆病证的诊疗难以做到准确。后理解了十二经别穴处之阴阳经气相互交换的机能道理，又结合《内经》对厥逆病的诊疗规则作指导，始能对厥逆病证取得疗效。诊疗十二经脉的厥逆病证，必须深明阴阳经脉的正负运行开阖道理，才能按照阴阳经脉升降不平的机理给予施治。



此类病证甚多，如果治疗取穴与阴阳机理相反，就容易产生医疗事故。足三阳厥逆多为寒厥，足三阴厥逆多为热厥。热厥的脉象，两脉口寸部浮盛而尺部虚；寒厥的脉象，两人迎寸部浮盛而尺部虚。还有因人的病证各异，可出现左右、阴阳脉象的不同差别。治疗厥逆病证，应如以上对足阳明经之厥逆病的取穴原则：应选择足阳明经之丰隆别穴以下穴位，不可超越丰隆穴以上取穴，最适宜的取穴位置以内庭、陷谷穴为好。因为内庭与陷谷二穴低于足太阴经之公孙别穴的水平线，所以能导引足阳明经气下降以封闭足太阴经的公孙别穴，从而能阻止足太阴经气过量地从公孙别穴输出而入于足阳明经，并可促成足阳明经气由丰隆别穴输入足太阴经。但是，选取足太阴经的一穴，必须要高于丰隆别穴的水平线，才能够导引足阳明经气由丰隆别穴输入以补充足太阴经的正运上达机能。经曰“刺寒厥者，留针反为热”，因遵从古圣的治疗原则，所以此患者膝以下寒冷的足阳明厥逆病证，经9次留针调治由寒转温而愈。如果属于寒厥太甚的病证，还需要采取火灸调治。久病厥逆头痛会形成上盛血瘀，还应放出瘀血后，再给予调平阴阳。凡属厥逆病机，必现上盛下虚。如阴经厥逆于上，阳经必沉坠于下；若阳经厥逆于上，阴经必沉坠于下。无论阳厥、阴厥，全属阴阳两性偏盛偏衰的升降不平运动所形成。经云“阳在外，阴之使也；阴在内，阳之守也”，厥逆病因是外阳内阴的“使”“守”失调，所以必须将表里、阴阳的运行机能调归正道，厥逆的病证才能得到痊愈。



第四章 十二经筋与十二经脉

人体十二经筋是附属十二经脉的筋肉，由有形质的类似条索状的组织所组成。十二经筋的分布路线大致与十二经脉路线相同，遍及人体的前后、左右和头面、四肢，十二经筋共合起来即成为一个完整的人体筋肉组织。所不同的是，十二经筋组织不进入脏腑，只显示在人的体表，犹如房屋的外围墙壁的组成部分，而未涉及墙壁之内的脏腑组织。但十二经筋亦与体内的脏腑有同气相感的联系，能供十二经脉的正负运行以贯通阴阳。十二经筋依靠十二经脉的往来经气濡养，例如属足太阳经筋和分支经筋的分布路线，全由足太阳经的往返经气与一部分足少阴经气流注其中濡养，其他的经筋所受经气濡养亦相同。

十二经筋与十二经脉的关系，若以有形的沟渠相比喻分三种类型：

一、经脉中往来运行的经气似渠中之流水（流水应想象成无形的，因经脉的经气是无形的）。

二、经脉路线似渠道里水层下面的沟槽。

三、十二经筋则似有形质的渠道里的边岸。有形的边岸是固定不移的，十二经筋在人体上也是固定不移的。由于十二经筋“热则纵缓”为病较少，但遭受“寒湿侵袭”受病甚多，所以《灵枢·经筋》将人体十二经筋分配在一年四季的十二个月之中。如在某月内遭受了“风寒湿邪”的侵袭，引起某道经筋路线固定的段落拘急疼痛，多为寒邪阻滞，不通则痛。凡出现条索状拘急牵掣性疼痛，多



为十二经筋受病，宜采取温热燔针治疗。当以局部的疼痛重点为火针取治的阿是穴范围，并可采取药物温熨法，或采用现代的电疗传热等方法，都能取得疗效，不过用火针直接刺激温热甚强，疗效显著，将来也许会逐步被电传热和激光传热取代。

附：经筋受寒的典型病例

患者：陈某某，男，56岁，搬运工人，于1994年9月13日就诊。

症状：右肩膀外侧患牵掣性疼痛，活动受限，不能上举后伸，疼痛重点在于肩与曲池穴处。

脉候：左右阴阳的动脉较平，唯右人迎动脉出现紧象，诊断为手阳明的经筋受寒而病。

治疗：取棉布裹针上浸菜油燃烧，用快速手法燔针劫刺患者的牵掣痛点，主要取刺曲池与肩髃穴处。经2次用火针劫刺治疗后，患者的右肩膀痛止，并运用自如而愈。



第五章 十二经络与十二经别

《灵枢·脉度》云“经脉为里，支而横者为络，络之别者为孙”，由此说明络脉是从经脉分出，再由络脉又分出无数的细支名为孙络。

《灵枢·经别》中论有十五别络：即手太阴之别列缺、手少阴之别通里、手心主之别内关、手太阳之别支正、手阳明之别偏历、手少阳之别外关、足太阳之别飞扬、足阳明之别丰隆、足少阳之别光明、足太阴之别公孙、足少阴之别大钟、足厥阴之别蠡沟、任脉之别尾翳、督脉之别长强，另有脾之大络大包，共合为 15 道别络。

所谓别络者，即有旁出之意，是正经脉的一道分支，是维系十二经脉阴阳经气交换滋养，使阴阳相互平衡的重要途径，犹如运输线只有宽广的大道来输送是不够的，还需要一些分支出的小道予以弥补不足，才能循环输送畅通无阻。十五络脉再分出无数孙络遍布周身，共同组成一个整体的经络系统，通过十二经脉正负运行机能的推动，使人体的气血有节奏规律地循环而传、注、周流灌溉全身。人体的络脉比较浮浅，在体表可以见到。《灵枢·经别》曰“经脉者常不可见也……脉之见者皆络脉也”，又曰“诸脉之浮而常见者，皆络脉也”，故凡从体表能见到的皆是络脉。

由于络脉是血液周流的通道，故对络脉的虚实现象可以从外观上诊断出来。《灵枢·经别》云“凡此十五络者，实则必见，虚则必下”，由此说明络脉的实证是血壅血瘀使血液循环受阻，故在体表可能见到，特别是在四肢部位易于见到络脉显露的结滞瘀血现



象；络脉的虚证为络脉内的血液不足，其络脉空虚而血液循环亦差，故络脉必然显得虚软下萎，在皮肤的表面就不易见到。

治疗络脉的实证，可用三棱针点刺络脉的结处（即特别突出外表的紫黑点）放血，使黑色的血液流出，如出血转变为红色时停止。如出血不止可用酒精棉球按压针孔其血即止，体弱者当少量出血隔两日再放，以防出血量多而发昏，可用3~5次酌情放血处治为宜。

治疗络脉的虚证，应该用药物补血活络治疗较好。如用经络疗法当采用温灸法，或采用传热疗法及药物温熨法为宜。凡是在腰部和手足四肢之处患有风寒湿痹的疼痛，或者跌打损伤的疼痛，若经久治不愈应检查四肢处络脉有无阻塞现象。

附：治疗络脉瘀阻的典型病例

患者：贫道的一位陈姓师兄，男，54岁，住山东泰山碧霞祠。1987年6月下旬因跌倒摔伤了右臀部，数天后病情逐日加重发生右臀、右腿及坐骨神经疼痛，到泰安市中西医院用西药、电疗、中药、针灸、按摩、牵拉理疗等医治，历经7个月有余皆无疗效，并且日趋严重，行动困难，两腋难离双拐。1988年2月7日赴泰安初诊，院方同意贫道在该医院给陈师兄治疗，并提供患者所需要的药品及入院以来的病历给贫道参考。

症状：上半身温和易出汗，右下肢寒冷胀痛，并牵连腹股沟冲门穴处亦痛，患者的饮食及大小便均正常，说明脏腑无病。从外观检查发现，患者之右腿的委中与丰隆穴处均有紫黑色的络脉瘀阻显露。

脉候：阴阳四处的脉象多比较和平，唯独右人迎的尺脉沉而有力。

治疗：经云“实则必见，虚则必下”，可证明是络脉充实瘀塞。



用三棱针点刺紫黑点络脉放血治疗，当针眼血出自行停止时，即采用中指与大拇指扣成环状努力用中指弹针眼3~5下，血即能再行流出。4天内4次放出紫黑色血液，后见血转变红色之时停止放血治疗。经放血治疗后，复查患者的右人迎动脉，变为寸浮尺弱，患者各处的疼痛大减，行动时能不需要左侧腋下的拐杖。后改用针刺疗法，取右侧的环跳、足三里、昆仑、解溪等穴以导引足三阳的经气下达，并结合用中药辅助治疗。处方：知母、薏苡仁各18g，黄柏、赤芍、伸筋草各15g，当归、秦艽、炮山甲各12g，地龙、红花、桃仁各9g，以活血行瘀清上焦之热，每天服1剂，分3次服。针药并施，经过7天治疗，患者能不用拐杖行走，在2个星期的调治下病愈，于2月20日出院。

体会：人体的络脉若瘀阻太甚，犹如在流水的沟渠中筑上了一坝，阻挡了血液循环运行的通道，故前人总结经验有“痛者不通”之说。如络脉内血瘀不甚，用活血行瘀的药品能开通瘀塞。若是络脉内血液瘀阻太甚，必当先开通络脉的闭塞，然后调理其阴阳经脉，才能收到良好效果。此病例经过200多天的各种医疗方法都不能生效，贫道仅在短期10多天内给予治疗而愈，可见络脉壅塞的实证，采用络脉放血治疗疗效显著，因此对长期患有疼痛病的患者，应当检查病人的络脉有无阻塞现象。



第六章 奇经八脉与十二经脉

第一节 概 述

贫道对人体经络学研究后认为，人体内的生命机能是由三种力量综合而组成的，即引力、斥力、中和力。人体内的引力与斥力，是由十二经脉的机能运行所产生的作用，人体内的中和力是由奇经八脉的机能运行所产生的作用。

人体内的左右两侧十二经脉机能运行，是由正运行与负运行组成的，正运行能量属扩张性，故称斥力，负运行能量属收缩性，故称引力。当人体左侧的十二经脉在正运行而产生斥力的同时，则人体右侧的十二经脉即负运行而产生出引力；当人体右侧的十二经脉正运行而产生出斥力的同时，则人体左侧的十二经脉即负运行而产生出引力；但是在斥力的尽头随即转化为引力，在引力的尽头随即转化为斥力。人体之内的引力与斥力，是在左右、正负灵活轮换交替和无止息地运行。

人体内中和力的发源处是奇经八脉，即任脉、督脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。当贫道进入胎息功态之时，感觉身体前后中线的任、督二脉都在运行，特别感觉到任脉、督脉是由两条经脉相合并在一起的结构，亦是左右各别的升降往返运行。可是在历代的医书著作所传承下来的《奇经八脉图》中，冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉等六脉在人体上都有



两条经脉而分布于左右两侧，但是任脉与督脉在人体的中线均是独一无二的一条经脉，谁知是由两条经脉相合并的，这犹如现代在一条橡胶线中包裹着两根导电丝的情况一样。此后，考察任脉是起于人体的中极之下，督脉是起于人体少腹以下的骨中央，但任、督二脉循行之后皆终止于两目之下。根据这两目之下的两道分支经脉线，便可充分证明任、督二脉确实是由两条经脉相合并为一的，也是发挥左右各自不同的升降、往返机能。但是任脉属阴，却与足三阴经的运行机能相反；督脉属阳，却与足三阳经的运行机能相反。当人体左侧之足三阳经的经气在负运上升的同时，左侧的督脉便运行下降；当人体左侧足三阳经的经气在正运下降的同时，左侧的督脉便运行上升。人体右侧之足三阳经的经气及右侧督脉的升降、往返运行，亦与左侧相同。当人体右侧之足三阴经的经气在正运上升的同时，右侧的任脉便运行下降；当人体右侧之足三阴经的经气在负运下降的同时，右侧的任脉便运行上升。人体左侧之足三阴经及左侧任脉的升降、往返运行，亦与右侧相同。由此证明，人体左右两侧之足三阳与足三阴以及人体左右两侧之任督二脉的升降、往返运行，均是由相反而组合成相成的运行机能。

由于任督二脉，在人体前后的中线，贫道在功态中易感觉出它的动态。人体的冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉等，都分布在人体左右的十二经脉的路线上，因而受左右两侧之十二经脉的升降运行机能所混淆，难以体证辨清这六条奇经的升降运行机能的规律，有待将来医科的研究。

为什么说奇经八脉是人体之内的中和力呢？我们中国有儒、释、道三教，具有数千年的历史，儒、释、道三教在修身炼性中流传有很多宝贵的经验，综合在修行炼道的原则上，各教都特别注重在人体任、督二脉路线上下工夫。练通小周天的功夫，必须要练通



体后督脉路线上的尾闾、命门、玉枕穴三关，督脉路线的上丹田，以及任脉路线上的中丹田、下丹田。如儒教在修身的原则上，注重意守中道。又如佛教在修行中所注重的“慧眼”（天目穴），均是在人体中线任、督二脉上用功。再如道教《丹经》中说意守丹田，提倡“守中道至中和”。诸如上述可证明，奇经八脉是人体内中和力的机能运行。人体内有引力、斥力、中和力的机能运行，宇宙空间也有引力、斥力、中和力的机能运行，因为天是个大宇宙，人是个小宇宙，符合天人合一的自然规律。

人体奇经八脉中唯有任脉、督脉的经脉分布于人体的中线，皆有腧穴可以调治疾病。任脉循行人体胸腹的中线，经云“腹为阴”，人体的任脉为诸阴经脉之海。人体的任脉运行虽然与足三阴经的运行相反，相反的运行却有相助足三阴经的运行之功，所以人体的任脉有担任诸阴经运行的潜能。督脉循行人体背部的中线，经云“背为阳”，故人体的督脉为诸阳经脉之会。人体的督脉运行虽然与足三阳经的运行相反，但相反的机能有相助足三阳经的运行之功，故人体的督脉有总督诸阳经运行的潜能。

再者，人体冲脉起于气街（属足阳明经脉的气冲穴），由足阳明经别出，并着足少阴经夹脐上行至胸中而散，为十二经脉之海。因冲脉发源于足阳明的气冲穴，足阳明胃经是接受生活物质的水谷之海，五脏六腑皆禀受其气，为后天营养全身之根本；并且冲脉又并着足少阴肾经，是储藏先天精气营养周身的根本；所以人体的冲脉受先、后天的二经之经气滋养，经气充沛故为十二经脉之海。但是冲脉借居足少阴肾经的腧穴调治疾病，故奇经八脉除任、督二脉在本经有穴位调治疾病外，其他奇经皆是借居十二经脉的穴位来治病。例如后世发明的“灵龟八法”，立论说“后溪穴通于督脉，列缺穴通于任脉，公孙穴通于冲脉，临泣穴通于带脉，照海穴通于阴



跷脉，申脉穴通于阳跷脉，外关穴通于阳维脉，内关穴通于阴维脉”，这证明奇经八脉全都是借用十二经脉的穴位治病。

第二节 对奇经八脉的治疗分析

用中药治疗奇经八脉的疾病，仅见到前医叶天士先生言“八脉隶于肝肾”，以“龟板、龟胶”为入任脉之药品，以“鹿角、鹿胶”为入督脉之药品，除此之外，很少见到专为奇经八脉立出方药。由于任、督、冲等脉皆起于少腹下与胞中，所以后世医生对于妇科疾病的胎前、产后、月经、崩带以及胞宫生殖等病，虽然常以任、督、冲、带等脉立论很多，但在用中药立方用药上，主要还是调治肝、肾二脏的一些药品。

如以上对奇经八脉的种种观点认为，除任、督二脉外，对其他奇经的调治，若调正了十二经脉，便是调治了奇经八脉。因调治奇经八脉的治病穴位，多属于十二经脉的穴位。

第三节 奇经八脉生长衰老过程

奇经八脉在人体生理中，有它生、长、衰、老的寿命过程。《素问·上古天真论》曰“女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。男子二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和故能有子”，说明女子生长发育大致到14岁时，冲、任两脉发育健全，即开始排卵按月行经。经过35年的寿命过程，一般到49岁，冲、任二脉逐步趋向衰弱，故而导致月经停止，同时生育子女的功能亦消失。男子生长发育到16岁时，肾脏的精气充盈即能开始排精，如男女媾和即能生殖子女。经过48年的寿命过程到达64岁时，肾脏的



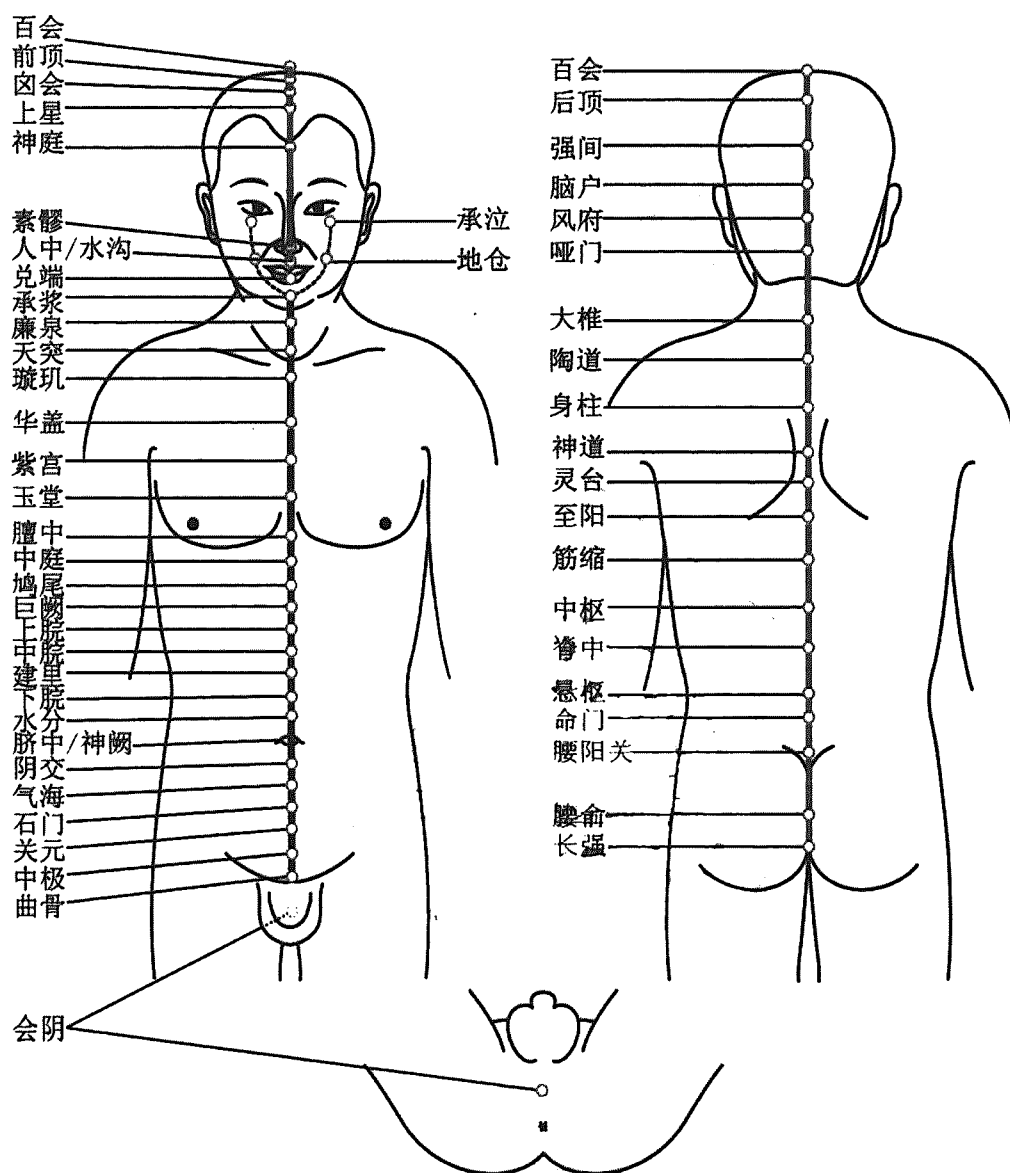
精气即趋向衰弱，因而断绝繁殖儿女的功能。

在人体之生、长、衰、老的生理过程中，正当冲、任二脉的旺盛之期，奇经八脉皆旺盛；当冲、任二脉的衰弱之期，奇经八脉皆衰弱，故奇经八脉有它的生理寿命过程。奇经八脉在人体未发育健全之前、精气衰弱及断月经之后，运行功能都是存在着，前者是起着生长不足的中和力运行反作用，后者起着衰退不足的中和力运行反作用。亦如《灵枢·营卫生会》黄帝问于岐伯曰：“老人之不夜瞑者，何气使然？少壮之人不昼瞑者，何气使然？”岐伯答曰：“壮者之气血盛，其肌肉滑，气道通，荣卫之行，不失其常，故昼精而夜瞑。老者之气血衰，其肌肉枯，气道涩，五脏之气相抟，其营气衰少而卫气内伐，故昼不精，夜不瞑。”所以，奇经八脉在壮年与老年时期是各不相同的盛、衰生理。妇女的行经与断经可证，行月经之期是旺盛的体征，断月经之后是衰老的体征。

《素问·上古天真论》黄帝曰：“夫道者年皆百数，能有子乎？”岐伯曰：“夫道者能却老而全形，身年虽寿，能生子也。”这说明，善于养身修炼之人能够保持延长奇经八脉的寿命。因为修炼者在第一步就是通小周天功，即是通调任、督二脉，如果任、督二脉得到通调相交，即获得健康长寿的有利条件。可喜的是，近些年来修炼气功的热潮遍及全世界，所以在不久的将来，对人体科学研究、对奇经八脉的研究，都会取得一定的进展。

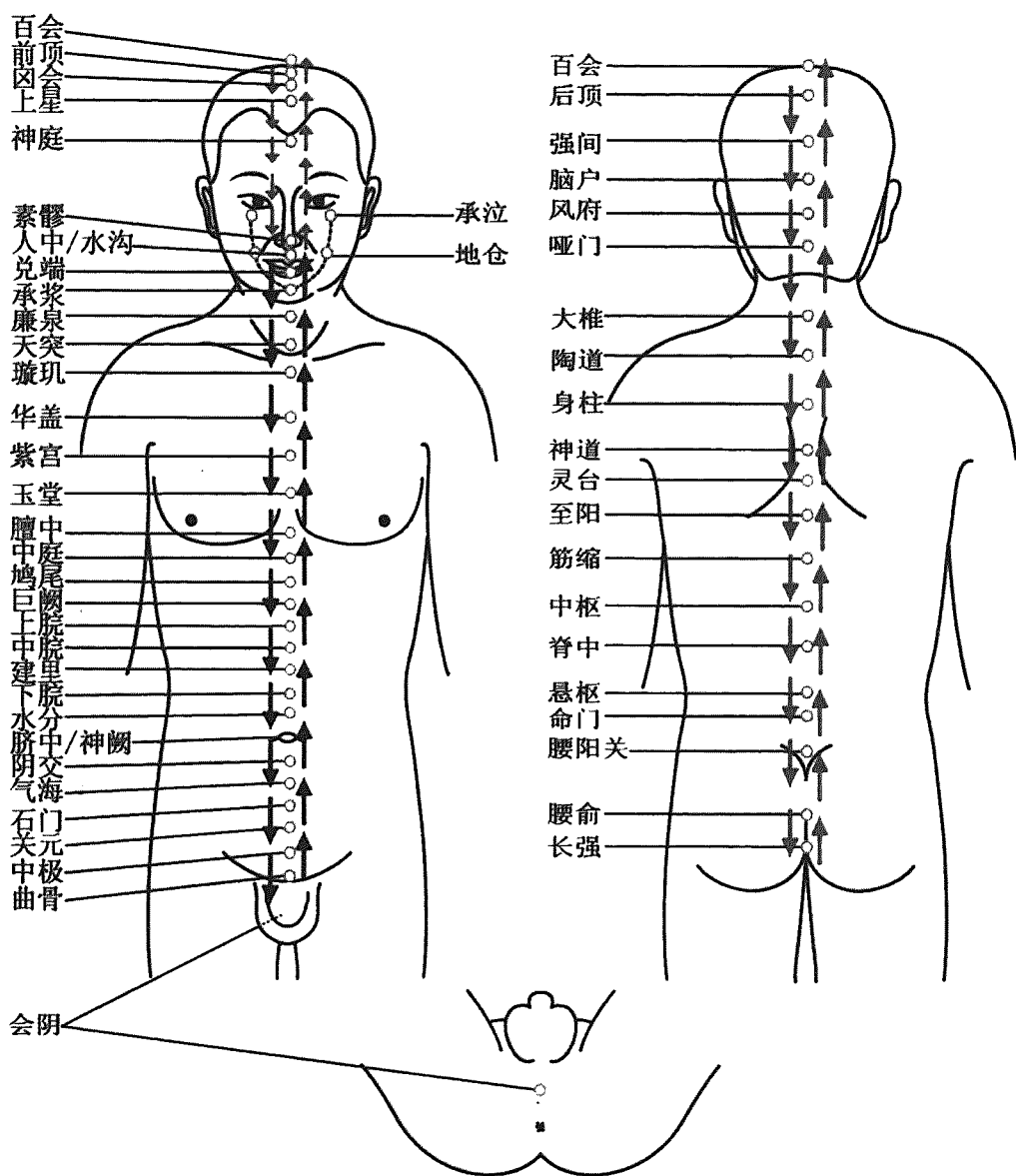
关于十二经脉的循行路线，贫道与古今的观点一致，读者可参考古今针灸书中的十二经脉循行示意图。关于任、督二脉的形态，贫道在功态中的现象感觉却与前人有所不同。因此，特遵照前人立出了传统的任、督二脉示意图，并又立出贫道在功态中感觉的任、督二脉示意图，以供研究考证。（图八、图九）

如果奇经八脉患病，各有特殊性的病证表现。如：任脉为病，



图八 传统的任、督二脉运行示意图

男子内结七疝，女子带下瘕聚；督脉为病，脊强反折；冲脉为病，逆气里急；带脉为病，腹满，腰溶溶若坐水中；阳维为病，苦寒热；阴维为病，苦心痛；阳跷为病，阴缓而阳急；阴跷为病，阳缓而阴急；等等症状都必须联系起来归类分析，并根据诊察左右、阴



图九 功态中感觉的任、督二脉运行示意图

阳、上下、盛衰动脉的现象，拟定出调治左右阴阳经脉的治疗方案。



附1：在任脉穴位用药物治疗的典型病例一

患者：毛某某，男，78岁，住武当山，于1997年4月15日就诊。

症状：患者陡然发生腹痛甚剧，四肢寒凉，面色惨白，咬牙紧齿，痛苦呻吟不止，舌质淡红苔白润，并出现呕吐。

脉候：左右脉口浮候无脉，沉候两寸部亦无脉，左右关、尺两部脉象沉迟而小，脉搏极弱；左右人迎动脉均现浮小兼迟之象，能感觉动脉的往来，但比较两脉口之脉搏略微明显。

治疗：凭脉据症诊断为，体内的阳气衰微，无热能化阴，从而致使阴寒之气太甚，寒主收引即形成痉挛性腹痛剧烈。因发病急迫，采用西药穴位注射治疗。用5ml注射器吸取硫酸阿托品0.6mg，又吸取盐酸肾上腺素1mg混合后，分别在患者的关元、气海穴刺入三分注入二分之一药液。经注射药液达15分钟后，患者的腹痛好转大半，仅只有轻度的腹痛。复查患者左右脉口、人迎动脉，阴阳双方的脉搏明显增强，迟脉象消失，但两脉口的寸部脉波还显不足之象，两人迎的寸部还显浮象。另用肌苷0.1mg 2片，维生素B₁ 10mg 3片，醋酸泼尼松5mg 2片，维生素B₆ 10mg 2片，胃复安5mg 2片给患者口服，在服药45分钟后痊愈。

体会：奇经八脉中的任脉乃是诸阴经之海，而任脉的关元穴又是足三阴经的交会之穴，任脉的气海穴乃禀受呼吸气机之海底根蒂处，我们道家在修养中亦提倡关元、气海为呼吸归根之处，所以贫道选取这2个穴位用药物注射以治疗阴寒急症。因借此二穴特点能使药物在阴经方面来迅速发挥药物作用，令阳气升举，在短时间以内消除阴寒之邪，所以获效甚捷。以前，贫道常用如上配方，选取气海与左右阴陵泉的三穴注射，救人甚多。阴陵泉穴属于脾经，脾胃乃后天之本，故补充此经能激发后天生命的活力，与气海穴二者



综合，能获得立竿见影之效。但以上疗法只适用于阴寒腹痛急症，如属于炎症腹痛者忌用。《灵枢·根结》云“用针之要，在于知调阴与阳，调阴与阳，精气乃光，合形与气，使神内藏”，人体患病，阳盛则热，阴盛则寒，医生治病原则在于胸有定见地知道调整患者的阴经与阳经的寒热、虚实，如能调整患者之体内的阴阳趋向和平，便能使患者的神机和灵机内藏，精气光明而康复。

附 2：在任脉穴位用药物治疗的典型病例二

患者：杨某某，女，41 岁，武当山道教协会成员，于 2006 年 10 月 10 日就诊。

症状：患者有痛经史，上午 9 点多起病急骤，脐下小腹突然发生痉挛性腹痛，并头昏眼花，恶心呕吐。贫道赶到时见患者四肢发凉，牙关咬紧，全身震弹，呻吟不已。

脉候：患者两手的动脉感觉不到脉搏，当贫道再查人迎动脉时，患者之全身震弹及呻吟声忽然停止，只见患者的白眼上吊，戴眼而欲闭，随之昏厥不省人事。

治疗：在这危急之际，去医院约有 25 千米，根本来不及送医院，唯有采取急救措施，使用西药在穴位上注射以抢救。用 5ml 注射器吸取盐酸肾上腺素 1ml 1mg、盐酸消旋山莨菪碱 1ml 10mg、地塞米松磷酸钠 2ml 10mg，将药液混合注射关元、气海穴各 1ml，再注射左右阴陵泉穴各 1ml。此时患者的脉搏已无，证明患者的心脏功能衰竭，患者的生理机能运行已微乎其微。随即又采取温水浸毛巾拧干后热敷以上注射的 4 个穴位，想借毛巾的温热以促进药物迅速发挥作用，大约 6~7 分钟后，患者咬着牙闷哼了一声，才见她的面容逐渐向好的方面转化，此时患者的脉口已出现微弱脉搏，又采用“神灯照”温照患者的腹部。在注射 10 分钟后，患者说口干要喝水，这是注射山莨菪碱发挥了作用的缘故。一来给患者饮少量温



水，二来诊患者两手的动脉，患者此时的两脉口已出现了明显的脉搏，可证明所注射的肾上腺素及地塞米松已发挥了作用。问患者有心跳加速否，患者答道不觉得，往常注射肾上腺素以后患者均有心跳加速的药物反应。贫道治疗此病幸有患者的姐妹在场，经过40多分钟的抢救，患者才转危为安而愈。

体会：在抢救此患者时，要不是患者的两位亲属在场做主，贫道定不敢轻易动手，由于贫道多年以来利用十二经脉的机能机理，在临床中救治了很多急症病，所以有一点经验。贫道在临床上取得的成果，全是靠十二经脉的机理作方向盘，在急救危症时唯有背水一战。



第七章 五脏六腑与十二经脉

第一节 十二经脉的运行机能

十二经脉的运行机能即是脏腑五行的运行规律。

针灸与按摩治病的理论指导，全依靠调整人体的十二经脉。十二经脉的理论出自于《灵枢》，如仔细研究《灵枢》之书名意思，我们可以得知《灵枢》是古圣人指示我们人体之内均有一个无形无象的灵魂枢纽，这一枢纽主导着人体阴阳运行的机能。这“灵”字可以说是灵机、灵气、灵能、灵动、灵魂，这“枢”字可以说是人体生命之左右、上下、内外、阴阳最重要的核心枢纽。综上所述，每个人体内均有由金、木、水、火、土阴阳五行所组成的一个无形无象之灵魂运行结构，出入、升降循环不已。全世界的五大宗教都说我们人体之内有一个灵魂存在，所以调治人体的十二经脉便是调整到了灵魂层面，故疗效非凡。据贫道平生钻研经络学认为，宇宙是个大宇宙，人体是个小宇宙，人体全依赖十二经脉与大宇宙之金、木、水、火、土的大能量互通。如果人体的十二经脉不平，人即患病；医者调平了十二经脉，人体便可与宇宙的大能量同步共振而身体健康，才能天人相应甚至合一。由此说明，人体十二经脉机能机理才是最高最理想的医学理论之一。我们祖国中医学的经络学理论，可促进将来中西医学走向至高无上的诊疗原则，所以医学界的人士应当认真研究开拓，才能使人体十二经脉理论逐步地发展上



进，从而为人类的健康事业作出贡献。

人体内十二经脉之左右上下的阴阳升降机能运行平衡，人即健康；人体内之左右上下内外阴阳的灵枢机能的升降运行失去平衡，人即生病。医者采取各种医疗方法，若调正了人体内的阴阳，使其达到平衡状态，患者的疾病即告痊愈。如果人体内十二经脉的灵魂机能组织结构脱离了形体，人即死亡。五大宗教的信徒之灵修者，如果虔诚精勤地修心养性，都可以将身体内的金、木、水、火、土五行之无形无象十二经脉的灵魂神气提炼升华与道合真，甚至可以出神入化，从而成仙、成佛、成祖、成圣。

虽然数千年以来，人体十二经脉的机能机理一直指导着中医们在临床中治疗疾病，但由于对人体十二经脉机理的真相未明，因而导致中医的诊疗水平不能达到高层次。在当前中医门派百花齐放、学术百家争鸣、理论层出不穷的年代里，对人体之内最核心最本原的十二经脉之机能机理的研究工作，确实非常的神圣而且至关重要。

人体十二经脉的机能运行，即是阴阳五行之金、木、水、火、土的机能运行，亦是人体内之五脏六腑的机能运行，所以是人体内至关重要的生命生理机能。从古至今的明医先哲们说“中医在临床上诊疗疾病，是利用望、闻、问、切四诊，分阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八纲，按阴阳五行的偏盛偏衰，从整体辨证观点施治”，这是中医在临床诊疗上的总结，多以为是十分精当无遗漏的结论。但贫道认为，如果未弄清楚人体内阴阳五行之正常的运行机理，当人体患病时，在临床上怎能做到随机应变、有的放矢地去调整那些不正常的运行偏差呢？这是当前中医界面临的至关重要的一个问题，也是当前中医进程中急需解决的问题。因此，必须弄清人体之内十二经脉的机能机理才能开拓上进。这是中医进化升华之纲



领性的问题，纲举才能目张，纲不举则目不张矣！

对人体十二经脉的研究，是当今医学攻关的课题。人体内十二经脉的运行机能无形无象，即使利用现代高科技仪器亦难测出它的全貌，所以十二经脉在人体内有能量无形象，是隐形的生命机能，这个能量是人体之内唯一的生命活力。如果人体之内十二经脉的机能停息，人即死亡，故十二经脉是非常重要的。现代医学用解剖手段所观察到人体的各组织、脏腑器官以及皮、肉、筋、骨和一切细胞组织等等，均是有形有象的人体生理组织；而中医学中所论述人体内之十二经脉的灵机运行，是一种无形无象的能量运行。在此举例说明：如果将人体比作一辆汽车，现代医学通过医科仪器观察到人体的各器官、组织等，仅仅只明白了这部汽车的各式各样的零件结构；然而我们中医学所论述的人体内之十二经脉的运行机能，相当于这部汽车在开动时所释放能量的节奏机能和运行规律。如果这部汽车不能够起动，便是几块死铁；一个人如果失去了十二经脉的机能运行，就是个死人。因此谁轻、谁重、谁是本、谁是标，明智者可定矣。故贫道认为，调治人体的十二经脉才是治病救人的唯一治本措施，否则难免失误。明代的中医马元台说“此言十二经脉……实学者习医之第一要义，不可不究心熟玩也。后世能言不识十二经络，开口动手便错”，这说明中医钻研十二经脉的道理十分重要。

在《灵枢》和《素问》中记载有人体手足之三阴三阳的经脉路线及其穴位，并记载有奇经八脉的路线及其特性生理结构等，因此导致从古到今的医者源源不绝地用针灸和按摩推拿治病。但贫道认为，在远古时代利用针灸和按摩治病是据经典中的要求，均是采取诊察脉口、人迎之阴、阳经脉的盛衰而调整疾病，根据阴阳盛衰的太过与不及，随机应变、有的放矢地采取或补或泻的方法，调和人



体内的阴阳经脉。但后世以来，可能因十二经脉之运行的机理失传，再加上对人迎脉诊失传不察，由此便失去了针灸的治病纲领，从而导致后世的针灸家们对某类疾病的治疗经验，都注重研究特效穴位，例如“肚腹三里留，腰背委中求，头项寻列缺，颜面合谷收”，再如《标幽赋》《金针赋》《席弘赋》《玉龙歌》以及《天星十二决》等，均是突出地采用经验穴位组方立法治病，后世以来的针灸医者都采取经验穴位疗病，遗失了人体十二经脉之生理机能的总纲。因为人体的阴阳十二经脉是宏观生理运行的机制，各经脉路线上的穴位是微观生理的效应，所以应该将宏观建立在微观之上，才能取得胸有定见、纲举目张的良好效果。

后世的针灸医生，在临床中各有各的经验穴位组方，但是并不相同，真是遵此则失彼，遵彼则失此，这是经验主义扰乱了中医的理性系统。由此认为，针灸医者必须钻研十二经脉的运行机理，才能逐步实践纲举目张的成果。譬如深明电力传导理论的人，可以利用这电力传导规律研制出成千上万各类电器设备，利用这种无形的看不见的电能量为人类的幸福生活服务，利用电发光的能量照亮了全球；但是如果有意或无意地违反了电的规律，或在没绝缘的情况下接触上了火线，其结果便十分不幸，甚至危及生命；故必须以电力传导的理性为纲，才能开创出成千上万的有益人类的电器设备。祖国传统医学的十二经脉的机理，亦是无形无象的能量，类似电能源的系统一样，它虽无形无象却有巨大的能量。例如，用一根小针扎错了穴位，马上就会使病人虚脱或昏迷过去，如果施救不当甚至会危及生命。《灵枢·根结》云“上工平气，中工乱脉，下工绝气危生”，说明上工是根据患者之阴阳、盛衰的脉象，胸有定见地补虚泻实以调平阴阳的经气，中工是从主观经验意识取阴阳经的腧穴治病，扰乱了病者的阴阳经脉，下工是不明阴阳、盛衰的诊



断，甚至会去补实泻虚，将会使患者阴阳经脉机能处于危绝的状态。因此利用针灸穴位治病，必须懂得人体之内十二经脉的机能机理，才能诊断出病人阴阳经脉的虚实现象，才能随机应变、有的放矢、合情合理地施治，才符合纲举目张的理论与实践。

现代西医所观察到人体内的一切生理机能现象，全部是由于人体内之无形无象十二经脉的左右、正负运行机能之震动频率所导致的，这便证明中医理论之十二经脉的活力是本，西医所观察到人体的一切生理现象是标。这好比太空中起风一样，风是一种无形无象的运动能量，是难以看见的，但可以从沙尘的飞扬、起伏的波浪、树枝的摆动测知有风，这便证明太空之中的风是本，而沙尘、波浪、树枝是标。西医所观察到人体内的一切生理现象，即等于是沙尘、波浪、树枝的标，中医理论之无形无象十二经脉的机能运行规律才是中西医学的本中之本。因此想要提高医学理论水平，治愈当今一些疑难杂症，就必须深入研究人体内之本原机理的十二经脉。

第二节 脏阴腑阳互相为用

十二经脉对人体之内的五脏六腑确实有互相为用的机能活动，举足阳明胃经与足太阴脾经为例：足阳明胃经有属胃络脾的别脉，足太阴脾经有属脾络胃的别脉，体内各脏腑之间各有这样的阴阳分支别行络脉，也类似体外四肢的之十二经别穴的结构一样，从而沟通阴阳经气。因胃经和脾经各有两道经脉，一道在于左侧，一道在于右侧。在经脉的运行中，若右侧的足阳明胃经在络脾之时，左侧的足太阴脾经就在络胃；相反，左侧的足阳明胃经在络脾时，右侧的足太阴脾经就在络胃。可见左右阴阳是相对立而不间断的阴阳转化机能，并互相为用，在脏阴腑阳之间就形成了不间断的阴阳生化



之机，故五脏六腑之间及左右经脉运行之间，都是不间断地相互生生化化，正可谓“无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”，体内的脏阴腑阳联系着左右阴阳两性机能，从而保持既对立又统一的阴阳协调关系。

第三节 五脏六腑与十二经别的开阖机能

贫道在功态中发现手足四肢的十二经别穴之处，五脏六腑与十二经别有开放与关闭的机能。其开放关闭的机能，是在四肢的内三阴经脉与外三阳经脉的正负运行中，并通过十二经别穴的灵机进行阴阳经气交换的，故易感觉出来。但是因人体之内的五脏六腑所处的位置分散，贫道对各脏腑的开放与关闭机能，虽然有感却难辨清。根据体外四肢处十二经别的结构与体内五脏六腑之别络的结构相同，再根据手足四肢的内三阴、外三阳之有规律的开放与关闭机能，即能推理以确定五脏六腑的开放与关闭机能。

体外四肢十二经别穴之处，与体内五脏六腑之别络之处，是脏腑阴阳经气相互交换滋养的分支通道，阴阳的经气相交全依靠这开阖机能起作用，亦举足太阴脾经与足阳明胃经及手太阴肺经与手阳明大肠经为例：因为手经和足经的正负开阖性质不同，故应联系手、足的阴阳机理，才能说明完整的手、足阴阳开阖道理。当足太阴脾经正运行之时，正值属脾络胃之脉开放，同时在足部的公孙别穴关闭；脾经负运行时，轮值足部的公孙别穴开放，同时属脾络胃之脉关闭。当足阳明胃经正运行时，轮值下肢的丰隆别穴开放，同时在膈下属胃络脾之脉关闭；胃经在负运行时，轮值膈下属胃络脾之脉开放，同时在下肢的丰隆别穴关闭。当手太阴肺经正运行时，轮值脉口的列缺别穴开放，同时在中焦下络大肠之脉关闭；肺经负



运行时，在中焦下络大肠之脉开放，同时在脉口的列缺别穴关闭。当手阳明大肠经正运行时，在缺盆内的属大肠络肺之脉开放，同时上肢的偏历别穴关闭；大肠经负运行时，上肢的偏历别穴开放，同时在缺盆内的属大肠络肺之脉关闭。

因此，人体阴阳的十二经脉不但联系着外在手足四肢之阴阳别穴的开放与关闭机能，而且又联系着内在五脏六腑之别络的开放与关闭机能。这便阐明了中医理论之一脏一腑的阴阳运行生理机制，并且也阐明了金、木、水、火、土之整体阴阳运行的生理机制，即在人体生理正常的情况下，全是有规律地开放与关闭，从而进行阴、阳经气的交换。正常人的十二经脉之阴阳正负运行，能促使人的整体一切有形质的组织相互协调自如，所以五脏、六腑、皮、肉、筋、骨、阴、阳、气、血皆有规律地轮换交替、灵活往返而各行其道，以适应人体之表里、阴阳的生理联系。

第四节 五脏六腑混元统一论

贫道在前面对五脏六腑分别作了简略的辨证，根据十二经脉是混元统一的阴阳正负机能运行的道理，并结合人体的生理结构，特概述对五脏六腑的混元统一理论认识。

现代医学解剖证明，隶属南方的心脏有左右心房和心室，并形成4个运行血液的器官。贫道认为，北方的肾脏有左右肾脏2枚和左右正副睾丸2枚（妇女有左右卵巢），亦是形成4个以精化气的运行器官，从而形成南北两极遥相对应的人体两极磁场，故人体之内有生物电和磁力场。心为南极的枢机，其作用在于运行血液以循环周身；肾为北极的枢机，其作用在于以精化气而运行周身。心与肾，是南、北方位的直径；肾主冬，心主夏，是子、午方位相对立



的。但是心、肾二脏既是对立的，又是统一的，是相互为用的，经言“苦味入心，咸味入肾”，其入心之苦味能走骨，入肾之咸味能走血，可证明它们是心肾水火相交的。

肝脏属东方木，肺脏属西方金，虽然肝与肺表现有青、白颜色的不同，但肝脏与肺脏的外形是相同的。肝主藏血，肺主藏气，各司运行阳气东升西降以及阴气西升东降的气血周流循环。肝与肺，是东、西方位的横纬；肝主春，肺主秋，是卯、西方位相对立的。但是肝、肺二脏既是对立的，又是统一的，是相互为用的，经言“酸味入肝，辛味入肺”，其入肝之酸味能敛肺，又能补肺，入肺之辛味能疏肝，又能补肝，可证明肝木、肺金是合并的（水、火、金、木达到正常的生理就相合，反常的变态即相克）。

诸如以上所论述的东、西、南、北遥遥相隔而能取得四方共济，全依赖于中宫之脾、胃的转输。例如，我们玄门阴阳八卦的核心是以中土五数为“太极”，道祖太上老君著《道德经》云“多言数穷，不如守中”，即言中土的五数“太极”有协调木、火、金、水的养身功效。这虽然是恬憺虚无修身养性的教导，但为医者也应当利用这混元一体的道理来诊疗疾病，定能取得良效。

南方乃手少阴心火藏神，北方乃足少阴肾水藏精，东方乃足厥阴肝木藏血，西方乃手太阴肺金藏气，这神（火）、精（水）、血、气乃是人体生命的根本。

心与肺相互联系、协同，在上焦起着运行作用；肝与肾相互联系、协同，在下焦起着运行作用。下焦的肝、肾之腑胆与膀胱都是袋囊形状，其功能上济，胆上输胆汁，膀胱化气上蒸。上焦的心、肺之腑大肠和小肠，都是上下通畅，其功能下达，小肠在向下运行中吸收营养，大肠下达排便。中焦的脾胃升清于上，全赖脾阴；降浊于下，皆靠胃阳。三焦化水道行气，以运输左右上、中、下三焦



的周身水气。五脏六腑共合起来配合人体左右手足的三阴三阳正负机能运行，即成为一个混元一体。这说明人体之内阴阳结构的统一性，所以我们祖国医学在诊疗方面不能像西方医学将人体分成几大系统，而是强调用混元统一的整体观点诊疗疾病。



第八章 脉口、人迎对比诊法

第一节 脉诊的诊法

《素问》中论脉诊有三种诊法。①诊察三部九候：分上、中、下，各有天、地、人三部共九候，以确诊疾病在上、中、下何部。②诊察脉口与人迎：以诊候手足三阴三阳经脉的盛衰现象，主要用作针灸和按摩调治十二经脉的诊疗依据。贫道认为，此诊法也可作为药物施治（辨证脏腑阴阳虚实）的诊疗依据。③诊察两手脉口的寸、关、尺三部脉象：主要用作药物治病的依据，可按寸、关、尺的阴阳虚实脉象以调治疾病，后世独诊两脉口而治病的诊断方法即根源于此。《素问·脉要精微论》曰“尺内两傍，则季胁也，尺外以候肾，尺里以候腹。中附上，左外以候肝，内以候鬲；右外以候胃，内以候脾。上附上，右外以候肺，内以候胸中，左外以候心，内以候膻中。前以候前，后以候后。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝胫足中事也”，这说明古圣认识到左右手太阴经脉之脉口部位，可以诊察肝、心、脾、肺、肾等五脏及胃腑的脉象，并将五脏和胃的诊候分配于左右脉口寸、关、尺各部，古圣人以两脉口诊候五脏的虚实也是一种全息论的诊断方法。

两尺部皆属肾，左肾属真水，右肾属真火。左尺部之真水生左关部的肝木，左关部之肝木生左寸部的心火；右尺部之真火生右关部的脾土，右关部之脾土生右寸部的肺金。《素问·脉要精微论》



中对于六腑的诊候只论述了胃腑，并将其诊候分配于右脉口关部，但对大肠、小肠、三焦、胆、膀胱等五腑并未论及，后世的脉学著作则将六腑配属于左右脉口的寸、关、尺各部，此为后世脉学家的立论。

经言“善调尺者不待于寸，善为脉者不待于色”，如将脏腑安排在一个部位来诊断易引起混淆难辨，凡是临床多的医生，皆有自己的诊脉经验，经验丰富的医生不会为脉象所惑，但经验不足的医生就难以分辨清楚。贫道认为，用针灸治病对六腑的脉诊，既然能取察于人迎动脉，用药物治疗亦可取察于人迎动脉，以确诊六腑的虚实，即能按外阳、内阴分清阴阳界限，并符合人体阴阳对立的生理结构，能用阴阳对立辨证以区别阴阳经脉的虚、实、甚、微，从而作出正确诊断，并能取得良好的疗效。

根据贫道多年来在临床中的实践经验，有个别患者的病脉现象与众不同，通过诊察脉口、人迎的四处动脉，也察不出阴阳盛衰现象。如遇到这种难以确诊的情况，就应该利用古圣人所制定的三种诊法，来共同使用以协助脉诊诊断。贫道遇到一个患右侧偏头痛的病人，通过诊候脉口、人迎，皆察不出阴阳、虚实的异常现象，后采用在患者头部察天、地、人三部之脉诊，诊察出患者的右侧之额旁发际处动脉独现旺盛脉波，经针刺右侧的头维、上关穴，用泻针法治愈。又遇到一个患胃部胀满的病人，经过诊察脉口、人迎亦察不出阴阳、盛衰的异常脉象，后采用察足部的趺阳穴动脉，诊察出左右之趺阳动脉现充实搏指的脉波，通过针刺左右足三里穴，用泻针法治愈。因此，如在诊察脉象难以确诊的情况下，当全部采用古圣人的三种脉诊方法，以助诊断。

关于脉诊诊断，历代的前贤对有关脉诊的经验甚多，恕不重



述。谨将贫道个人诊脉的点滴心得经验写出，以供同道在临床实践中验证。现总结歌诀如下：

瞑目凝神不可忘，以神察脉细参详；
脉口人迎阴阳和，不疾不徐为健康；
春弦夏洪应生长，秋浮冬沉归收藏；
脉应四时天人合，脉逆四季身受殃；
色脉相得治易愈，色脉相克医难匡；
左脉太过却克右，右脉太盛则制左；
左脉不及能助右，右脉不及反从左；
阴脉上盛阳易陷，阳脉上盛阴易潜；
阳脉下盛阴多浮，阴脉下盛阳常厥；
阴阳虚极重下陷，左虚血亏右气虚；
阴阳现象皆浮越，下虚火升炎上诊；
浮沉迟数须分辨，紧缓大小滑涩参；
寒热虚实各有象，阴阳表里为大纲；
先察脉口出入别，次诊人迎升降差；
更诊左右盛衰象，方明气血循环情；
并候寸尺浮沉力，才知正负盈亏况；
正运太过当反调，负运太过则正治；
拟方用药从脉症，挽转阴阳运生机；
针灸按摩亦凭脉，逆从选穴补泻施；
临床用活阴阳理，圆融通变疗百病。

由于胃经乃五脏六腑之海，而左右人迎穴处乃胃经部位，故能诊候六腑的脉象。肺经为百脉朝会之所，故两脉口能诊候五脏的脉象。察左右脉口以诊五脏之本，察左右人迎以诊六腑之标，以本为



主，以标为次，标本主次以得，自有调治权衡阴阳的法则。如汉代医圣张仲景善于用药物治疗病，也非常注重诊察阴阳双方的脉象，《伤寒论》原序云“人迎趺阳，三部不参”，可见其不但诊察人迎脉，并且对诊察脉口与趺阳的动脉也十分重视。因趺阳动脉也属胃经之气下达的部位，故人迎与趺阳动脉的诊候，都是与足阳明胃经联系相关的。以上是贫道的脉诊观点和实践经验，有待未来医科的科学研究证实其优劣；同时也希望当今中医研制出阴阳共振诊察脉口、人迎之阴阳、盛衰数据的诊脉仪，从而提高传统医学的确诊率。

第二节 古圣人诊候脉口、人迎出入升降的例证

张仲景医圣《伤寒论》原序云“按寸不及尺，握手不及足，人迎趺阳，三部不参”，桂林古本《伤寒杂病论·平脉法》仲景师曰“人迎脉大，趺阳脉小，其常也；假令人迎趺阳平等为逆，人迎负趺阳为大逆；所以然者，胃气上升动在人迎，胃气下降动在趺阳，上升力强故曰大，下降力弱故曰小，反此为逆，大逆则死”，以上充分说明，张仲景医圣深明足阳明胃经是在升降往来运行，故诊察胃气上升的能量，候在颈两侧的人迎穴动脉，诊察胃气下降的能量，候在两足部的趺阳穴动脉。人迎与趺阳皆属于足阳明胃经，故能诊候胃经的升降、盛衰。

《素问·玉机真藏论》曰：“春脉如弦，何如而弦？”岐伯对曰：“春脉者肝也，东方木也，万物之所以始生也，故其气来，软弱轻虚而滑，端直而长，故曰弦，反此者病。”帝曰：“何如而反？”岐伯曰：“其气来实而强，此谓太过，病在外；其气来不实而微，此



谓不及，病在中。”帝曰：“夏脉如钩，何如而钩？”岐伯曰：“夏脉者心也，南方火也，万物之所以盛长也，故其气来盛去衰，故曰钩，反此者病。”帝曰：“何如而反？”岐伯曰：“其气来盛去亦盛，此谓太过，病在外；其气来不盛去反盛，此谓不及，病在中。”帝曰：“秋脉如浮，何如而浮？”岐伯曰：“秋脉者肺也，西方金也，万物之所以收成也，故其气来，轻虚以浮，来急去散，故曰浮，反此者病。”帝曰：“何如而反？”岐伯曰：“其气来，毛而中央坚，两傍虚，此谓太过，病在外；其气来，毛而微，此谓不及，病在中。”帝曰：“冬脉如营，何如而营？”岐伯曰：“冬脉者肾也，北方水也，万物之所以合藏也，故其气来沉以濡，故曰营，反此者病。”帝曰：“何如而反？”岐伯曰：“其气来如弹石者，此谓太过，病在外；其去如数者，此谓不及，病在中。”以上论春、夏、秋、冬四季脉象，唯独论肝脏脉只讲出了来的脉象，而未说明去的脉象，但对心、肺、肾的三脏脉象，都说明了在诊脉中有来去之诊候。这春、夏、秋、冬四季的脉象转变，皆指诊候两脉口的动脉而言，贫道若没有经过那种功态的显象，也难悟透这《素问·玉机真藏论》所论脉波之来去的道理。所谓“来者”，即正运行的脉波显象；所谓“去者”，即负运行的脉波显象。据以上两个证例，可证明古圣人们诊察脉象，都十分重视诊候正负往来的脉波。

贫道研究十二经脉的道理亦是正负往来运行机理，与古圣脉诊道理是相符合的。但其中之理，只有一点点区别，即分别左右两侧的脉象运行是相对立的升降、往来。特列出阴阳正负脉波表于下，还当联系参考功态呈现表即明二十经脉之左右圆通的机理。（表二）



表二 脉口、人迎动脉的正负脉波表

手足三阴经	正运	手足三阴经从胸走手、由足走腹运行时，所激起的气血波动在脉口（来）的脉象	负运	手足三阴经从手走胸、由腹走足运行时，所激起的气血波动在脉口（去）的脉象
手足三阳经	正运	手足三阳经从手走头、由头走足运行时，所激起的气血波动在人迎（去）的脉象	负运	手足三阳经从头走手、由足走头运行时，所激起的气血波动在人迎（来）的脉象

左手脉口以诊候左侧手足三阴经的正负运行脉象，右手脉口以诊候右侧手足三阴经的正负运行脉象；左人迎脉以诊候左侧手足三阳经的正负运行脉象，右人迎脉以诊候右侧手足三阳经的正负运行脉象；并比较脉口和人迎所释放的脉波能量之大小、强弱，辨别一倍、二倍、三倍以及阴阳的太过或不及。

脉诊乃医生诊察患者之正负脉波运行的传感意识，所以医者必须静心静息，集中精神，细心分别，默识神会而体察出患者的不平之处或独异之处，即是病灶之所在。无论是用针灸、按摩，还是用中、西药治疗，均要从调平上下、左右的阴阳经脉着手，如调治得阴阳四处（即左右脉口、人迎）动脉平衡，才为“上工平气”，疾病亦祛。“平均合理”是世间辨证论治的真理，但是在事物发展进程中却难以真正实现这个“平均合理”，所以医者调治一切疾病，一定要正确执行这个法则，只有将人体之内的左右阴阳调平而愈，才能真正实践“平均合理”的要求。



第三节 阴阳两性的脉象诊断

《灵枢·九针十二原》曰“凡将用针，必先诊脉，视气之剧易，乃可以治也”，说明在用针之前，医者必须首先诊察脉象，根据脉象所呈现的虚实以及病证的轻重情况，才可以相应地决定出调治方法。《灵枢·终始》云：“人迎三盛，泻足阳明而补足太阴，二泻一补，日二取之，必切而验之，疏取之上，气和乃止。脉口一盛，泻足厥阴而补足少阳，二补一泻，日一取之，必切而验之，疏而取之上，气和乃止。”据经上所论述的“人迎脉三盛”，当补足太阴脾经而泻足阳明胃经；“脉口脉一盛”，当补足少阳胆经而泻足厥阴肝经。这就充分说明未经过诊察阴阳脉象盛衰之前，就预先决定出取治某经某穴的处方是不符合古圣之针灸治法的。

贫道多年以来在研究探讨经络学中体会到，人体患病，其十二经脉的运行复杂，有意料不到的变化，手足三阴三阳经脉也并非常存固定的盛衰状态，所以在诊疗上若要做到合理合法调治人体十二经脉的疾病，首先就必须通过诊察阴阳脉象的虚实之后，才能根据阴阳两方脉波的虚实现象来决定应该调治某经脉或某某穴位，又才能根据阴阳脉象的盛衰表现以确定施行或补或泻的调治方法，即是遵守古圣人诊疗结合的正确治疗规则。但参阅后世各针灸家的书籍，皆缺少阴阳两个方面的脉象诊断，都只着重于某类病证即预定有某些经验穴位的组方，并倡导各个穴位的经验效果等等，所以后世以来在各穴位上总结了很多经验。各针灸书籍虽然也论及脉象诊断，但仅只论述了两手脉口的脉象而已，故后世以来的针灸书籍中论脉象，只有阴经方面的脉象诊候，却没有阳经方面的脉象诊断，



因而只形成了不周全的阴阳诊断。

《灵枢·经脉》论手太阴的肺经脉云“盛者寸口大三倍于人迎，虚者则寸口反小于人迎也”，论手阳明的大肠经脉云“盛者人迎大三倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也”，这说明古圣们诊脉，全是用阴阳两方的脉象相对照，按大小、盛衰以确定阴阳经气的虚实。贫道遵守古人圣法诊察脉口、人迎的阴阳动脉，在诊断治疗上疗效甚高，故认为应承继先圣的诊法，即可减少误诊。

现以大、小脉而论：如诊得人迎的阳脉大而脉口的阴脉小，便可确诊为阳经的能量盛、阴经的能量衰；若诊得脉口的阴脉大而人迎的阳脉小，便可确诊为阴经的能量盛、阳经的能量衰；如果诊得脉口、人迎两方皆呈现盛大的脉象，只可诊断为阴阳的经气皆盛，就不能确诊阴阳两方面谁胜谁负了。因此“大脉”若失去“小脉”来相互比较，也就失去了对照依据，那用何作证据以确定其为“大脉”呢？脉口的阴脉若失去了人迎的阳脉来作相互比较，也就失去了对照依据，那用何作证据来确诊阴阳两方谁盛谁衰呢？所以，必须有对立面，才能有完整统一的辨证方法。经云“盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之”，又云“阴盛而阳虚，先补其阳，后泻其阴而和之；阴虚而阳盛，先补其阴，后泻其阳而和之”，这以上说明的种种有原则的施治，全要依靠诊断脉口和人迎，以权衡三阴、三阳经气的盛衰之后，才能胸有成竹地去施行调整阴阳次第的补泻针法，即是正当的诊疗规则，否则就遗弃了古圣先哲们的正确诊疗规则。不依据脉口、人迎的阴阳脉象盛衰而施行补泻针法，即是盲目的施用补泻，失去了人迎脉的诊断是十分可惜的。

《灵枢》是针灸疗法的鼻祖经典，其中具备着天人合一的道理，真正是道合太虚、理应人体，实乃举世无双的中华瑰宝，如能遵守



古训诊疗治病可起沉痾，其利于病人的疾病早愈而功德无量。故贫道于研读之前，必虔诚敬意稽首顿首以致礼，亦望未来中医界同人不可轻视。如果用针灸调治疾病，定要恢复古圣阴阳对立的脉口、人迎诊法，将阴阳脉象诊断与十二经脉的道理结合起来，才能正确地辨证施治运用于临床，才称得上是随机应变和有的放矢的治疗。

第四节 对脉口、人迎动脉之一倍二倍三倍的分析

一倍、二倍、三倍的动脉显象，是论阴阳动脉正负运行之宽窄度的脉波差别。何谓病在手足的太阴、阳明脉三倍，病在手足的少阴、太阳脉二倍，病在手足的厥阴、少阳脉一倍？

两脉口的脉诊部位，属手太阴肺经的经脉路线；两人迎的脉诊部位，属足阳明胃经的经脉路线。

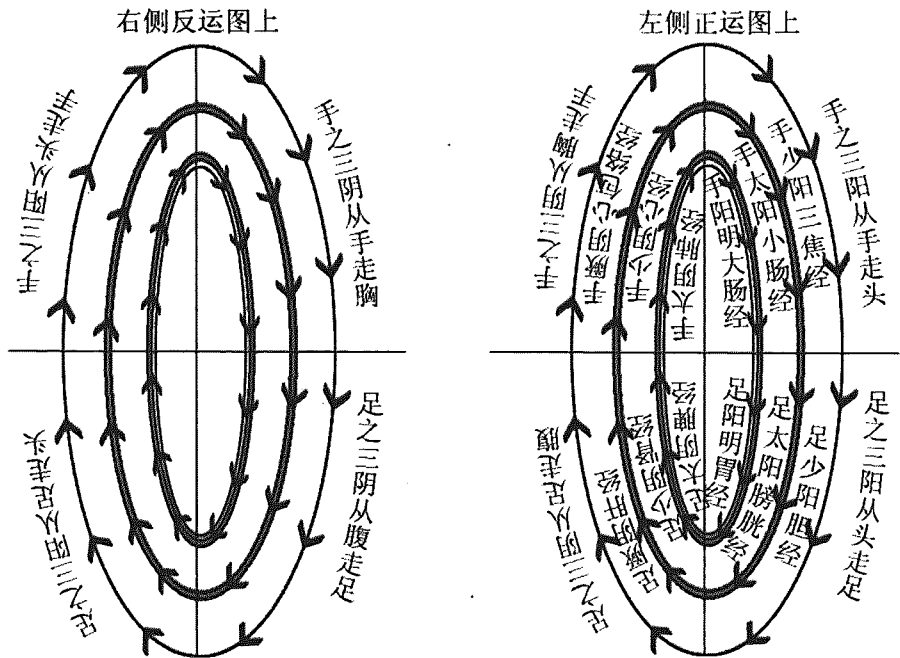
1. 《灵枢·经脉》论手足太阴、阳明的经脉：起始于手太阴肺经的胸中，外出行至手交手阳明，由手阳明上行至头交足阳明；由足阳明下行至足交足太阴，由足太阴上行至腹。这从体上到体下循环阴阳、表里一周，形成了第一道手足阴阳的大循环周。因为脉口、人迎脉诊部位都在这第一道阴阳环周之上，所以手足的太阴、阳明受病，是受直接的阴阳脉搏传感反应，故以三倍的脉象以诊候太阴、阳明的疾病。

2. 论手足少阴、太阳的经脉：起于手少阴心经的心中，外出行至手交手太阳，由手太阳上行至头交足太阳，由足太阳下行至足交足少阴，由足少阴上行至腹。这由体上到体下循环阴阳、表里一周，形成了第二道手足阴阳的大循环周。由于脉诊部位是在第一道阴阳环周之上，所以手足的少阴、太阳受病，是间接的阴阳脉搏传



感反应，故以二倍的脉象以诊候少阴、太阳的疾病。

3. 论手足厥阴、少阳的经脉：起于手厥阴心包络的胸中，外出行至手交手少阳，由手少阳上行至头交足少阳，由足少阳下行至足交足厥阴，由足厥阴上行至腹。这从体上到体下循环阴阳、表里一周，形成了第三道手足阴阳的大循环周。因脉诊部位在第一道阴阳环周之上，中间隔着第二道阴阳环周，故脉搏传感更远，所以手足的厥阴、少阳受病，是隔离间接的阴阳脉搏传感反应，故以一倍的脉象以诊候厥阴、少阳的疾病。示一倍、二倍、三倍之全息图如下（图十）：



图十 一倍、二倍、三倍图

这三道大循环运行的联系，是依靠三条分支经脉：

1. 足太阴脾经：“其支者，复从胃，别上膈，注心中。”
2. 足少阴肾经：“其支者，从肺出络心，注胸中。”
3. 足厥阴肝经：“其支者，复从肝别贯膈，上注肺。”



人体的营卫之气，就是通过以上三道大阴阳环周，行阴二十五度，行阳亦二十五度，终而复始，传注周流，循环不已。（表三）

表三 手足十二经脉太过不及表

手肺	太阴	太过	脉口大三倍于人迎	不及	脉口反小于人迎
足脾					
手心	少阴	太过	脉口大二倍于人迎	不及	脉口反小于人迎
足肾					
手心包	厥阴	太过	脉口大一倍于人迎	不及	脉口反小于人迎
足肝					
手大肠	阳明	太过	人迎大三倍于脉口	不及	人迎反小于脉口
足胃					
手小肠	太阳	太过	人迎大二倍于脉口	不及	人迎反小于脉口
足膀胱					
手三焦	少阳	太过	人迎大一倍于脉口	不及	人迎反小于脉口
足胆					

第五节 对阴阳动脉的认识及阴阳双诊的优点

《灵枢·经脉》曰“经脉者常不可见也，其虚实也以气口知之”，十二经脉的正负运行机能无形无象，何以医者诊察阴阳脉象的往来虚实，可以确诊十二经脉的阴阳盛衰，甚至两足部的太溪穴动脉还能见到它的动脉搏动？既然说十二经脉是无形无象不可得见，何以又能摸得着和见得到呢？因为无形无象的十二经脉之阴阳对立运行的能量，鼓动了人体之有形有象的气血，故而形成了人体



阴阳动脉的脉搏显象，所以医者才可以摸得着和见得到。这犹如大地上吹起东南西北风一样，而东西南北的风是无形的能量，亦难以见得到，但可以从大地上有形的物体如树木的摆动及水面的波浪测知。所以诊察脉口与人迎动脉，即是诊察人体三阴三阳之正负运行所促成的气血脉波，阴阳动脉的盛衰与十二经脉的盛衰是同源相感的。

人体之内这个气血脉波的现形现象，历代的前贤创作了很多脉学著作，各立己见而说法不一，这些复杂的脉象立论各有自己的理论心得体会。据贫道研究《灵枢》认为，归根到底只有两类归纳性质，即平与不平的两类性质脉象。《灵枢·终始》云“所谓平人者不病，不病者，脉口人迎应四时也，上下相应而俱往来也，六经之脉不结动也，本末之寒温之相守司也，形肉血气必相称也”，如以上各类脉象正常相应，当归纳为人体十二经脉的和平公式。再如《灵枢·终始》曰“人迎一盛，病在足少阳，一盛而燥，病在手少阳。人迎二盛，病在足太阳，二盛而燥，病在手太阳。人迎三盛，病在足阳明，三盛而躁，病在手阳明。人迎四盛，且大且数，名曰溢阳，溢阳为外格。脉口一盛，病在足厥阴，一盛而躁，在手心主。脉口二盛，病在足少阴，二盛而躁，在手少阴。脉口三盛，病在足太阴，三盛而躁，在手太阴。脉口四盛，且大且数者，名曰溢阴，溢阴为内关”，如以上种种有阴阳盛衰差别的脉象，当归纳为人体十二经脉的不和平公式。《灵枢·终始》云“持其脉口人迎，以知阴阳有余不足，平与不平，天道毕矣”，诊候两手的脉口动脉属阴，犹如地道，诊候颈两侧的人迎动脉属阳，犹如天道，故阴、阳动脉双诊即可得天地之全道。但后世的脉学诊候，均只论诊察两手上的脉口动脉，并有言“左手动脉为人迎，右手动脉为脉口”。因此，很可能是这种立论失掉了真正的人迎脉诊，但这种立论贫道认为是没有理由的。因为五脏与六腑各有两道经脉，一道在于左



侧，一道在于右侧，这左右两手的脉口动脉部位，全属手太阴肺经的经脉路线，故两手的脉口动脉只能代表五脏之阴面左右正负往来的脉象，它不可能代表颈两侧胃经的人迎动脉。

根据贫道多年的体验，应遵古法诊候两脉口与两人迎动脉，才是左右四方、阴阳两性的全面诊察。如果只注重属阴的脉口动脉的诊断，尤其是在阴阳运行的极化之时，脉口与人迎处显象特殊，不是在阴面隐形藏相，就是在阳面隐形藏相。若从脉口诊候五脏的里阴，从人迎诊候六腑的表阳，脉象藏形于阴面，必显形于阳面，脉象藏形于阳面，必显形于阴面。双诊阴阳经气的太过和不及，则明昭易辨，准确少误，既明了又简单，在治疗中才能辨证明确，疗效亦佳。医者诊疗疾病应根据这简捷的诊候，以诊察出阴阳脉象的盛衰差别，来确定出调整阴阳平均的方法，从而促使十二经脉再回复“还原和平”的运行状态。

这种直截了当的阴阳脉诊为何弃而未用？贫道认为，《灵枢》虽然未将十二经脉的道理详尽地述明于书，但在古圣师徒之间定有心传口授。例如《黄帝内经》中的雷公、少师、伯高等即是传人，很可能在后来一代代的传承中，因保守医术或时代变迁等原因造成真理失传。现代中医学界提出口号要研究发展中医治病，那就必须要拓展出古圣们之宝贵的传统经验。经曰“持其脉口人迎，以知阴阳有余不足”，由此对古圣经典中所倡导的诊断方法不能盲目遗弃，应在继承的同时，再结合现代新认识加以提高，如此将会使祖国医学进入一个新的领域，也将对古医文化中所蕴藏着的至高无上的医理、医术有新的发现。若逐步总结经验，将会准确无误地运用于临床，何愁我国的中医水平不超越世界的医学水平呢？

由于十二经脉的道理不明而阻挡着中医前进的道路，因此贫道不自量力，虽然学识有限，文字表达能力甚差，也勉强著书立说，



将研究十二经脉的心得体会贡献出来，以供爱好祖国医学的同人们参考验证，以共勉前进。为此贫道真诚地希望中医界同人本着实际出发，用科学的态度来证实这阴阳双诊的优越性。

第六节 关于人迎脉的诊法

后世以来对颈两侧的人迎动脉少有人诊，只见到仲景医圣论及，在各脉学书中也未见到对人迎脉的诊察方法。因此，贫道为了验证落实十二经脉的道理，通过多年的探讨，历经反复的验证，现已确定两人迎动脉的诊候部位与诊察方法，今提供出来以供中医界同人在临床中试诊。

1. 人迎动脉的诊候部位：在前颈（廉泉穴下）喉结骨最高突处（从此处向两旁后退至人迎动脉搏动处诊之）为关部，关部以上为寸部，关部以下为尺部。

2. 人迎动脉的诊法：医生可采取 2 种诊候形式。①令患者端坐，医者立于患者的背后，诊脉动作与诊候两手的脉口动脉同样，以三指并齐，先下中指（以中指头接触高突喉结骨位时再向后退至人迎动脉处诊之）属关部，次下食指于关上寸部，再下无名指于关下尺部。用右手以诊候患者的右人迎动脉，用左手以诊候患者的左人迎动脉。②医者站立于患者的左侧，用左手诊候患者的右人迎动脉；医者转换方位站立于患者的右侧，用右手诊候患者的左人迎动脉。

3. 脉诊规则：先诊脉口动脉以候五脏之里阴，后诊人迎动脉以候六腑之表阳，就能取得八纲辨证的阴、阳、表、里四纲。《灵枢·禁服》云“脉口主中，人迎主外”，《灵枢·五色》曰“人迎盛坚者，伤于寒；气口盛坚者，伤于食”，充分说明两手的脉口属五



脏之阴，主里，颈两侧的人迎属六腑之阳，主表。明确分清了阴、阳、表、里，再结合辨别缓、急、大、小、滑、涩六脉，并以浮、沉、迟、数参合诊断，就又能诊断出寒、热、虚、实的四纲证候，诊法虽然简单，亦能运用阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八纲诊断。

《灵枢》论脉诊，提倡两种简要的诊断方案。①论色、脉相应、相克、相生。《灵枢·邪气藏府病形》云：“色青者，其脉弦也；赤者，其脉钩也；黄者，其脉代也；白者，其脉毛；黑者，其脉石。见其色而不得其脉，反得其相胜之脉，则死矣；得其相生之脉，则病已矣”，说明如肝木生病，其色当青，其脉象当弦，为色脉相应的常规现象，可按阴阳的盛衰调平即愈。如果肝木患病，其面色青，反诊得轻浮而毛的肺脉，是肺金克肝木之象，为不吉而预后不良。若是肝木有病，其面色青，而诊得沉石之肾脉，为肾水生肝木之吉象，故肝病易于痊愈。心火、脾土、肺金、肾水仿此理类推。②在脉诊中，辨别缓、急、大、小、滑、涩六种脉象以诊断人体的寒、热、虚、实及气血盛衰。《灵枢·邪气藏府病形》曰“诸急（紧象脉）者多寒，缓者多热，大者多气少血，小者血气皆少，滑者阳气盛，微有热，涩者多血少气，微有寒”，足以说明诊此缓、急、大、小、滑、涩六脉，便可诊断体内的寒热、虚实及气血多少。

附：缓脉典故

谈到缓脉，借此讲贫道误解缓脉的故事。说出来虽属无知可笑，但借鉴生活中真实的物理现象却能有益于脉理。

初习医时，由于从事农活，常借耕锄之隙学习，既没上医校，又未拜师，加之文化知识有限，学脉理时对《灵枢》中诊察缓脉的误会，却是在犁地时始明其理。脉学中有迟脉一息三至主寒，数脉



一息六至主热，这两种相对的脉象道理甚明。可是《灵枢》言“缓脉多热”，由于开始学医，认识肤浅，自以为缓脉的缓字与迟脉的迟字是同义词，为何却说迟脉有寒而缓脉又多热呢？这个疑问一直存疑惑于大脑，日夜思考不得其解。

有一天秋播耕地收工，便将犁地的工具置于田野而牵牛归家，当日晚上风雨交加，降了数阵大雨。次日天气晴朗，贫道又牵牛去耕地，依旧将耕牛套在轭头绳子内，却发现粗绳子缩短了七八寸（因寒湿雨水入侵所致），随手即将粗绳放长七八寸而驱牛耕地，对这种日常遇见的事物也未介意。将近中午，太阳当空，气温高升，此时见耕牛犁地十分吃力，才发现粗绳上的雨水亦被阳光晒干，粗绳已变得松缓弛长了。在停牛收绳的瞬间，突然醒悟到《灵枢》中的“缓者多热，急者多寒”之故，亦是热胀冷缩之理。这一深刻的启发，成为贫道后来治病诊断寒热的依据。

由于脉现不迟不数的寒热甚多，就需用紧、缓脉象来分辨寒热，才能辨证明确，今特将此过程述出，愿同行亦能受益。

第七节 对缓急大小滑涩六脉的认识

《素问》《灵枢》乃古圣人创立的医学之纲，后世的医学是从这纲中化出的目，贫道畏繁求简，认为《灵枢》中的缓、急、大、小、滑、涩六种病脉的诊断甚为简要。贫道对缓、急、大、小、滑、涩六脉的认识如下。

1. 缓脉 经言：“缓者多热。”凡显现松弛形象的缓脉，就知体内存有温热的阳气。正常人如诊得阴阳双方的寸、关、尺三部的动脉往来均匀都现缓象，可为阳足神全，是阴阳交泰健康长寿之脉。如果诊得缓脉在左右、阴阳、寸尺不均即是病脉。缓脉出现在尺



部，热在下焦；在关部，热蕴中焦；在寸部，热炎上焦；在脉口，主脏；在人迎，主腑；在左，属左；在右，属右。其他六脉诊候以此类推。所以如上所述，诸疾患若显象缓脉者，可证明体内有阳光煦照，故言“缓者多热”。

2. 紧脉 经言：“急者多寒。”诊得脉象紧急，即知为寒邪所伤，大凡寒邪必先侵表，“寒主收引”即热胀冷缩之理。如果身体感寒，脉搏即会出现紧象，故言“紧者多寒”。

3. 大脉 经言：“大者多气少血。”脉显粗大，可知体内气有多余。若是体内的气血平等相宜，其脉象必显出不大不小的中和之脉象。所以脉大者为血液配备气运不够所需，故言“脉大者多气少血”。

4. 小脉 经言：“小者血气皆少。”小脉者，乃细小的脉象，可证明气的张力与血液的流量共同运行不足，故诊得小脉为阴阳平衡衰弱，气血双亏，故言“小者血气皆少”。

5. 滑脉 经言：“滑者阳气盛，微有热。”诊得滑脉能证明体中的气血通畅流利。气无血不附，血无气不行。前贤云“气主煦之，血主濡之”，故血依气运行，气靠血濡养，若气血运行和平相宜，脉象定不快不慢，从容不迫。脉显往来流利的滑象知气必旺，故言“阳气盛”。因滑脉的运行较快，虽然不能称为数脉但接近于数脉，故言“滑者阳气盛，微有热”。再者，生育适龄的妇女，在断经之后如诊得滑脉，为身怀有孕之脉象。

6. 涩脉 经言：“涩者多血少气，微有寒。”脉显涩象，可测知体内的血液中缺乏阳气运通血脉，犹如沟渠内本自有水，却不能得到畅流，其内在的运行道理是与滑脉恰恰相反，故言“多血少气”。水长流者不易结冰，是水流生温之故。然而涩脉的血液并非不能流动，只是在流行之中尚缺乏一点阳气促使通畅而显涩滞不利，故经言“涩者多血少气，微有寒”。



第八节 脉诊中的现实情况

《灵枢》对五脏六腑的脉诊诊断，没有按脉口、人迎的寸、关、尺部来分配脏腑定位，却只区别一倍、二倍、三倍的阴阳两面性以对照盛衰，以决定阴经、阳经的虚实，贫道按这种阴阳两面性的诊断治疗，效果满意，并在多年的临床中发现有如下几种脉象情况。

1. 诊候脉口、人迎的一倍、二倍、三倍现象，是古圣人对众人的大体概括，并非是所有人都以同样大小之一倍、二倍、三倍的脉波出现，而是根据各人自身的生理及动脉的现象，再分别以大、中、小的比差来确诊病在何脏、腑、经脉，是因人制宜的脉诊规则。贫道经过测试，如脉诊 10 个健康无病之人的动脉显象，各有内外、阴阳、左右、上下不同的脉象差别，不可能取得统一的脉波显象。《灵枢·阴阳二十五人》论五五二十五种人的生理，各人有所不同的生理特征或缺陷，故在脉诊中就不能得到统一的脉象。

2. 个别先天素质太差的人又与大众有别，其脉象似有不明，微涩难辨。还有肌肉丰厚特殊体胖之人的动脉被肌肉掩盖，特别是颈两侧的人迎动脉，难以辨别。

3. 一部分四五十岁及以上的老年人，其颈部的人迎动脉逐步增强，而手上的脉口动脉逐步减弱，是否与衰老和血压升高有关，有待研究。

4. 比较单纯的疾病，易于用一倍、二倍、三倍之脉象辨明，如肝脏患病可按一倍的动脉显象诊断，如果肝脏患病而肺脏又生病，或是脾脏有病而心脏又患病，在脉诊中易产生混淆。

实践证明，利用阴阳两性的脉象诊断，实是调治阴阳经脉的指南方向盘。但是若遇到以上数种特殊异常的脉象，还必须运用脏腑辨证和望、闻、问、切辨证来综合诊断，才是祖国医学灵活完整的诊断规则。



第九章 脏腑辨证与十二经脉

中医脏腑辨证，是根据内在的脏腑各有隶属，外在的经脉各有循行路线，各脏各腑的病各有突出不同的症状表现以作辨证分析。各脏腑的病变虽然复杂，但根据病因结合病证细心分辨，自能得出诊断结果。

一、肝脏

肝藏血，血舍魂。肝主筋，开窍于目，其荣在爪，与胆相表里。在体为筋，在色为青，在声为呼，在变动为握，在味为酸，在液为泪，在志为怒。怒伤肝，肝恶风，悲怒气逆则伤肝。酸走筋，筋病勿多食酸。肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸泻之。肝苦急，急食甘以缓之。以上归纳了不完全的《内经》引言，以便在临床中归类分析病机病因，并按五脏六腑各有不同的生理特征及病证表现，给予辨证施治。

经云“诸风掉眩，皆属于肝”，肝脏主筋，属风木，凡出现头目昏眩与筋脉抽搐动风，应考虑为肝经的病证。

肝经实证：急躁易怒，头痛昏眩，两目混浊红赤，或产生吐血衄血。若肝阳上亢，肝经炽热上冲巅顶，甚则引起癰疽昏愤失知，治宜平肝熄风清理肝火，以及镇肝潜阳熄风。

肝气郁结：多因情志不畅导致肝经运行郁阻，使肝气横逆于两胁下闷胀串痛，并牵连腹背疼痛，抑郁易怒，咽哽干呕，厌食，善叹息，两脉口之寸部当涩滞少脉，治宜疏肝理气血宣散郁结。



肝阴亏损：头昏头痛，耳鸣心烦，难以入眠，多梦，小便色黄，口舌干燥少津液，为阴血不足以养肝，治宜滋养肝阴兼培脾肺。

寒侵厥阴：如寒犯肝经而寒气留连，可引起小腹隐隐作痛，妇女易导致少腹气结瘕聚，男子则痛连睾丸，脉当弦紧迟涩，治宜温经散寒通经。经云：“肝病者，两胁下痛引少腹，令人善怒。虚则目眈眈无所见，耳无所闻，善恐，如人将捕之。”

附：中风偏废病理分析

中风偏废之病，现代医籍多列于肝脏，认为肝经主风，中风偏废的症状，并非肝经一经受病，而是人体一个侧面的手足之三阴三阳机能全部失调，一时共虚所引起的突然发病。由于人体是左右、阴阳两性组成的一个整体，人体的气血可以左右周流无处不到而灌溉全身，可是人体左右十二经脉的机能运行，是左侧手足的三阴三阳与左侧的阴阳经脉相交，右侧手足的三阴三阳与右侧的阴阳经脉相交，故而中风只偏废人体的一侧。

中风偏废疾病，当参考第三章“解释根溜注入矛盾”一节论述的头、手、足三部之三阴三阳经脉的机能伸缩活动。头部的升降屈伸机能，以颈为界限，形成在上的天部；手部的三阴三阳经脉之出入屈伸机能，以上半身的肘部为界限，形成在中的人部；足部的三阴三阳经脉之出入屈伸机能，以下半身的膝部为界限，形成在下的地部。

例如现代医学定名为“颜面神经麻痹”的口眼歪斜病证，为邪风侵入了人体一侧的天部，故症状以颈为界。如果中风偏废，即是邪风侵入了人体一侧的天、地、人三部，所以症状表现则是半侧偏废。《灵枢·九宫八风》云“其有三虚而偏中于邪风，则为击仆偏枯矣”，说明是人体一侧之上、中、下三部的经气共虚，才导致中



风偏废疾病。由于人体的任脉与督脉都是左右两条经脉相合并的，所以中风偏废的症状，即以任、督二脉的中线分界，其患侧废而健侧好。任、督二脉如果是一条经脉，那么中风病邪就会传染到人体的左右两侧。

二、胆腑

胆腑实证：常有头昏目眩，甚则耳聋，两肋间疼痛气逆连背，并可导致胃气上逆而呕吐苦水，小便黄赤，或表现有寒热往来，人迎脉当弦而有力，治宜疏肝泻胆。

胆腑虚证：两目视物昏暗不明，胆虚易惊，常感畏惧自恐，头昏少寐，脉弦细无力，治宜养肝以利胆。经言：“徇蒙招尤，目冥耳聋，下实上虚，过在足少阳、厥阴，甚则入肝。”

三、心脏

心藏脉，脉舍神。心主血，开窍于舌，其荣在面色，与小肠相表里。在体为脉，在色为赤，在声为笑，在变动为忧，在味为苦，在液为汗，在志为喜，喜伤心，心恶热，忧愁思虑则伤心。咸走血，血病勿多食咸。心欲软，急食咸以软之，用咸补之，甘泻之。心苦缓，急食酸以收之。心脏如产生精神失常的疾病，则神志错乱，狂躁妄动，哭笑悲怒，语无伦次而行动反常。经言“心气虚则悲，实则笑不休”，这说明临床诊疗精神疾病，既要诊候阴阳脉象的虚实现象，又要观察患者的情志表现以确诊属实属虚，对治疗精神性的疾病用针灸治疗最宜。心脏主血，其血液的循环能通达脏腑内外上下周身无所不至，故心脏患病除精神疾病外，多为在血液运行上造成病因。

心火盛实证：多为心脏的血液运行过速而产生心火过甚，证现



心烦不安，面赤脉数，小便赤涩，口渴不欲多饮，或产生吐衄及外渗出血等症，治宜泻心火凉血。

寒证：若血分有寒则血液运行不畅，脉象弦紧而涩，或迟涩，面色青，心胸疼痛或腹痛头痛，妇女则行经不畅而痛经，饮食喜热畏凉，治宜温经行气血。

血瘀：心血运行瘀阻在内，常见面色晦暗，脉象沉涩，口唇爪甲青紫，舌紫红有瘀斑，心胸憋闷刺痛，痛引肩背左乳房下，时发时止，如血液循环瘀塞在体外，则发生痈疽疮疡，脉象滑数，或伴有发热、畏寒等症状。经言“诸痛痒疮，皆属于心”，即是言心脏血液瘀阻于外的痈疽之病。前者，治宜活血行瘀理气；后者，治宜清热凉血解毒行瘀。

心血虚损：血液量少则循环运行不足，心悸短气，面色无华，健忘失眠，精神疲乏，情志好悲伤，脉象虚弱无力，治宜培补气血。经言：“心病者，胸中痛，胁支满，胁下痛，膺背肩胛间痛，两臂内痛；虚则胸腹大，胁下与腰相引而痛。”

四、小肠腑

小肠为受盛之府，主转化饮食糟粕并吸收营养，是食物分别清浊的界限。

小肠实热：头痛心烦，少腹胀痛，小便黄赤不利，或耳前面发热，口舌糜烂，治宜清热利湿。

小肠虚寒：小腹隐痛时痛时止，喜温热，按则痛缓，或少腹痛时牵连腰背睾丸而小便频数，治宜理脾温气散寒。经曰：“心烦头痛，病在鬲中，过在手巨阳、少阴。”

五、脾脏

脾藏营，营舍意。脾主肌肉，开窍于口，其荣在唇，与胃相表



里，在体为肉，在色为黄，在声为歌，在变动为哕，在味为甘，在液为涎，在志为思，思伤脾，脾恶湿，饮食大饱则伤脾。甘走肉，肉病勿多食甘。脾欲缓，急食甘以缓之，用甘补之，苦泻之。脾苦湿，急食苦以燥之。

脾与胃，主中央土，中土运化木、火、金、水四方。胃土为水谷之海，脾土转输水谷以发散精气而营养全身为后天之本，故从古达今的良医对治疗五脏六腑之病，无不注重脾胃，所以皆联系脾胃用药立方，主要由于中土是木、火、金、水的中枢核心。如《素问·太阴阳明论》云“脾者土也，治中央，常以四时长四藏，各十八日寄治（是于三、六、九、腊的辰、戌、丑、未之月各取十八日，而每一昼夜亦有辰、戌、丑、未之时亦属中土的时辰）”，所以说脾与胃是人体后天的生化本源之核心。

脾胃不调：多为饮食不节所伤，引起中脘食积痞满，噎气呃逆甚则呕吐，腹痛绵绵不思饮食，治宜健脾消食和胃。

脾胃中气下陷：多为左肝右脾气机下陷，两脉口在正运之时，两寸部动脉特别显象虚而无力，肠鸣腹泻，气往下堕，呼吸短气懒言，饮食减少，四肢倦怠乏力，治宜补益中气。

脾胃湿热：湿热蕴郁中焦，脘腹胀满，身重体困，面目暗黄，大便溏，小便黄而不利，或发热口渴，治宜清热利湿。

脾肾两虚：形体畏寒，四肢清冷，腰酸腹痛虚满时轻时重，大便稀薄，脉象沉小，或下肢浮肿，治宜温肾健脾化水气。经言“诸湿肿满，皆属于脾”，又言“脾气虚则四肢不用，实则腹胀”。

六、胃腑

胃是容纳五谷之府，人以胃气为本，胃消化五谷以养人，故胃是人体最根本的生命资源。



胃寒：脘腹疼痛绵绵喜按摩，口常吐白沫清涎，舌苔白腻，喜热饮食嗜好香燥，治宜理中温胃。

胃热：口渴喜凉饮，胃脘嘈杂，多食善饥，或反胃呕吐，舌红苔黄少津，治宜清胃泻火。

胃虚：脘腹虚满，时胀时消，消化不良，饮食减量，大便宣泄，舌质淡苔薄，治宜补脾健胃。

胃实：口臭舌干，脘腹疼痛胀满，按之痛增，大便干，数日一便，两脉口的关、尺部沉而有力，两人迎的动脉浮沉皆有力，治宜消导。经言：“腹满腹胀，支鬲肱胁，下厥上冒，过在足太阴、阳明。”

七、肺脏

肺藏气，气舍魄。肺主皮，开窍于鼻，其荣在毛，与大肠相表里。在体为皮毛，在色为白，在声为哭，在变动为咳，在味为辛，在液为涕，在志为忧。忧伤肺，肺恶寒，形寒饮冷则伤肺。辛走气，气病无多食辛。肺欲收，急食酸以收之，用酸补之。肺苦上气，急食苦以泻之。肺脏主气，为诸脉朝会之所，司行呼吸之节奏，开阖上、中、下三焦的气机，以肃清内外、通调周身而推陈致新，故肺脏喻为相傅之官制节的称号。肺脏若失去正常的气机生理，即产生疾病，病证表现多为呼吸道的咳喘疾病以及表皮发寒发热。经言：“邪在肺，则病皮肤痛，寒热，上气喘，汗出，咳动肩背。”

肺寒：肺如受到风寒外束，周身可发生肌肤疼痛，鼻塞无汗，呼吸气粗，咳嗽喘促，吐出清痰，脉当浮紧，治宜发汗解表。

肺热：若邪气入侵蕴热伤肺多日化火，以致温邪内炽，咳嗽气喘，胸痛引背，咽喉肿痛，口干舌燥，甚则咳唾脓血有腥臭气味，



脉当滑数，治宜泻肺清热化痰。

肺气虚证：肺气虚弱则生理功能减退，呼吸气短，咳嗽无力，痰液稀清吐白沫，畏寒怕冷，倦怠无力；或因肺气久虚导致心火移肺刑金而成肺痿，干咳短息，虚烦盗汗，手足心热，午后低热，甚则痰中带血，声音嘶哑。前者，右脉口的寸部脉当不及，治宜培土益气化痰饮；后者，左脉口当浮数无力，右脉口沉数无力，治宜滋阴降火益脾肺。经言：“肺气虚则鼻塞不利少气，实则喘喝胸盈仰息。”

八、大肠腑

大肠为传导转输之腑，由于饮食入胃，下转小肠，又由小肠转入大肠，再由大肠将食物渣滓排出体外。

虚寒证：大肠受寒则腹痛肠鸣，大便清稀，好温热饮食，不能久立，喜屈腿侧卧，治宜温中散寒理气。

实热炎症：如右下腹患阑尾炎，热结疼痛拒按，治宜泻下清热而消除炎症。

湿热证：大肠感染湿热秽浊之气，起病陡然，腹痛，里急后重，大便频数，暴注下迫，或泻痢脓血，脉当滑数，治宜清热理气解毒。经言：“咳嗽上气，厥在胸中，过在手阳明、太阴。”

九、肾脏

肾藏精，精舍志。肾主骨，开窍于耳，其荣在发，与膀胱相表里。在体为骨，在色为黑，在声为呻，在变动为栗，在味为咸，在液为唾，在志为恐。恐伤肾，肾恶燥，强力举重则伤肾。苦走骨，骨病勿多食苦；肾欲坚，急食苦以坚之，用苦补之，咸泻之。肾苦燥，急食辛以润之。肾处下焦为先天之本，主骨髓藏精液，内藏真



水真火，左肾属真水，右肾属真火，若真火真水不亏，人体即十分健康，如二者有损即导致疾病。

肾阳虚：形寒肢冷，精神无力，面色淡白，头昏耳鸣，腰脊酸软或冷痛，或阳痿早泄遗精尿频，妇女则宫寒不孕，脉当沉小无力，治宜温补肾阳填精。

肾阴虚：肾阴亏损虚阳上浮，舌干口燥，头昏耳鸣，潮热盗汗，虚烦难眠，小便色黄，大便秘结，脉当阴阳俱浮寸旺于尺，治宜滋阴以潜浮阳。

肾不纳气：劳伤久病，肾气摄纳失调致使气不归元，咳逆短气汗出，动则喘促尤甚，腰以下寒，治宜摄纳固肾。

肾虚土衰：腰酸腹痛虚满，按之痛减，食少，四肢无力，常在早晨滑泻大便，消化不良大便稀溏，右脉口当沉弱无力，治宜温肾补脾益气。

肾水凌心：心中悸动不宁，多唾吐嗜睡，四肢厥冷，面色鲜明有水气，甚则四肢振振而动，脉当左脉口脉浮而迟，右脉口脉沉而迟，治宜宁心温肾化水气。

十、膀胱腑

膀胱为州都水府之官，化气则能出矣。由于膀胱主行津液化水气，病证表现多在小便。

膀胱之里实证：膀胱内湿热蕴结，导致小便淋沥不利，则尿急、尿频、尿痛、尿白浊等淋病，甚则尿血，日久可酿成结晶如砂石而引起腰痛，或小腹痛，大致疗法宜清热除湿利小便。

膀胱经之表实证：在冬天的寒冷季节，如风寒外邪侵入足太阳膀胱经，病证恶寒、头痛、身痛，脉象浮紧，治宜用辛温法以解表祛邪。



膀胱虚证：形体畏寒怕冷，腰膝酸软，小便多而频数，或遗尿尿精，脉当沉迟，治宜温摄补肾壮阳以温蒸水气。经言：“是以头痛巅疾，下虚上实，过在足少阴、巨阳。”

十一、三焦腑

人体六腑之中的三焦腑生理特殊，胃、胆、大肠、小肠、膀胱等五腑，都是有形有质的腑器，唯独手少阳三焦腑，在上肢有经脉路线，但在胸腹之内却没有腑器的形质，亦类似无形的十二经脉结构一样，在人体之内有它的实际功能但没有实体。根据三焦腑的独特生理而综合归纳认识如下。

1. 《灵枢·本藏》云“肾合三焦膀胱，三焦膀胱者，腠理毫毛其应”，手少阳三焦经虽然在上焦与手心主相协调表里阴阳的运行机能，但与下焦的肾脏和膀胱还有联络功用，经云“少阳属肾（是指手少阳三焦经而言），肾上连肺”，这充分说明手少阳三焦经实隶属于下焦的肾脏，并又牵连着上焦的肺脏，因肺脏主皮毛，故以上经云“三焦膀胱者，腠理毫毛其应”，由此说明手少阳三焦经与上焦和下焦都有联系，虽然未言及中焦而中焦亦包括在内，所以称之为三焦经。

2. 关于三焦腑病的症状。《灵枢·邪气藏府病形》曰“三焦病者，腹气满，小腹尤坚，不得小便，窘急，溢则水，留即为胀。候在足太阳之外大络”，故手少阳三焦经的合穴委阳与足太阳膀胱经相联系。

3. 手少阳三焦经与足厥阴肝经的“上巅顶之脉”和督脉的百会穴都有联系。如《灵枢·经别》云“手少阳之正，指天，别于巅，入缺盆，下走三焦”，根据以上将三焦经特别地喻名为“指天”之尊称，就足以说明手少阳三焦经在人体施行功用与其他五腑大有



不同。

4. 《素问·灵兰秘典论》云：“三焦者，决渎之官，水道出焉。”因肾属北方为“水脏”，与膀胱经相表里以施行化气行水利水道，如果没有心火下济于肾，肾脏即缺乏化气行水的蒸腾能量。三焦经与手心主相表里，主相火，并且因其手少阳属肾，所以手少阳三焦经能使心君之火向下转移入肾，以协助北方肾脏化气、行水、利水道，因此手少阳三焦经实是协助肾脏、膀胱之强有力的化气行水之腑。

5. 由于手少阳三焦经在人体内生理功能特别，故而给它以特别的“孤府”之称号。贫道认为这“孤府”的称号有两义：一是其他五脏五腑皆有阴阳脏腑配偶，唯独三焦腑无正当的配偶之脏，而重配偶于“手心主心包络”。二是三焦腑所施行功用与众不同而称它为“孤府”，因古代的皇帝才称孤道寡，故认为古圣人对三焦腑书以“孤府”的称号，是形容手少阳三焦经有统率人体周身上、中、下三焦之运输水道的特别功能，因人的生存全依赖阴、阳、水、火转输以维持生命。

6. 关于三焦经的病证表现。《灵枢·经脉》云：“是动则病耳聋浑浑淳淳，嗌肿喉痹。是主气所生病者，汗出，目锐眦痛，颊痛，耳后肩臑肘臂外皆痛，小指次指不用。”

如用针法治疗三焦经的疾病，当根据脉、证的虚实给予合理的调治。若用药物治疗三焦经的疾病，如果调平了脉口、人迎的寸、关、尺脉象，即是调治了三焦经疾病，因为手少阳三焦经与上、中、下各阴阳系统都有联系。



第十章 六淫致病与十二经脉

大自然界有风、寒、暑、湿、燥、火六种气候，随着春、夏、秋、冬更变运行。宇宙的正常六气，对大地植物的生长变化及人类和动物的成长变化都起到促进作用，人与自然界的气候是息息相关的，经云“天气下降，气流于地；地气上升，气腾于天。故高下相召，升降相因，而变作矣”。

人体内十二经脉的升降机能与天地同理，是相适应的。大地的人类，在天之下地之上的气交之中，故天地的升降之气就滋养着人体，只要人体健康，就是不正常的六淫气候也不易侵入人体，经云“正气存内，邪不可干”。如果不善于锻炼保养，操持过度嗜欲无限，致使身体亏损而体内失去了抗病能力，即使很正常的六气也会常常入侵人体而感染疾病，经言“邪之所凑，其气必虚”，所以对自身的修养和锻炼保健都是非常需要的。

《伤寒论》与《温病条辨》是中医界诊疗寒、温二邪之理论指导的规矩绳墨，在诊疗实践中的效果已受到医学界公认，是诊疗六淫之气的典籍。

伤寒病邪先伤足太阳膀胱经，足太阳膀胱经为三阳之表，循行人体的后背，属巨阳，主外表，主化气藏精液之腑，为三阳之父，经言“三阳为父”。手太阴肺经，乃百脉朝会之处，主外表皮毛，主司呼吸行气之脏，为三阴之母，经言“三阴为母”。因此，膀胱经和肺经为三阴三阳的父母，父阳是三阳的外表，母阴是三阴的外表。外邪袭人必先犯表，寒邪伤阳，温邪伤阴。经云“邪之所凑，



其气必虚”，故风寒之邪入侵，为父阳的阳气虚而致病，风寒之邪先伤足太阳经而次第传六经；风温之邪入侵，为母阴的阴气虚而致病，故风温之邪先伤手太阴肺经而次第由卫及营传上、中、下三焦，此为寒、温二邪致病的辨证规律。

暑、湿、燥、火伤人致病，虽然各有各的病证现象不同，其表里的症状表现都不出三焦与六经的范围。

一、风

风，在春季风木当令，气温上升，人若感染风邪，属温病为多，前贤言“夏至日前为病温，夏至日后为病暑”。《温病条辨》云：“太阴之为病，脉不缓不紧而动数，或两寸独大，尺肤热，头痛，微恶风寒，身热自汗，口渴，或不渴，而咳，午后热甚者，名曰温病。”风温热邪易损伤人体的阴液，治疗风温病初期宜用辛凉法解表，若病邪减退改用辛凉轻剂清理或佐以甘寒法继后治疗。如果温邪进入营分宜用清营等法，从血分理邪外出。风温之邪深入营分，利用现代医术静脉输液法疗效亦佳，由于液体之内配合以甘、咸、寒凉之品，恰好从血脉中熄灭温邪。

如温邪传入中焦化成温燥，宜用清热、增液等育阴法缓解；若温热邪燥甚而使大小便结者，当用消导法除邪。若患病多日阴分已伤而温邪深入下焦者，宜采用滋养下焦的阴液为治；如下焦出现滑泄虚脱者，兼用收摄法以固之。

经言“冬不藏精，春必病温”，《素问·金匱真言论》曰“夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温”，说明患温病之人阴精必定先已损伤，所以《温病条辨》中的一切治疗药方（除患湿性病证采用“温燥利湿法”治疗外）多以育阴养液法为治疗宗旨。治疗温病的诊疗法则，当参考《温病条辨》，恕不赘言。



二、寒

寒，寒冬季节有冰、雪、寒霜，寒风凛冽，悚骨清冷。如风寒犯人先侵入足太阳经，症状头痛项强，腰脊皆痛，发热恶寒，骨节疼痛，无汗，脉浮紧，为伤寒；若头痛发热，汗出恶风，脉象浮缓，为伤风。

经云“伤寒一日，巨阳受之，故头项痛腰脊强。二日阳明受之，阳明主肉，其脉侠鼻络于目，故身热目痛而鼻干，不得卧也。三日少阳受之，少阳主胆，其脉循胁络于耳，故胸胁痛而耳聋。三阳经络皆受其病，而未入于脏者，故可汗而已。四日太阴受之，太阴脉布胃中络于嗌，故腹满而嗌干。五日少阴受之，少阴脉贯肾络于肺，系舌本，故口燥舌干而渴。六日厥阴受之，厥阴脉循阴器而络于肝，故烦满而囊缩”，仲景医圣根据《素问》中的六经传变规律，通过潜心研究归纳，开创了对阴阳六经诊疗的辨证论治，拟定出对六经的正治方药和误治的解救方药。张仲景医圣的《伤寒论》药方与《金匱要略》药方，被历来医家一致公认为“众法之宗，群方之祖”，可称用药物治病的“万世师表”。

对伤寒病初期病邪在太阳经的治疗：伤寒身痛、脉浮紧无汗者，宜用发汗驱邪；伤风头痛发热、汗自出、脉浮缓者，宜用解肌和表除邪；如病邪传入半表半里之少阳胆经而寒热往来者，用和解法以调和表里；若病邪传入阳明胃经化为燥热伤津而汗出口渴、脉洪大者，用辛凉生津以清热；如邪气入里腑结不通，其两脉口脉沉实而大便燥结者，用消导等法除邪；如病邪深入足三阴经化为诸寒证者，用温热下焦回阳的四逆汤治疗。由于风寒之邪易损伤人体的阳气，故《伤寒论》中一切主治的药方（除特殊因寒化为燥热之症而采用寒凉甘润的治疗外）大多以温阳与存津液为治疗疾病的



宗旨。

贫道临床以来，见患伤寒传六经之病逐渐减少，可能与自然界的气候变化有关，不知北方严寒地区的病况如何。仅有极少数人在冬寒季节里感染伤寒传经，但病证表现仅见到足三阳经的表证为多，或是传入足三阳经的“腑里”而止。由此认为，风寒之邪不易传过足三阳经的界限而进入足三阴经，故实际传入足三阴经的病证极少。

贫道常见到素体本是“阴寒”之人，突然又遭受到寒凉的气候，或是由寒凉的饮食所导致而直中阴经（未经过三阳经的表证而直中阴经），其常见症状：发病突然，腹痛腹泻，甚则下利清谷，腹痛如绞，四肢厥逆，面色惨白，或面容青色全身寒悚，症轻者脉沉、小、迟、涩；症重者脉微欲绝，治宜回阳救逆。贫道常遇此症，缺乏中药救急时即采用西药：用盐酸肾上腺素 1mg 与硫酸阿托品 0.5mg 混合，再加入地塞米松更佳，用 5 号针头选取 3 个穴位注射，每个穴位各注入三分之一药量，先取左右阴陵泉穴针入五分深注射，后取气海穴针入三分深注射。采用此法救人甚多，回阳救急收效迅速。用药物在穴位上注射治疗后，一般 10 分钟左右即获捷效，最适合治疗突然脱阳直中阴经的阴寒之急症。因患者的体内气血未损，一得药物挥发回阳，病即痊愈。若是患病多日由伤寒六经的传变而传入足三阴而致厥致泄者，其身体的元阳已经受损，还当选用“四逆”回阳等方处治，或兼用温灸法亦可。

伤寒传六经的辨证和处方，不仅只为了治伤寒病而用，若研究六经的理法、方药，还可借鉴启发另化裁出治疗其他疾病的立方立法。例如《温病条辨》的诊疗法则，就是借鉴《伤寒论》道理，再以寒温两性相对立的观点而化裁出来的治病方法。伤寒传六经的详细诊疗内容，当参考《伤寒论》，恕不赘言。



三、暑

暑，盛夏季节天气炎热，暑气酷热熏蒸。人如在烈日之下劳动，或在高温场所工作，或在路途久行，都能导致中暑。常见症状：全身壮热，头痛心烦，口渴喜凉饮，身体蒸蒸发热汗出，甚则昏倒失知不省人事，治宜辛凉甘润。

亦有因元气素虚，又感染暑热湿气而发病，症状：恶寒发热，短气自汗出，头痛四肢酸软无力，脉当正运不及，治宜益气理湿清暑。

四、湿

湿，长夏季节主湿，湿为阴邪，湿性黏腻重浊。湿邪侵表症状：全身发热困重，四肢关节疼痛酸软，鼻息塞滞不利，语声重浊不清，治宜用温燥利湿法散表兼理湿。

脾土喜燥恶湿，内湿素盛之人脾受湿侵而导致湿由内生，或因思虑过多伤脾引起脾失健运湿由内生。内湿症状：四肢疲乏，饮食减退，消化不良，脘腹气机虚满不舒，时轻时重，大便溏稀，或小便不利甚则水肿，右脉口当沉涩，湿邪在里，治宜健脾利湿。

五、燥

燥，秋金主令季节，空气比较干燥，如果秋季久旱不雨，则燥气更甚，阴虚的体质易感染燥气生病。症状表现：头痛身热心焦躁，鼻干口渴，咽痛干咳，甚则大便秘结，小便短少，舌干齿槁无津，治宜滋阴润燥少佐辛凉，若无表证兼用酸甘化阴法治疗。

六、火

火，盛夏季节的炎气属火，夏季为阳气旺盛至极，阳气炳明主



升，火性上炎导致各类炎症。经云“诸逆冲上，皆属于火；诸躁狂越，皆属于火；诸热瞀瘵，皆属于火”，凡表现向上冲逆之病，热极昏瞀瘵痲之病，神志浮躁狂乱之病，皆属于火之为病。由于火之为病甚多，涉及各类疾病，应区别几类火的性质。属阴虚火浮者，治宜滋阴纳阳以熄火；属实火亢盛者，治宜用苦寒直折以灭火；属表里之郁火者，治宜用疏散通利以散火；属微火者，治宜用清凉运化以降火。



第十一章 运用十二经脉理论进行针灸治疗

第一节 概 述

《灵枢·禁服》所述内容证明，用针灸调治疾病必须恢复已失传的人迎动脉的诊断，才能遵照人体的手足阴阳十二经脉的盛衰表现，按阴阳有秩序、有原则地合情合理治疗，否则就不是遵照古圣人经典里所论述的有原则性的诊疗。

从《灵枢·禁服》所言可知，古圣们有先见之明，预知后来的子孙会将针灸的真理演变失传，因而非常关心这一门玄隐高深的针灸医理在历史过程中的演化。例如，先圣们按一倍、二倍、三倍的脉诊对号入座的诊疗圣法就失传了，子孙后代们真的没能继承下来，从而形成了当今的混乱现状。前圣云“一阴一阳之谓道”，人体的十二经脉均是由一阴经配合着一阳经所组成的生命机能及生理结构，此即人生之道。如果想研究人生之道阴阳十二经脉的针灸原理，首先必须恢复人体人迎脉的诊断，才能由浅入深地钻研阴阳十二经脉的理论，也才能为祖国的中医学术作出贡献。

在《灵枢·禁服》中，黄帝传授雷公针灸治病的诊疗医理是多么的神圣，有诚惶诚恐之感，必须要斋戒礼拜三日，并要割背歃血为盟，方可将玄隐高深的道理传授给后学，否则便不可以轻传。由此证明这是多么的神圣庄重啊，当启发后学定要振奋精神，认真领会、努力学习此篇至关重要的诊疗全文，从而在临床上改善患者的



疾苦，才不辜负古圣对我们的厚望，不辜负先哲们在经典上苦口婆心的谆谆教导。

《灵枢·禁服》的核心内容是诊察人体的脉口、人迎，以确诊脏腑阴阳经脉的不平，从而有原则性地补虚泻实，以调整脏腑阴阳经脉达到平衡。贫道通过对脉口、人迎的诊断研究，也对人体阴阳十二经脉理论进行了学术归纳。人体内阴阳十二经脉的运行，当左侧正运而右侧就反运，当右侧正运而左侧就反运；反运是协助正运，而正运也是协调反运的；所以，人体阴阳十二经脉的运行机能自始至终是既对立又统一的运行机理。

《灵枢·经脉》与《灵枢·禁服》原文可证，均要依靠诊察脉口、人迎来确定人体脏腑阴阳十二经脉的盛衰，从而采取有原则性的补虚泻实的调治，而今人迎动脉的诊断失传，就难以实现前圣们这一正确的诊疗方案了。因此，中医进程中的当务之急，当快速恢复人迎动脉的诊断而调治百病，只有运用古圣们最简要的诊疗方法才是对号入座，否则便难以执行前圣们阴阳圆满的诊疗规则。有幸的是，贫道发现了人体十二经脉最简捷的运行规律，将非常复杂的经络学的机能机理已简单化了，这也是上天的感应和机缘的巧合吧。古圣先哲们留传下来的医道天书，作为后代的子孙应非常感恩，一定要继承他们的简捷疗法。当前，我国正在提倡发扬祖国中医学，中医学的复兴前景光明，由此十分希望中医学界的全体同人共同努力，快速恢复失传已久的人迎动脉的诊断方法，让传统的中医学重放光彩。



第二节 临床典型病例

病例 1

患者：熊某某，男，29 岁，住公安县红专三队，于 1979 年 8 月 19 日就诊。

症状：2 天前起病，右侧乳下肋间内部疼痛，吸气时疼痛更甚，饮食及大小便均如常。

脉候：右脉口及右人迎的动脉升降往来均衡，左脉口动脉的往来也比较和平，仅感到寸部微显浮象，左人迎寸、关二部的脉象也不太盛，唯独诊得左人迎尺部脉现三倍沉大有力。经云“别于阳者知病处”，所以在脉诊诊断中凡是显现独特脉象之部位为患病之处。今患病者的疼痛在右侧，病脉现象却在左侧，遵照古圣人的教导，用右病取左的“巨刺法”调治，针刺左侧足三里穴，采取透天凉针法泻之，针完患者的疼痛消失。静息 10 分钟左右，复查患者左人迎的尺部动脉沉大有力之脉象消失转和。越三日走访患者，病未再发。仅取一穴而愈，实有一定的临床指导意义。此症若不诊察人迎脉，便难诊断病在何经，更难采用巨刺治法准确地调治，由此可见诊察人迎脉的重要性。《素问·阴阳应象大论》云“故善用针者，从阴引阳，从阳引阴，以右治左，以左治右，以我知彼，以表知里，以观过与不及之理，见微得过，用之不殆”，证明将来中医进化升华治病的原则，定要遵守古训，贫道治病的良好疗效就是遵守古圣教导所取得的成果。

病例 2

患者：严某某，男，67 岁，农民，于 1980 年 6 月 10 日就诊。



症状：患者陡然起病，经本地医生治疗无效抬送医院，行至中途患者昏迷失知若死状而返家，后苏醒请贫道医治。见患者不断呕逆，声大气粗，口角出涎沫，额两旁太阳穴处青筋暴露，貌若怒颜，眼睛呆视，汗出如珠，小便自遗，舌质淡少苔，面色红赤。

脉候：按理说盛夏季节及红赤面色应得洪脉，今诊候得左右脉口动脉将绝，仅关、尺部微微脉波似有若无；左右人迎的动脉盛大之象达到四倍，寸、关二部脉象特盛而尺部次之。

治疗：根据脉象，贫道认为患者的三阴经脉将绝并从足阳明胃经越轨脱出。虽然足阳明胃经之气盛不可遏，却不可用泻盛调治，应当急切拯救足三阴的机能运行以挽回欲绝之阴而固守脱越。故急用补针法取左右阴陵泉、三阴交穴，由于未备艾灸条，速燃香烟温针，同时用手指按压两足的内庭穴，以导引阳面的经气下降转入阴经。以引阳济阴为宗旨治疗 20 分钟后，患者的各症好转，病退大半，并能握着贫道的手致谢。复查患者两脉口的关、尺部脉波微增，但两寸部仍无脉；左右人迎的脉力虽减但还盛大搏指。停止治疗观察 20 分钟后，患者的病证复发如故，再诊察病者的阴阳动脉又复原来脉象。贫道寻思其三阴经不能正运而竭绝于内的根源，主要是在负运行时从足阳明胃经逆越上脱所致，决定第二次治疗采用强烈的火灸法猛转阳明胃经经气以进入足太阴脾经。仍遵引阳济阴以加强脾经为目的（还是在阴经取穴），取用棉布裹成约 1cm 条状，蘸麻油燃烧施灸。先灸右阴陵泉穴，后灸左阴陵泉穴，如此反复 3 遍，最后灸太仓（中脘）穴 2 遍，用直接灸法强烈刺激治疗约 10 分钟后病愈。复查患者脉象，两脉口的寸、关、尺三部脉出，两人迎之盛大脉象亦平。后走访患者病未再发，但灸疮发炎历经月余才愈。

体会：此病证贫道在临床中初见，发病急骤，病情危重，乃急



性大厥暴脱之症。《素问·调经论》云“血之与气并走于上，则为大厥，厥则暴死，气复反则生，不反则死”，此症开始就应当用强烈火灸法以猛转气机回厥治疗，故开始采用的温针补法是多余的施治。贫道如不明十二经脉的阴阳正负之圆活机理，定不能正确地在足太阴脾经取穴而挽救这一危症，若不通过脉口、人迎之阴阳脉象的盛衰确诊，也难以挽回这一危症。因患者的症状在外观表现上，如面色红赤、气粗、出涎沫、呕吐等，全属胃气上逆之证候，如果认为是胃气上逆而误取足三里穴来降逆和胃，此患者定会在针刺得气之时，使内侧微弱的足三阴经气向外绝尽而亡，就违反经典中所说的“五脏之气已绝于内，而用针者反实其外”的禁戒。所以救治阴阳暴脱之危症，犹如火车将要越轨，是在生死立判之际，施针灸者必当按照阴阳经脉之正负运行道理给予转化归正的调治，才能取得立竿见影之效。

此病案是贫道初次治疗大厥暴脱症，尚缺乏治疗经验，故第一次用温针法取三阴交穴是错误的取穴。因在当时认为，两脉口之阴脉将绝，温针三阴交能补充三阴经的经气。但之后醒悟到，三阴交穴位低于足阳明胃经之丰隆别穴的水平线，故属错误的取穴。理当取丰隆别穴水平线以上的脾经腧穴，如地机、阴陵泉、血海穴等，才为正确的选穴。故第二次用直接火灸法未取三阴交的穴位，仅取阴陵泉、中脘穴而治愈。这种大厥暴脱急症，若经过迅速救治患者必然死亡；但通过治疗若不能将盛经之气转归于虚经，亦必然死亡。所以拯救这种大厥暴脱之症，必须要根据脉口、人迎之阴阳脉象的特异盛衰现象而确定治疗方法。

病例 3

患者：董某某，男，28岁，浙江省雕刻工人，于1983年7月



15 日就诊。

症状：右睾丸疼痛、肿胀下坠，腰不能伸、伸即痛连小腹，舌苔薄白舌质淡红，患者发病后经西医治疗 4 天无效。

脉候：左脉口、左人迎的寸、关、尺三部的阴阳动脉出入升降相等，脉波现二倍宽度兼紧象；右脉口寸部浮紧而关、尺两部异常紧小，右人迎寸、关、尺三部脉沉而紧。历代医家论疝气病邪多在肝经，由于足厥阴的经脉“循股阴入毛中，过阴器，抵小腹”，今患者的阴阳动脉都现紧象，脉紧为寒，右脉口的尺部独显紧小脉象，故诊断为足厥阴的经脉受寒气侵袭而病。

治疗：采用艾条施灸治疗，先灸右侧的行间、大敦穴 10 分钟，次灸右侧的液门、关冲穴 2 分钟，艾火与皮肤表面的距离可近可远，以病人能够感到温热适宜为度。温灸之后当时复诊脉，觉得右脉口尺部的紧小脉象较前有所松缓。如以上艾灸法每日 1 次，治疗 3 天后，患者右睾丸的疼痛、肿胀逐日减轻，左右阴阳的紧脉象也逐日转化成缓象，最后经服一剂通经散寒行气利湿的中草药而收功。处方：土茯苓 20g，制川乌 5g，延胡索、乌药、青皮、川牛膝、炒橘核、川楝子各 10g，桂枝 9g，白茯苓 15g。一星期后随访，患者自告痊愈。

病例 4

患者：崔某某，男，18 岁，道教徒，于 1984 年 9 月 20 日初诊。

症状：4 年前因患黄疸型肝炎留下后遗症，4 年多来常感心热烦躁，左胁下满，时而腹痛，多汗口渴喜热饮，舌质深红苔微黄，大便正常，小便黄色，经过多方治疗无效而请贫道医治。

脉候：滑数，均呈一倍的动脉现象，唯独诊得左脉口之尺部滑



数有力，右人迎之尺部滑数有力，断定左侧的肝经有蕴热，右侧的胆经有余热。

治疗：采用泻针法调治，先取左侧的太冲穴，后取右侧的阳陵泉、丘墟穴。针后静息 10 分钟，复查患者的阴阳动脉，其左脉口之尺部、右人迎之尺部的滑数有力脉象均有减退。按以上用泻针刺法调治 5 次，患者感觉诸症悉除。复查患者左右脉口、人迎的脉象，阴阳四处的脉波往来和平。

病例 5

患者：钱某某，男，38 岁，住太子坡，于 1985 年 9 月 4 日初诊。

症状：患者自述于 1985 年 8 月 18 日发生疝气疼痛，两睾丸肿胀，经中西医治疗半月无效，医治期间，医生曾用艾灸大敦穴治疗亦无效，并且两睾丸肿胀增加、疼痛加剧。

脉候：左右脉口的寸部独现紧涩脉象，关、尺二部动脉缓和；左右人迎的尺部独现紧涩脉象，关、寸二部动脉缓和。

治疗：前人经验治疝气病用艾灸大敦穴疗效甚佳，但根据贫道灸大敦穴治愈多例疝气病的脉象情况，其脉口动脉之尺部多为紧涩、紧迟或紧细小等，今患者的左右脉口之关、尺二部动脉无紧象，可证明足厥阴经脉的下端无寒气凝滞；唯独在两寸部紧涩，证明足厥阴经脉的上端为寒所郁结；人迎动脉的两尺部紧涩，证明足少阳经脉之下端为寒凝阻；决定用灸法兼刺法调治。艾灸地五会、窍阴穴（双）各 3 壮，次灸玉堂穴 3 壮，膻中 1 壮，后针鱼际穴（双）行补针法留针 15 分钟。针后静息 10 分钟复查左右阴阳脉象，脉口的寸部、人迎的尺部之紧涩脉象转变缓和。

9 月 6 日复诊：经前日用针灸法治疗之后，患者的睾丸疼痛、



肿胀均减轻大半，诊察左右阴阳脉象，两脉口的寸部及两人迎的尺部之紧涩脉象大有好转，还呈现轻微的紧涩现象，复遵前法用针灸调治而愈再未复发。

体会：此病例调受病之足厥阴与足少阳，何以又针刺调肺经的鱼际穴呢？因为足厥阴肝经之支脉上通肺经，《灵枢·经脉》云“其支者，复从肝别贯膈，上注肺”，故取手太阴之鱼际穴以导引肝气通于肺经，可使肝经的经气流通无碍，亦与用辛味之药物疏肝同理，因辛味药品入肺反而能够疏肝。从脉认症按理施法，故获捷效。

病例 6

患者：赵某某，女，57 岁，朝山香客，于 1992 年 7 月 7 日夜诊。

症状：患者在道协旅社睡眠之后突然发生腹痛难忍、心胸不安，继而上吐下泻。

脉候：左右脉口的寸、关二部动脉往来明显，唯独两尺部涩滞少脉；右人迎的动脉尺大而寸小，左人迎的动脉寸大而尺小。

治疗：此乃阴阳气机运行失常而乱于肠胃，故表现以上脉、证。从足太阴经与足阳明经取穴用针法施治，取左右公孙、天枢穴，取右侧的人迎、左侧的足三里穴，共留针 25 分钟而诸症消失。静息 10 分钟复查阴阳动脉，两脉口与两人迎之寸、关、尺三部的脉象正反往来运行均衡。次日随访，患者言经针疗后诸症好转，仅泻过一次而愈。

病例 7

患者：魏某某，男，12 岁，住河南省新乡市，于 1995 年 8 月



16 日就诊。

症状：左侧面瘫，口向右歪，左眼闭合不全并流泪，饮食时舌不灵活，经本地医治 3 个月有余疗效不佳而前来武当道教诊所求医。

脉候：左右脉口三部的动脉往来和平，右人迎的动脉亦和，独诊得左人迎寸部的动脉大而坚强有力，显三倍的现象，经云“候虚实之所在者，能得病之高下”，证明病证与脉象都显现于左侧的上部。

治疗：采用针刺法以祛病邪，兼服“牵正散”为辅佐医疗。针刺左侧面部的四白、迎香、地仓、颊车穴，在得气的同时行泻法出针，出针时随即用中指弹针眼 5~7 下，令针眼流出一滴血为宜，或用手指挤压针眼出一滴血，若见流出的血色紫黑可令出两三滴血以泻病邪。每天针疗 1 次，经过 5 次用泻针法调治，其各症基本消除，在外观上只略有一点歪斜显像。复查左人迎寸部动脉，其大而坚强的脉象消失并趋向平衡。经曰“能知虚实之坚软者，知补泻之所在”，今据左人迎寸部动脉的坚实脉象而取治左侧面部穴位，用泻针法疗效甚速，说明按照古代圣人们对脉口、人迎之阴阳经脉的诊疗法则治疗，效果显著。2 个月后，患者的父亲前来相告，回家后 7 天左右面部的歪斜已恢复正常。

病例 8

患者：邓某某，女，76 岁，本山道协人员，于 1998 年 8 月 29 日就诊。

症状：患者右侧面部患三叉神经痛，痛处肿兼口腔溃疡糜烂，经西医镇痛消炎治疗 10 多天无效。

脉候：左脉口与左人迎的动脉往来均衡无异，但右脉口的动脉窄小，右人迎的动脉大三倍于右脉口，且尺部独显沉实有力。人迎



大三倍于脉口者，阳明经气太过而太阴经气不及也，当泻有余而补不足。

治疗：先取右阴陵泉穴行补法，后取内庭、陷谷穴行泻针法，经过1次调治后病减，再经过2次治疗痊愈，3次针法取穴相同。

病例9

患者：陈某某，男，25岁，武馆成员，于1999年11月12日就诊。

症状：自述近2个月以来，胃脘部胀闷不舒，特别是小腹部胀甚兼有微痛，由于食后增胀而饮食减少，甚至饮一杯茶水随即增加胀满，大便2~3日1次，便体干燥。经医院检查确诊为浅表性胃炎，使用雷尼替丁与胃复安药物治疗，服药后胃脘胀闷不舒缓解，但小腹胀满却依然如故。患者的舌质深红，苔白，舌中心微黄，按压小腹增加痛胀。

脉候：两脉口脉沉，现二倍宽度脉波，寸、关、尺三部脉力较平；两人迎脉浮，亦现二倍宽度脉波，但沉候重按两尺部脉独显弦劲搏指之象。

治疗：拟定取小肠经的合穴用针刺治疗，先取左侧下巨虚穴在得气时泻之，后取右侧下巨虚穴在得气时泻之，如上法调治2次，患者的小腹诸症已减去十分之七。复查病人的脉象，左人迎尺部的弦劲搏指之脉已缓解，唯独右人迎的尺部还呈现轻度的搏指之象，故第三次用针调治，独取右下巨虚穴以泻之，共调治3次，患者小腹胀满除、疼痛止、大便调而愈。后复查脉口、人迎的脉象，阴阳动脉和平无偏，随访2月病未发。

病例10

患者：刘某某，女，72岁，农民，于1999年12月15日就诊。



症状：脐下正中线腹胀满自觉有手掌大范围，脐下偏右有时产生疼痛，按压痛增，饥不欲食，食不知味，勉强进食还要用醋和辣椒配伍助食方能进少量食物，但食后即发生呃逆上冲并吐涎沫，大小便2日1次，舌暗苔厚，因条件有限病达30余日未治，现病情逐渐加重求治。

脉候：两脉口浮滑，寸部盛于尺部，两人迎动脉沉大却比两脉口更盛，显三倍宽度的脉波，唯有两尺部显沉实坚紧之象，阴阳脉诊皆现盛象，而患者并无表证，便确诊为实邪积聚所伤而病。

治疗：枳实12g，青皮7g，三棱10g，莪术7g，法半夏、陈皮各10g，厚朴、茯苓各15g，每日服1剂。经服上方5剂，患者每日大便2次，其呃逆上冲及吐涎沫有减轻，但脐下胀满及疼痛未减。自思患者本来大小便无阻，今增加排便而病证未退，此症并非是肠道阻滞之弊。凭人迎动脉三倍的盛象，可证足阳明经脉线上充实过盛，据胀满部位属冲、任两脉的范围，定是冲、任经脉的积聚所致。于是改用圆利针针刺治疗：先取石门、四满穴（双），后取上巨虚穴（双），均在得气时用泻针法泻之。经第一次针调治疗，次日患者自述，食物知味，觉腹内气转肠鸣。如上法用针调治7次，患者的诸症消失而安，复查阴阳动脉四处和平均衡，随访1个月病未发。

病例 11

患者：陈某某，男，70岁，住湖北枣阳市七方镇马武街，于2004年3月5日就诊。

症状：患者的次子小陈叙述病情说：“我父亲在2月28日早上起床，曾用半杯温水兑入半杯凉茶饮下，随即到屋后菜地里种菜，可是在到菜地的同时身体出了一阵冷汗，自觉周身无力不能劳动，



即回到房中卧床休息。等到吃早餐时，父亲失去了吞咽功能，不但任何食物不能下过咽喉，甚至连茶水也不能咽下一点一滴，我们全家人都觉得父亲的病证特殊，所以急将父亲送到枣阳市中心医院检查是何病证。通过医院安排的各项检查，均查不出异常现象和异常指标，难以确诊是何疾病，所以每天唯依靠用西药输液1~2次，以保护父亲的身体。用以上方法日复一日地点滴治疗将近1周，父亲之吞咽症状没有改善一点，经人介绍特来武当山道教诊所求医。”听小陈倾诉他父亲的起病及诊疗过程之后，可说这一病例是贫道数十年在临床上从未见到的奇症。因为一般进食困难的患者，虽然难进一般平常的饭菜，但能吞咽饮料及流质性饮食，可是陈老连茶水都不能咽下点滴，这种异常的现象可证明已没有吞咽的功能了。患者显出情急不安的苦愁面容，但能答复语言，神志清楚。根据贫道数十年对人体十二经脉之机能运行的研究心得发现，有些疾病在脉诊中能查出患者阴阳盛衰的不平，西医利用医科仪器也能在患者的形体上查出病因病灶，但是有个别疾病只在阴阳脉象上表现出阴阳盛衰的不平，通过现代医科仪器在患者的脏腑器官及头身四肢的形体上却查不出病因，陈老的疾病即是此类病型。既然现代西医用各项检测方法都查不出病因，便可证明该患者绝对不属有形有象器质上的病变，而是无形无象之十二经脉的机能病变，这便是现代医学的不足之处，陈老已经六七天不能吞咽一点饮食，这难道说是个健康正常不病之人吗？

脉候：两脉口的脉波均是关、尺部有脉而寸部无脉，左右人迎的脉波均显盛于上而不足于下；阴阳两方的脉象强弱对比，两人迎的阳脉要比两脉口的阴脉旺，并显出三倍的脉波。可证是脾胃二经不能运行到位所致，足太阴脾经之脉“上膈，挟咽，连舌本”，足阳明胃经之支脉“从大迎前下人迎，循喉咙，入缺盆”，由此认为



该患者的病因当是脾胃表里二经的机能紊乱失调，导致喉部吞咽失常。既然是属于阴阳经脉的机能失调病变，唯采取针刺的方法以转变脾胃二经的机能协调。可是《灵枢》言“已饥勿刺”，今患者接近一星期未进饮食，如用针刺治疗就违犯了禁忌条例。于是便与小陈商量：“你父亲的病证特别，贫道行医多年从未见到此症，没有治疗过的经验因而没有把握，也想不出其他治疗方法，唯决定用针法强刺激而背水一战以定吉凶，但是有效无效或者将会产生不良反应，必须由你亲属签字而承担一切责任，否则贫道不治疗。”小陈书写了字据愿意承担一切责任后，贫道便用针刺治疗：①取中脘穴，使脾经的运行机能到达结穴；②取左右足三里穴，使胃经的上盛之经气下达。在三穴轮流强刺激行补法约3分钟，其左右足三里穴的气感已下窜连至足背，而中脘穴也获得明显的胀感，即出针。随之复查患者阴阳四部的动脉，两脉口的寸部已出现了脉波，两人迎的尺部虽然有所充实，但左右人迎脉的寸部还是盛动搏指。因此，即取粗针刺入左人迎穴大泻之，又刺入右人迎穴大泻之，后以毫针取天突穴以疏通任脉。针完随即用大拇指和食指在患者左右人迎穴下提拿颈肌各3下，又站立患者背后，用中指猛拨左右缺盆内之筋肌两下。术完，即取高渗葡萄糖2支于杯中，兑入温开水适量，令患者强迫咽吞饮下。患者在强迫进行咽吞时，突然连呛带咳，随之接二连三地吐出了很多胶质性的痰液以及药水，患者咳嗽平静之后，却喜出望外，陈老能慢慢地咽下高渗葡萄糖水了，可证陈老在呛咳之际即恢复了吞咽的功能。此时见天色不早，建议他们父子俩在我们道教旅社住宿，以便观察此病有反复否。但小陈回答说：“我们是农民，经济条件有限，在你们道教诊所治病，虽然只买了一盒葡萄糖花了1元多钱，但我们承包的一辆汽车花费太大，必须连夜赶回家去。”因此，便不知患者之后的情况如何。直到2005年



农历二月，小陈给我们武当山道教诊所送来一面锦旗，锦旗的左侧写的是“赠丹江口市武当山道教诊所祝华英”，锦旗的中间书写的是“道医怀丹心，妙手施银针”，锦旗的右侧书写的是“枣阳市七方镇高集村马武街陈天顺2005年农历2月2日”。小陈介绍说：“我父亲自从通过针刺调治之后归家，一路平安而愈，再没用任何医疗。”贫道又于2006年11月16日前去枣阳市马武街走访，得见陈老依然健康，上病从未再犯。据此医案证明，对人体经络学说的研究是十分需要的。

第三节 针灸调治小结

—

贫道在钻研经络学的探讨中，用针灸治疗疾病常遵古圣的诊疗方针：①以脏腑阴阳之十二经脉的表里症状作辨证基础。②以诊察脉口、人迎来辨别左右、阴阳、上下的虚实作指南。③将以上两类理论体系相组合，拟定出调整阴阳经脉平衡的方法，所以其理论、诊断、治疗是有一定规律的。

《灵枢·卫气》云“候虚实之所在者，能得病之高下。知六腑之气街者，能知解结契绍于门户。能知虚石之坚软者，知补泻之所在”，这说明古圣们全凭脉与证相结合以辨别病人的左右、阴阳、上下、虚实，脉虚之处当用补法，脉实之处当用泻法。

上一节中的病例9、10皆是腹内胀满，遵守古训针对患者的脉口、人迎之左右、阴阳、上下、虚实的现象，有的放矢地施行或补或泻的针法调治，均能获得满意的疗效，证明古圣所倡导的这种有原则性之阴阳两方相对照虚实的诊疗十分正确。根据患者阴阳动脉



各有不同的现象，采用不同的调治方法而愈，证明针灸的治病取穴没有一定之规，但必须联系阴阳盛衰的道理。因此认为，用针灸调治百病，无论疾病的大、小、远、近，都必须遵从《灵枢》中的诊疗指示，一定要根据患者脉口、人迎之阴阳动脉的盛衰演变现象，拟定出随机应变的灵活选穴调治方法，才能契合古圣先哲有原则性的阴阳辨证施治。

针灸疗病的古今历史之演变概况：根据贫道 30 余年研究经络学的推理分析及设想，认为远古时期先哲们用针灸治病，深明人体之内十二经脉的阴阳运行机能规律。据《素问》与《灵枢》二经中种种有规律性的调治阴阳经脉的论述，即证明古时全是以阴阳十二经脉的基理为纲而调治百病，故经云“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起”，说明调治一切疾病，全是从宏观的以十二经脉为纲要，并注重结合脉口、人迎之阴阳脉象的太过与不及以确定脏腑、阴阳的虚实，从而拟定出有规律性的调治阴阳经脉的针灸方法。古时治病是以广义的阴阳道理为纲，执行狭义的有原则性的阴阳调治方案，纲举目张是具有一定的主次程序的。但后世针灸医者治病的最大弊端，一是十二经脉的真理失传，二是遗失了人迎动脉的脉诊，因此便失去了调整阴阳盛衰的指南，失去了有的放矢地施行阴阳补泻的针法，所以导致后世的针灸学术最注重的是在经验穴位的疗效上，认为某种病证应取某某经验穴，并立出了很多穴位的组方。贫道认为这种狭义微观的指导，虽然在临床实践中治好了某些疾病，却是繁杂无绪，且多属于以目去牵强附和着求纲，这就好比瞎子摸大象，各有自己不同的感觉和主观的验证，总结不出中医统一的真理，对人体阴阳十二经脉的宏观原理的理论指导研究毫无进展。贫道认为必须使宏观建立在微观的基础之上，使微观处于宏观的调控之中，才能胸有定见地来执行正确调



治阴阳经脉的原则，必须恢复古圣先哲们的诊疗方针，通过这种诊疗转变做起，来促进针灸学术发展并逐步升华。但贫道声明用针灸治病之复古的思想，并非是不赞同现代的先进新生事物。世界上一切事物的发展和进步，都是以先进的事物淘汰后进事物，它是通过各事物中之基本原理的规律一步步地进化发展和革新。因为古《灵枢》中之十二经脉的真相，就是利用现代高科技仪器亦难查出它的全貌，即证明十二经脉的运行机能是人体之内一种玄奥高深隐形的生命机能，是超时代性的一门学科。如要将经络学发展升华，首先当恢复古圣的诊疗方针以探讨掌握原始的道理，对古经典中所提倡的诊疗方法不可盲目遗弃，应在继承的同时，再结合现代的新认识加以逐步地提高和革新，如此将会使祖国的针灸医学、医药学进入一个新的领域。

二

贫道多年来在用针灸治病的实践中，定要根据阴阳脉象的盛衰现象来作针灸施治的补泻依据。脉象独盛之部，当是实邪处；独衰之部，即是虚弱处。

治疗实邪：当用泻针法治疗，调治之后静息片刻（约10分钟左右），应复查其盛坚脉波，如有减退现象为有疗效，经云“泻者益虚，虚者脉大如其故而不坚也”。若诊得依然像未经针调之前的盛坚脉波，为没有疗效。如果其病邪太甚，通过用针调治后，在当时复查脉象较以前减轻，但到次日查脉、证依然复反如前亦为有效，乃病邪太甚之故，持久执行泻盛调治，则病邪必然衰退。所以调治实邪，必须治疗到其脉、证不再复炽并达到阴阳和平痊愈。

治疗虚弱处：应用补针法治疗，经调治之后，当复查其虚弱脉波，如有增强现象为有疗效，经云“言补者，必然若有得也”。若



经调治后虚弱脉波依然如故，为无疗效。如果某阴阳经气虚甚，通过调治之后，在当时复查脉象有增强现象，但到次日查脉、证依然虚如以前亦为有效，乃该经太虚之故，持久执行补虚调治其脉、证必然恢复健康。故治疗虚弱处，定要调治到其脉、证不再退化并且充足为痊愈。

用针灸调治虚实等病，没有一定之规，而是以愈为度。用针灸法调治虚弱的经脉，又必须分清是阴经虚则阳经盛，是阳经虚则阴经盛，才可采用针灸法以补虚泻实来调和阴阳经脉。针疗时应遵古训，先补充其虚经、后泻其盛经以和之。如果诊察患者的阴阳脉象双方平均下降衰退，即不应当采取针法施治，经云“阴阳形气俱不足，勿取以针，而调以甘药也”，故阴阳经气双虚的病人，当用甘温药以补充阴阳气血，若强行用针刺法治疗，易导致晕针或不良后果。

三

上一节中的病例，有的是多年前贫道初发现十二经脉机理时，在缺乏现代医疗设备的条件下，用土方土法按十二经脉的道理进行针灸施治，疗程期短，治法简要，易于记住，也是贫道在临床中所遇见的普通病例，因依据十二经脉的正负机理来调治患者的左右、上下、阴阳偏差，所幸皆获良效。

多年来贫道在临床上医治了以万计的病人，其中许多是疑难病证，因以十二经脉的阴阳正负机理作总纲而灵活化裁治疗，多取得良好效果。实践证明，利用十二经脉的正负机理调治疾病良效无比。《灵枢·卫气》曰“能别阴阳十二经者，知病之所生。候虚实之所在者，能得病之高下。知六府之气街者，能知解结契绍于门户。能知虚石之坚软者，知补泻之所在”，所以贫道在临床上十分



遵从上古圣人的旨意诊疗疾病，十二经脉运行的道理对于证候、诊断、治疗都十分重要。根据贫道长期以来的探索经验，用针灸治疗疾病不赞成墨守成规的取穴处方，应该依据十二经脉的阴阳运行现象差别，拟定出随机应变的灵活取穴方案。诊察到十二经脉的机变，其法亦变，才契合真切的诊疗规则。总之，要与人体之内的阴阳运行机能相协调，就能获得良效。



第十二章 运用十二经脉理论进行推拿按摩治疗

运用十二经脉理论进行推拿按摩治疗的辨证论治方法大体与针灸相同，下面仅举几个病例予以说明。

病例 1

患者：罗某某，女，72 岁，住武当山，于 1995 年 11 月 23 日就诊。

症状：患者因误吃食物引起上吐下泻，兼腹痛，经用西药治愈，但在后来常复发腹痛甚剧，腰不能伸，腰曲压腹，痛苦呻吟，当腹痛发作时不能食物并常如厕，有便无便亦然，用药物治疗只能缓解疼痛，但经过数日又发腹痛，其症状表现每次相同。

脉候：两脉口的寸部有余而尺部不足，两人迎的寸部浮躁有余而尺部不足，阴阳两方脉波的宽窄度相等。凭脉波的表现，证明正运有余、负运不及。

治疗：采用按摩逆治法调整阴阳气机，先取下肢左右内侧的足三阴经，从膝至足内踝由上及下，用推、摩手法着重点按三阴交穴位，并相继握着患者的足大趾用摇扯法以疏导经气（以上法先取右后取左），次取上肢左右外侧的手三阳经，由肘关节到腕关节用按摩手法从上及下，并按点合谷、后溪、外关等穴位（先取右后取左）。以上用按摩手法施行 25 分钟反复运用 3 遍后，患者的腹痛大减。复诊察患者的脉口、人迎动脉的阴阳寸、尺之有余与不及差别已转变平均。次日患者的阴阳脉象又有退化，连续用以上按摩逆调



手法治疗3次，患病者的脉、证痊愈。追访3月，未有再发腹痛。

体会：《灵枢·小针解》云“知其往来者，知气之逆顺盛虚也”，此病例乃阴阳两方正运偏盛、负运不及而形成的腹痛疾病，利用按摩推拿施行逆调的治疗手法收效甚佳，可证明按十二经脉正负机理的逆顺立法治疗十分正确。《小针解》又云“明知逆顺，正行无问者”，是教导后世医者在脉诊诊断中，如果查明了十二经脉阴阳运行的逆顺偏差，即当正确地、毫无疑问地去执行或逆治或顺治的医疗方法，所以经云“凡将用针，必先诊脉”，是由于人体十二经脉的内在正负、盛衰机能不可能在表面见到，唯有从脉口、人迎的正负脉波来诊察出它的盛衰逆顺现象，才能做到有的放矢地去施行顺、逆的调治规则。观有的前医对有关顺逆、迎随等医疗立言，多是根据“手之三阴从胸走手，手之三阳从手走头，足之三阳从头走足，足之三阴从足走腹”之正运道理而立论，如果知道十二经脉还有负运机能，肯定就不会说出那种无立场的论点。《灵枢·小针解》中论顺逆诊疗原则，是指诊察阴阳动脉的顺逆现象，必当先了解到阴阳脉象的虚实、顺逆，然后才能决定出逆顺原则的选穴配方。用按摩推拿治疗与用针灸治疗的诊疗道理相同，如不通过脉诊的诊断而进行按摩推拿治疗，不当之处亦是难以避免的。

病例2

患者：李某某，女，42岁，住武当山，于1996年9月5日就诊。

症状：患者自述近半月以来，胸腔内不安，并觉有气聚结胸之感，头昏目眩，两目不敢向上看，如向上看即昏晕欲吐，喜静恶动，静卧于床症状减轻，但一起床即产生头昏目眩恶心欲吐。

脉候：左右脉口两寸部皆现涩象少脉，关、尺两部的脉波明



显，两脉口寸、关、尺三部的脉波显出下宽上窄之象；左右人迎的脉波两尺部现涩象少脉，寸、关两部的脉波明显，人迎寸、关、尺三部的脉波现出上宽下窄之象。从阴阳脉波的宽窄度平等，可证明阴阳两面无偏盛偏衰之弊；左右脉口之寸部的脉涩，可证明阴经之气阻塞于内不能正运出外，故结聚于胸中；左右人迎之尺部的脉涩，证明乃阳经之气阻隔于外不能正运下达，所以昏眩上冒。

治疗：采取按摩推拿治疗法，以调整阴阳的经气。①从右侧手三阴经脉由肘至手采用摩法与推法，并按点鱼际、内关、劳宫等穴位；②左侧手三阴经的调治与右侧相同；③右侧足三阳经脉由膝至足亦采用摩法与推法，兼用提拿解溪穴处，并按点阳陵泉、足三里、内庭等穴位；④左侧足三阳经的调治与右侧相同。如上法经过40分钟反复调治3遍，患者即感到各症减轻。随即复查脉象，两脉口的寸部及两人迎的尺部之涩象有转变而脉波微增。按以上治法每天按摩推拿1次，经过5次调治患者的诸症悉除而痊愈。

体会：用按摩推拿治法，亦可配合于针灸疗法之中，能相互起到协调阴阳经脉的作用，特别对老年人、儿童、体质虚弱患者及畏针怕痛患者的治疗均十分适宜，对左右、阴阳经气不虚而又升降不平或阴阳偏有盛衰的治疗也十分有效。



第十三章 运用十二经脉理论进行药物治疗

第一节 古代名方与药物归经

根据十二经脉阴阳、正负的道理，结合临床实践经验，贫道简要地分析了历代 19 个名方的主治病证、药物作用以及对调整患者体内三阴三阳左右、正负运行的功能。

一、四君子汤(《兰台轨范·通治方》)

治面色萎白、言语轻微、四肢无力、脉来虚弱者；若内伤虚热或饮食难化，须加炮姜。人参、白术、茯苓、甘草各二钱（6g），加姜枣水煎服。徐灵胎曰：“此补脾之主方。”

四君子汤主治四肢无力、消化不良。贫道认为此方的药物作用主要是补助右侧足太阴脾经的正运功能，脾土衰弱不足以生肺金而致气虚者宜之。

方中白术为健脾胃之要药，其性味苦、甘、温，苦能燥湿，温能补脾；甘草性甘、平，甘入脾；人参性味甘、微苦、微温，入脾达肺，大补元气；茯苓性味甘淡，渗湿健脾。此方四药皆有甘味，甘味能入脾，故为补脾之主方。四药合起来其药性甘温和平，故名四君子，大有补脾、益肺、健胃的效果。

二、理中丸及汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治霍乱、头痛、发热、身疼痛、寒多不用水者，理中汤；若大



病瘥后喜唾，久不了了，胃上有寒者，用理中丸。人参、炙甘草、白术、干姜各三两，上四味捣筛为末，蜜丸如鸡子黄大，以沸汤数合和一丸研碎，温服之。日三服，夜二服，腹中未热，益至三四丸，然不及汤。汤法：以四物依两数切，用水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。徐灵胎曰：“四逆乃温下焦、中焦之法，理中为温上焦、中焦之法，各有部位也。”

理中丸及汤主治脾胃虚寒、霍乱腹疼呕吐或久患虚寒腹痛、大便溏等症。贫道认为其药物作用主要是温中散寒，具有正运右侧脾经的功能。理中丸适宜于长期患慢性脾胃虚寒证；理中汤药物发挥迅速，适宜患急性脾胃虚寒证。人参、甘草、白术为补脾健胃的良药，佐大热大辛的干姜以温中散寒，因脾土气虚导致功能反馈而腹痛腹泻者，宜服此方以升举中宫脾土，故名理中丸。

三、四物汤(《兰台轨范·局方》)

治一切血热、血虚、血燥诸症。当归、熟地各三钱，川芎一钱五分，白芍二钱酒炒，上四味，水煎服。徐灵胎曰：“此血病之主方。”

四物汤主治人体左侧的肝经血虚、心血不足或妇女的月经不调、经期腹痛等症。贫道认为此方的药物作用，具有补助左侧足厥阴肝经的正运行功能。

方中熟地性味甘温，以滋补养血；当归性味辛甘，合白芍归经入肝，既可补肝养血，又可行血活血；川芎气芳香辛温，能辛散温通血液中的凝滞，为血中之气药。此方四药配伍，共同补血养肝，使肝木的血液旺盛则生心血亦旺，故四物汤是调治一切血病的主方。



四、佛手散(《普济本事方》)

治妇人妊孕五七月，因事筑磕著胎，或子死腹中，恶露下，疼痛不止，口噤欲绝，用此药探之。若不损痛止，子母俱安。若胎损立便逐下，此药催生神妙。当归六两、川芎四两，上粗末，每服两钱，水一小盏，煎令泣泣欲干，投酒一大盏，止一沸，去滓温服，口噤灌之。

佛手散主治产后血虚头痛、胎动下血，催生神效。贫道认为此方长于补血行血，使血液运行上升，具有正运左侧肝经的功能。①由于妇人产后失血，易导致血液循环不足而头痛，川芎善于上行治头痛，当归长于补血行血，故此方治产后血虚头痛。②因动作过度而动胎，或血虚不足以养胎，不足之血易于由下方子宫大出血流出，可能导致堕胎，故用当归、川芎补血并升血，使下行之血转化上升，则下血可止而胎动可安。③妇人十月怀胎，血液供养胎儿，如血虚不足易导致难产，皆血少涩滞之故，所以用此方补血行血，以增强血液循环流行，使涩滞而转变滑腻，胎儿能得到滑腻即可出生，故催生神效。但是当归与川芎组合其性辛温，温能通，辛易散并易上行，故左脉口之寸部脉浮、脉滑、脉大者忌用。

五、小柴胡汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治少阳中风、往来寒热、胸胁苦满、心烦喜呕、腹痛心悸、头汗出、舌上苔白及妇人热入血室等症。柴胡半斤，黄芩、人参、甘草各三两，半夏半升（洗），生姜三两（切），大枣十二枚（擘）。上七味，水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，取三升，温服一升，日三服。若胸中烦而不呕，去半夏、人参，加瓜蒌实一枚；若渴者，去半夏，加人参，合前成四两半，瓜蒌根四两；若腹中痛者，



去黄芩加芍药三两；若胁下痞鞭，去大枣加牡蛎四两；若心下悸、小便不利者，去黄芩加茯苓四两；若不渴、外有微热者，去人参加桂枝三两，温覆取微汗愈；若咳喘者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升、干姜二两。徐灵胎曰：“此方加减法，须细审。”

小柴胡汤主治寒热往来、晕眩口苦、心烦喜呕、胸满胁痛等证。贫道认为此方的药物作用主要是疏理中焦，有协助左肝右脾正运上升与胆胃二经正运下降的作用。

方中柴胡药量最重为君药，其性味辛凉以疏理左侧的肝经之气；人参、甘草、大枣为臣药，三药性味甘温以入右侧补脾益气，可促进中焦左肝右脾正运能量上升；半夏、生姜、黄芩三药为反佐，以助胆经、胃经的正运机能而降逆止呕吐。

本方乃旋转人体左右阴经上升，并使左右阳经下达，使半表半里之邪在阴阳旋转的运行中而自行消失，故曰“和解法”。唯有深明人体阴阳旋转之机，才能立出阴阳旋转之方，故后世称仲景为医中之圣。

六、逍遥散(《兰台轨范·局方》)

治肝家血虚火旺、头痛目眩、颊赤口苦、倦怠烦渴、抑郁不乐、两胁作痛、寒热、小腹重坠、妇人经水不调、脉弦大而虚。芍药（酒炒）、当归、白术（炒）、茯苓、甘草（炙）、柴胡各二钱。本方加丹皮、栀子，即加味逍遥散。加煨姜三片、薄荷少许，煎服。徐灵胎曰：“此疏达肝脾之方。”

逍遥散主治中焦郁结、胁下胀满、头痛目眩等症。贫道认为此方的药物作用主要是疏达左肝右脾，使左右阴经正运上达畅通以解除中焦的郁结。

方中柴胡、当归以疏左侧肝经，以白芍柔肝，三药协同养血疏



肝；白术、甘草以补充右侧的脾经，佐茯苓以渗中湿；生姜味辛、薄荷辛凉轻扬，既能温中又可疏肝；共同作用能够疏肝健脾，使左右中焦畅通无阻，肝脾的郁结自愈。郁之为病，为情志蕴结于中而不畅，故易于伤肝，但情志常郁必有苦思而不能自控，故思多又伤脾。此方为疏肝达脾之方，故善于治郁。

七、麻黄汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治太阳中寒、头身俱痛、发热无汗、恶风而喘。麻黄三两（去节），桂枝二两（去皮），甘草一两（炙），杏仁七十个（汤泡去皮、尖）。上四味，以水九升，先煮麻黄减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升半，去滓，温服八合，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

麻黄汤主治伤寒脉浮紧、表实无汗症。贫道认为此方的药物作用，主要是升举足太阳经透发表皮的闭塞，因足太阳经为寒邪束表，导致肌表郁闭不和，周身疼痛。用麻黄、桂枝之辛温药以开发周身的毛孔，用甘草以和中，用杏仁之苦温药为反佐以下降利导气机，有旋转阴阳的运行作用。仲景医圣的立方，药物组成虽少，但用阴阳两性药物恰当配合，以调整人体的阴阳升降功能，故其疗效十分显著，足太阳经伤寒、头身疼痛、表实无汗、恶风而喘、阴阳动脉皆现浮紧者宜之。

八、桂枝汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治太阳中风、头疼发热、汗出恶风。桂枝三两（去皮），芍药三两，甘草二两（炙），生姜三两，大枣十二枚（擘）。上五味咬咀，以水七升，微火煮取三升，去滓。适寒温服一升，服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，通身皦皦微似有汗者



益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病瘥，停后服，不必尽剂。若不汗，更服，依前法。又不汗，后服当小促其间，半日许令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服。若汗不出者，乃服至二三剂。禁生冷、黏滑、肉、面、五辛、酒酪、臭恶等物。徐灵胎曰：“此服外感风寒之药，服法俱当如此。”

桂枝汤主治太阳中风、脉浮缓、头痛发热、汗出恶风等症。贫道认为此方用白芍入阴经负运内敛阴血以调营，并协助桂枝由足太阳经负运上升而卫外，生姜、大枣、炙甘草益脾胃以和中，共同起着调和营卫、解肌发表、扶正祛邪的作用。

九、葛根汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治太阳病、项背强、无汗恶风者，又治太阳阳明合病、自下利者。葛根四两，麻黄三两（去节），桂枝二两（去皮），芍药二两（切），甘草二两（炙），生姜三两（切），大枣十二枚（擘）。上七味咬咀，以水一斗，先煮麻黄、葛根减二升，去沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息及禁忌。

葛根汤主治太阳阳明合病、无汗恶风症。贫道认为此方的药物作用，主要是对被寒邪闭塞的足太阳经皮腠并兼被风寒之邪传入的足阳明胃经进行透发。因还有太阳经病证，故还当用桂枝汤药品；因表实无汗，故采用麻黄以发散驱除太阳经表邪；因邪入足阳明经，故采用葛根以散发胃经的表邪。足三阳经患病虽皆主外表，但足太阳经为表中之表，而足阳明胃经为表中之里。经云“太阳为开，阳明为阖，少阳为枢”，故风寒病邪传六经是有层次递进而由表入里。综合《伤寒论》中麻黄、桂枝、葛根汤三方，皆因有外邪



在表，故以上三方的药物作用，都是从阳经发挥其负运行功能以祛除外邪。

十、四逆汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治脉沉体痛、温温欲吐、下利清谷、手足厥冷、内寒外热、脉微欲绝等症。甘草二两（炙），干姜一两半，附子一枚（生用，去皮，破八片）。上三味咬咀，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚、干姜三两。徐灵胎曰：“四逆汤不可轻用，一症不具即当细审，必诸症皆全，方可决用无疑。”

四逆汤主治脉沉体痛、温温欲吐、下利清谷、手足厥冷、内寒外热、脉微欲绝等症。贫道认为此方的药物作用，主要是温暖足少阴肾脏和足太阴脾脏发挥正运行功能。因三阴经受气于五脏，三阳经受气于四末。人体内的五脏乃生命能量之发源处，故五脏为本。六腑却是在手足四肢禀受五脏所输送出来的能量，故六腑为标。如果病人产生手足厥冷、下利清谷、脉沉、脉微、脉迟等症，就证明足少阴肾脏的命门之火即将熄灭，故当急用四逆汤回下焦之阳，以巩固生命之根本。

中医处治一切疾病的规则：皆当先治表证，后治里证。若见下利清谷、四肢厥冷、脉微欲绝等症，便知人体的生命能量本源机能将绝，故病人虽有外表病证，此时此际急当舍表救里，使先天之本肾脏得到阳回而生气已足、脉波增强时，再来治理表证。

十一、真武汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治太阳汗出不解、仍发热、心悸头眩、身瞤动、振振欲擗地者；又治少阴至四五日、小便不利、四肢沉重疼痛、自下利，此为有水气。茯苓、芍药、生姜各三两（切），白术二两，附子一枚



(泡去皮，破八片)。上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。若咳者，加五味子半升，细辛、干姜各一两；若小便利者，去茯苓；若下痢者，去芍药加干姜二两；若呕者，去附子加生姜，足前成半斤。徐灵胎曰：“此治水逆之正方。”

真武汤主治心悸头眩、身振悸动、水气凌心、小便不利等症。贫道认为此方的作用，主要是负运左侧的三阴经，正运右侧的三阴经。①治“太阳汗出不解、仍发热”。病在足太阳经，其治法当以发汗祛邪。通过发汗治疗后还发热（经发汗其风邪当祛而湿邪仍在故发热），此患者平时必肾阳衰弱、体内寒湿素盛，所以用真武汤利水除湿。②治“心悸头眩、身悸动、振振欲僻地者”。贫道常见肾阳衰弱的患者，化气行水之功能不足，故而阴寒水盛，水气太盛则克火以凌心，导致心悸头昏、嗜卧，行动时则筋惕而肉悸动，甚则全身皆振振战栗而动，舌质淡红苔白润，面部微肿色白鲜明，脉波较弱，左脉口浮象，右脉口沉象，左人迎有浮脉亦有沉脉，右人迎有沉脉亦有浮脉。真武汤中之芍药入左侧负运足厥阴肝经，使凌心之水气就下；附子温足少阴肾经之阳，使肾阳振奋有化气行水之功能；白术入右侧正运足太阴脾经，以助燥湿行气上达右肺；茯苓入左侧负运手少阴心经，使凌心之水下达由小便而出，形成一个左降右升、圆周旋转化水行气之方；更兼一味生姜辛散温通，能散内寒、温水气以协助四味药物旋转左右之正负运行，故能疗以上水气凌心诸症。③治“少阴至四五日、小便不利、四肢沉重疼痛自下痢”等症。肾阳虚弱无能化水，导致水气阻滞小便不利；脾土衰弱则燥湿无能，脾失健运故自下利；脾主四肢，因脾脏燥湿的功能衰弱，故引起四肢沉重疼痛；所以亦需要用真武汤以化水气、祛寒湿治疗。以上三类疾病，全属阴寒水盛湿盛之症，故当用真武汤以治之。真武乃北方水神，善于治水，故仲景医圣特以此善于治水之神



而名之。真武祖师于武当山修真得道，是贫道最崇拜之尊神，故而对真武汤详细剖析。

十二、大分清饮(《成方切用·景岳方》)

治积热秘结、小便不利，或致腰腹下部极痛，或湿热下利、黄疸、溺血、邪热蓄血、腹痛淋闭等症。茯苓、泽泻、木通各二钱，猪苓、梔子、枳壳、车前子各一钱。如内热甚者，加黄芩、黄柏、龙胆草之属；如大便坚硬胀痛者，加大黄二三钱；如黄疸小便不利、热甚者，加茵陈二钱；如邪热蓄血腹痛者，加红花、青皮各一钱五分。

大分清饮主治上焦积热蕴结、湿热黄疸、小便淋闭不利等证。贫道认为此方的药物作用，主要是正运足太阳膀胱经而下降通利。方中茯苓、泽泻、猪苓、木通、车前子皆是由上焦下降通利小便之药，佐以破气消积滞之枳壳导湿下行，以梔子苦寒清降，并善能除上焦湿热郁结以导湿热下行，共同起着消上焦的积热蕴结、黄疸与小便淋闭不利等症。

十三、小分清饮(《成方切用·景岳方》)

治小便不利、湿滞肿胀、不能受补等症。茯苓、泽泻、猪苓各二至三钱，苡米仁二钱，枳壳、厚朴各一钱。如阴虚、水不能达，加生地、牛膝各二钱；如黄疸者，加茵陈二钱；无内热而寒滞不行者，加肉桂一钱。

小分清饮的药物作用与大分清饮同理，皆是正运下达通利小便之方，但有所不同的是：大分清饮是治上焦湿热蕴结之重症，小分清饮是治上焦湿热蕴结之轻症。

以上景岳之大、小分清饮的立方，乃是从仲景医圣之五苓散方



中化出，五苓散乃化湿行水利小便之圣方。如属脾土虚无能正运上达，或属足太阳经化气不足而引起小便不利者，还当采用五苓散方以培土通利膀胱水道。

十四、平胃散(《兰台轨范·东垣方》)

治湿淫于内、脾胃不能克制、有积饮、痞膈、中满者。苍术五斤(米泔浸七日)，陈皮(去白)、厚朴各三斤(姜汁炒)，甘草三十两(炙)。上为末，每日服二钱，姜汤下，日三服，或水煎，每服五钱。如小便赤涩，加茯苓、泽泻；米谷不化，饮食伤，多加枳壳；胃中气不快，心下痞气，加枳壳、木香；心下痞闷、腹胀者，加厚朴，甘草减半；遇夏，加炒黄芩；遇雨水湿润时，加茯苓、泽泻；如有痰涎，加半夏、陈皮；咳嗽、饮食减少、脉细，加当归、黄芪；脉洪大缓，加黄芩、黄连；大便硬，加大黄三钱、芒硝三钱，先嚼麸炒桃仁烂，以药送下。本方加皂矾，即皂矾平胃丸。徐灵胎曰：“消食积、虫痞。”

平胃散主治胃腑积饮积食、痞膈中满、脾受湿困，右脉口脉沉，正运脉波不能达到寸部。贫道认为此方的药物作用，主要是正运右侧足太阴脾经上升，正运足阳明胃经、手太阳小肠经、手阳明大肠经下降以消导，乃消除胃肠道积聚之方。

方中苍术味辛性温，芳香气烈，善能除湿发散，为燥湿健脾之良药，因配合甘草，便有辛甘化阳除湿之功；厚朴性温芳香，能化湿、温中、宽肠、理气、散满，兼有陈皮之芳香药能理气、和中、健胃、化痰湿，故能化湿、理气散满以和中；甘草佐苍术能促进右侧之脾经升清于上；陈皮辅厚朴能协助胃腑降浊而下达大、小肠。脾宜升则健，胃宜降则安，所以胃肠道的湿浊邪气或饮食积滞，能随着脾胃的阴阳健运而平息，故名之曰平胃散。此外，对与之有关



的其他症状表现，还当参考此方中的对症加药。

十五、大承气汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治伤寒十余日，吐下后不解，晡时发潮热，独语如见鬼状，循衣摸床，胃中有燥屎也，此下之。大黄四两（酒洗），厚朴半斤（去皮，炙），枳实五枚（炙），芒硝三合。上四味，以水一斗，先煮二物取五升，去滓，纳大黄，煮取二升，去滓，纳芒硝，更上微火一两沸，分温再服，得下，余勿服。徐灵胎曰：“胃中非存燥屎之所。此言胃中者，指足阳明言，即所谓胃中实是也，乃肠胃之总名。”

大承气汤主治阳明腑实证。贫道认为此方的药物作用，主要是由胃肠道发挥正运行以峻下热结。大黄性味苦寒，以消除胃肠道之实热结聚；芒硝寒咸，以软化胃肠道之燥坚；枳实、厚朴以消除胃肠道痞满；共同起着峻下消积清热通大便之功。前贤云：“通可去滞，泻可去闭，使塞者利、闭者通而正气得舒，故曰承气。”

胃为五脏六腑之海，纳饮食物质以营养内外周身。小肠与大肠有运行转输、吸收营养、排出糟粕以运行新陈代谢的功能。如胃肠道为燥、实、坚、满之热邪阻塞，特别是大肠有燥屎阻塞，就导致全身的阴阳气机运行受阻，并使内外周身的营养供给亦受限，故当急通胃肠道之闭塞以利内外周身。

十六、小承气汤(《兰台轨范·伤寒方》)

治汗多、微发热、不恶寒，或小便数而大便鞭、谵语者，与此汤微和胃气。大黄四两，厚朴二两（去皮，炙），枳实三枚（炙）。上药三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服。初服汤，当更衣，不尔者，尽饮之；若更衣者，勿服之。



小承气汤主治阳明腑实证。贫道认为此方的药物作用大致与大承气汤相同，也是泻下通便之方。因其在药物功能上次于大承气汤，故所治之疾病的病证也比大承气汤的病证要轻。由于胃肠闭塞或不畅通的原因较多，病情有轻重缓急之异，而虚实寒热皆可导致，所以运用攻里泻下之方亦多，有峻下、缓下、寒下、温下、润下，或攻补兼施以通利，故当根据脉、证情况选择适当的泻便药方。

十七、补中益气汤(《兰台轨范·东垣方》)

治阴虚内热、头痛口渴、表热、自汗、不任风寒、脉洪大、心烦不安、四肢困倦、懒于言语、无气以动、动则气高而喘。黄芪(炙)、人参、白术(炒)各一钱五分，甘草(炙)一钱，陈皮五分，当归一钱，升麻、柴胡各五分。上八味，加生姜三片，大枣二枚，水煎温服。徐灵胎曰：“东垣之方一概以升提中气为主，如果中气下陷者，最为合度。若气高而喘，则非升、柴所宜，学者不可误用也。”

补中益气汤主治四肢倦怠、自汗口渴、少气懒言、动则气喘、脉虚软无力；两脉口动脉正运时难以达寸，中气下陷则上焦气虚，上焦气虚不固则易导致久泄、脱肛、子宫下垂等症。贫道认为此方的药物作用，主要是提升人体左右三阴经的正运行能量。

方中黄芪、人参、白术、甘草、升麻侧重于归右；当归、柴胡侧重于归左；因归右的药物量多，故对人体右侧之能量补助提升甚强，因归左的药物量少于右侧，故对人体的左侧之能量补助提升则次于右侧；方中陈皮和中，气虚下陷而右侧气虚甚于左侧者宜之。凡是补助上焦三阴经的药方，皆能促进十二经脉正运功能。



十八、崔氏八味丸(《成方切用·金匱方》)

治命门火衰、不能生土，以致脾胃虚寒、饮食少思、泄泻腹胀或元阳虚惫、阳痿精寒、脐腹疼痛、夜多漩溺、膝酸腰软、目昏等症。王冰所谓益火之源，以消阴翳也，尺脉弱者宜之。熟地黄八两，山萸肉、怀山药各四两，茯苓、丹皮、泽泻各三两。

崔氏八味丸在下焦滋阴壮阳，引火归源，故曰“益火之源，以消阴翳”。贫道认为此方的药物作用，具有负运人体左右之三阴经脉的功能。方中熟附子、肉桂大辛大热，温肾壮阳以补肾气，熟地、山萸肉、丹皮、怀山药滋养下焦肝肾以补肾阴，茯苓、泽泻以渗湿利水，共同起着滋肾阴壮肾阳的作用，是填补下焦之阴虚阳衰的主要方剂，肾精亏兼命门火衰者宜之。

十九、六味地黄丸(《兰台轨范·钱氏方》)

治肾阴不足、发热作渴、小便淋闭、气壅痰嗽、头目眩晕、眼花耳聋、咽干舌痛、齿牙不固、腰腿痿软、自汗盗汗、便血衄血、失音、水泛为痰、血虚发热等症。干地黄八两（九蒸为度）捣膏，干山药、山萸肉各四两，丹皮、白茯苓、泽泻各三两。徐灵胎曰：“此方钱氏专治小儿。”

六味地黄丸主治小儿阴虚发热、易躁动、口渴多饮、大便干、小便黄、常低热（无清涕鼻塞、非感冒病）等症。贫道认为此方的药物作用，主要是在下焦滋阴降火，故曰“壮水之主，以制阳光”，具有负运行人体左右之三阴经脉的功能。

本方纯属滋补肾阴的方剂，故专治肾阴不足而导致虚火上炎，如气壅痰嗽、头目眩晕、咽干舌痛、牙齿不固、自汗盗汗、血虚发热等症，两脉口寸部脉浮、脉波寸宽尺窄者宜之。凡是补充下焦的



药方，皆能促进十二经脉负运行功能。

第二节 中药治疗病例

病例 1

患者：付某某，女，42 岁，家住北闸公社五星大队，于 1968 年 12 月 19 日初诊。

症状：家属叙述患者由于孩儿丧亡而常持悲哀，在悲伤过度之时，幻觉床上有蚂蚁游走成群，继后幻觉有一个女鬼日夜跟随着她，精神不振，食量减少，小便频多。经多方医治无效后，认为是鬼妖作怪缠身，多次请巫医送鬼驱邪亦不能消除患者的幻觉现象，经人介绍请贫道治疗。见病人体质发达，面色沉滞有恐惧感，形体畏寒悚然，舌质淡苔白滑，问诊时答言较少。

脉候：右侧脉口的寸部与人迎的寸部皆衰微少脉，而关、尺两部的动脉沉而迟，但阴阳两处的尺部脉波宽于关、寸，可证右侧面阴阳动脉皆上升不足；左脉口动脉在正运时寸部涩而少脉，负运时尺部沉迟脉象明显；左人迎动脉在正运时尺部少脉，负运时寸部浮迟脉象明显，唯有左人迎寸部呈显二倍宽度的脉波。

治疗：患者由于悲伤太过以致肺气受伤，经言“悲伤肺”，肺气损伤则气衰，肺主皮毛，故导致外表皮毛的外卫之气不充。据右人迎的寸部也少脉，可证阳经主表的足太阳经气之外卫亦衰。肺金位于西方，应在右侧，故病人肺气损伤则右侧的阴阳脉象皆趋向衰弱。左侧脉口的寸部在正运时涩而少脉，乃气虚血滞而血液不能流畅所致，但左侧面之阴阳动脉的运行状况主要表现在正运衰于负运。综合左右阴阳的脉象，其 4 处的寸部动脉显象，就有 3 处衰弱



不足，而只有左人迎寸部一处不弱，按阴阳寸部之脉主上、主表，即确诊上升的能量不足，故外表的阳气多虚，特别是右侧面的阳气更虚。经言“脱阳者见鬼，脱阴者目盲”，据此诊断病者的幻觉幻见实乃阴气盛阳气衰所致，治宜充实表阳之气并调正左右阴阳的机能运行。

处方：白术 18g，党参 20g，黄芪 35g，桂枝 13g，当归 15g，川芎 12g，巴戟天 10g，益智仁 9g，石菖蒲 9g，远志 6g，沉香粉 3g，杭菊花 10g，广木香 6g，甘草 7g，大枣 12 枚，生姜 3 片，施药 5 剂，每日 1 剂，分 3 次服完。用白术、党参、甘草以补充右侧阴经的脾肺之气，用黄芪、桂枝以补充足太阳经的外卫阳气，用当归、川芎以协助左侧阴经运行使血液上升，用菖蒲、远志、沉香为反佐药正运左侧的阳经之气，下用巴戟天、益智仁温补培肾以制约小便频多，用杭菊、广木香清脑醒神，以甘草、生姜、大枣调和诸药。

12 月 28 日复诊：经服完上药 3 剂后，女鬼的幻觉消失，5 剂药服完，患者的饮食增加，小便减少，精神好转。复查阴阳脉象，左右的脉波增加了搏力，但还呈现如以上的左右阴阳不平形状。主症已去，从缓调治，改用归脾丸调整月余，患者恢复健康。

体会：从古到今的医案中，发现奇奇怪怪病证甚多。由于人体的阴阳变化非常复杂，所以人患奇异现象的疾病亦多。由于出现的现象各人有所不同，医者应根据病因与病证并结合四诊表现来决定其治疗。凡是医治属情志之内伤疾患，必须以喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情为辨证论治依据。例如此病，去迷信于鬼神的做法是无济于事的。由于人患疾病，多是体内阴阳运行失常而形成的，在医治上可以从阴阳之道的机理来纠正而使之达到平衡。此病例因悲哀伤中形成阴气盛阳气衰而致病，阴气者犹如黑夜和阴雨的天气，阳气者犹如白日和晴朗的天气，故用补充阳气的药物使阳光朗



照，则黑夜及阴霾现象即消失。运用祖国医学理论治病，重在通辨宇宙的阴阳造化之理及人体之内的阴阳造化之机。经云“谨熟阴阳，无与众谋”，即指此义。

病例 2

患者：张某某，男，6岁，湖北江陵人，于1986年3月15日就诊。

症状：家长叙述患儿近三个月以来常发低热，体温在 38°C 左右，伴有口渴喜饮，时而汗出，大便干，小便黄量少。患病期间常注射青霉素钠，体温只能下降一会儿，继而又发低热且长久不愈。望诊鼻干无阻塞、不流清涕，触诊腿凉足心热，后颈下背部有汗。

脉候：左右脉口与左右人迎的脉象均呈现浮缓略数，综合上述症状诊断为不属于外邪感染所引起的发热，而属于下焦阴虚发热。由于阴虚内热生则虚火上浮，故脉浮数汗出，阴虚则缺乏津液，故口渴小便少。经云“血少则便难”，故阴血亏虚则大便干，以上症状应属阴液亏虚所致。从钱氏“育阴退热”经验，用六味地黄汤壮水以制阳光。

治疗：生地16g，山萸肉10g，怀山药10g，茯苓8g，丹皮8g，泽泻6g。用药5剂，两天服1剂，一日服3次。服完药后，患儿的祖父告知经服3剂药热退，5剂药服完诸症悉除而愈。

体会：小儿持久发热，应辨别外感发热或阴虚发热。感染外邪发热，脉象本浮，但易发高热，并伴有头痛、身痛、鼻塞、流清涕或咽喉疼痛、咳嗽等症，邪甚者可导致昏迷惊厥。但小儿阴虚发热脉象亦浮，只发低热，常伴有自汗盗汗、舌干口渴、虚火上炎、小便黄少等阴虚内热的现象。由于阴虚发热或外感发热其动脉皆能显出浮象，故不论诊得浮脉、沉脉皆要结合患儿的症状作出诊断，因



外邪深入亦现沉脉，但伴有表证。如属下焦阴虚发热为虚火上越，虚火上越而发热者，不能用苦寒药泻阳，宜用补阴药以养阴而制阳，使虚浮之火下降而归藏于肾，才能达到水火相济、阴平阳秘而愈。

病例 3

患者：饶某某，男，49岁，系湖北省咸宁地委会成员，因前额两旁太阳、头维穴处头痛已10年有余，经中西医采用各种方法治疗未愈，经人介绍于1994年4月27日前来武当山道教诊所治疗。

症状：患者每月皆发头痛数次，如饮酒或饮食厚味时更易导致头痛。日常痰多，头脑昏闷不清，发病期更甚，并伴有后项牵制不灵活，舌体胖大，苔微黄滑腻，舌边有齿痕。

脉候：左脉口的关、尺脉紧，寸部涩象，右脉口的关、尺二部脉象比左脉口的关、尺脉缓和，右寸部衰微少脉；左右人迎动脉皆是寸部大于尺部。

治疗：综合脉、证分析，左侧面肝木生心火的阴经之气血为寒气凝滞以致郁塞不畅，右侧面脾土化生肺气不足，由于左右两侧之三阴经气在正运行时不足受限，在负运行时却通畅无阻，故而导致足三阳经的负运行上溢过甚，产生痰火而引起两侧头痛与后项不灵。病者由远道而来治病，又没有时间停留，暂时处方中药7剂归家服药，并嘱咐患者将原处方带回，如服药后有效，当继续服药。

处方：川芎15g，柴胡15g，党参18g，白术9g，桔梗10g，防风7g，茯苓24g，陈皮10g，制南星10g，前胡15g，法半夏13g，枳壳9g，黄芩15g，生姜15g用温开水泡汁，服药时冲入药内同服，每1剂药分3次服完，每日早中晚服药。川芎、柴胡为君药，疏理左侧的阴经，使左侧阴经的正运之力能伸能达；党参、白术、桔梗



为臣药，以补助右侧的阴经，促进右侧阴经之正运行的能量充足；二陈汤及南星、前胡、枳壳以化久年的结痰；兼黄芩一味苦寒药以清降阳经上盛之热为反佐，并可协助化痰降逆使足三阳经正运之机能下达；用防风、川芎以至病所为使治头痛。1995年10月份，饶同志介绍一位患慢性结肠炎的患者前来贫道处治病，并带来了一封感谢信，说经过服用上方20余剂，其头痛病愈，至今一年半时间未再复发。

体会：利用十二经脉的道理治病处方，就需要遵循左右、阴阳四方脉象的盛衰调剂，使低者能以举之、高者能以抑之，从而促进左右、阴阳达到平衡，故在处方用意上必须有调正整体的用药组方，才易获得良效。

病例4

患者：耿某某，男，15岁，于1995年7月30日初诊。

症状：患者患外感病已有30余日，经用西药与静脉输液治疗月余未愈，病情时轻时重，因日久不愈前来武当道教诊所就医。患者来诊时头微痛，时寒时热，发热时体温达 38.5°C ，心烦不安，呕吐苦水，四肢酸软，饮食甚少，上午病轻，下午病重，小便色黄，舌红苔白兼青。

脉候：两脉口的动脉弦小，显象一倍的脉波宽度，左右脉口关、尺部有脉而寸部少脉，脉波正运行时不能达到寸脉部位；左右人迎的动脉比两脉口之脉略盛，都是寸部盛于尺部；凭弦小不强的脉波可证明病邪已不太甚，但正气亦虚，无能抗邪，故而病邪留连日久不愈。

治疗：据时寒时热和呕吐苦水症状以及动脉弦小，可证病邪处于足少阳胆经，采用小柴胡汤加川芎调治。处方：红柴胡18g，党



参24g，黄芩13g，制半夏10g，甘草7g，生姜13g，川芎6g，大枣9枚，鲜车前草30g。

8月3日二诊：经服上方2剂，呕吐苦水减少次数，体温减为38℃，其他症状同上，阴阳的脉象如故，但两脉口的脉波力微增，继续进上方2剂。

8月6日三诊：经服前方4剂，头痛、寒热、呕吐症状平息，体温37.5℃，青白舌苔消除，舌上干燥乏津。患者自述饮食增加，还有点心烦并有口渴思饮。诊察两脉口的脉波已运达寸部，但正运之时的脉波还显虚而乏力；左右人迎动脉寸盛尺弱的悬殊减少，还存有不平之象；病邪已祛，但精神不振津液有亏。按上方减去黄芩、半夏、川芎，另增养阴生津药品调治。处方：沙参20g，柴胡9g，麦冬20g，薏苡仁18g，甘草7g，生姜1片，大枣5枚。

8月9日四诊：服上方3剂，口渴心烦消除，体温36.8℃，诊察脉口、人迎动脉已趋和平，但患者还感到四肢无力。后用成药补中益气丸调治，以培养中气，服用5日后，诸症悉除而痊愈。

体会：小柴胡汤乃柴胡、人参、黄芩、甘草、半夏、生姜、大枣组成，主治邪在少阳证。因患者有头痛、小便黄之症状，故增加川芎与车前草。贫道用柴胡的经验是：若诊到左脉口脉弦，现一倍宽度的脉波，负运时关、尺两部脉波甚明，正运时其脉波不能到达寸部，认为是肝气难伸，常用柴胡以疏之。前人用逍遥散治妇女郁怒伤肝，亦是小柴胡汤变法。此患者，亦采用柴胡、川芎通调左侧肝经以助左侧正运机能，用党参、甘草、大枣等甘味益气药以补充右侧脾经有助右侧的正运机能，用黄芩、半夏、生姜之苦辛味以平息胆经逆上犯胃经之邪，以鲜车前草清利小便。经服药4剂诸症消退而又增口渴，故减去黄芩、半夏之苦燥药及川芎，改换麦冬、薏苡仁、沙参等药，以沙参代党参补脾肺益肺阴，以麦冬、薏苡仁代



半夏、黄芩降逆生津。这虽然调换成为运化生津性质的药物，但对于左右侧脏腑阴阳之和解法的调治功能，依然未改变小柴胡汤方之药理的运用。得见前人论小柴胡汤义，言以柴胡为君药疏少阳胆经之邪。这种论点与贫道的治疗观点相矛盾。根据现代医学解剖认识，胆管的开口在胃下十二指肠处，正常人的胆汁输入十二指肠后，即会下行于小肠与大肠以帮助消化（因胆汁味苦而苦主下降缘故，所以正常人不会有口苦），如果因外感病邪传到足少阳胆经时，可能产生心烦、呕吐、口苦等症，认为乃胆汁逆行于胃上冲所致。根据两人迎的脉象是寸部盛于尺部，由此证明既然胆经负运行有上盛之势，与胆经相配合运行的肝经却易导致负运，因而在正运行时受限，故左脉口的动脉正运时不能达到寸部，因此认为小柴胡汤中的柴胡实为疏通肝经之药。因为胆经脉已有上盛之势，如果再用柴胡去升举胆经，岂不是升上加升、盛上更盛吗？故认为黄芩、半夏、生姜等药以入胃腑降逆止吐，胆逆上冲之势即随之下降而平息。因此，贫道认为小柴胡汤方乃是调治左右升阴降阳的和解表里之方，实为治疗病邪传到半表半里之间、正气又虚的圣法。以上分析，是贫道个人对小柴胡汤的运用及认识，是否正确，有待科学研究证实。

病例 5

患者：彭某某，男，69岁，住武当山紫霄村，于1996年2月6日就诊。

症状：患者近半月以来胃脘常有微痛兼胀满，食后痛增，按压上、中脘部痛增，3~4天排1次大便，便体干燥，舌苔黄燥，口干喜凉饮。

脉候：左右脉口脉现沉象，尺部的脉搏比寸部力强，但右尺部



要比左尺部的脉盛；左右人迎动脉浮、沉两候皆大而有力，均显有三倍宽度的脉波。

治疗：证属胃肠燥实证。

处方：枳实 12g，厚朴 18g，瓜蒌仁 13g，麻仁 12g，薤白 10g，滑石 18g。3 天后走访，患者经服上方 2 剂，胃脘部疼痛胀满减退，二日行一次大便已不干燥，复查左右的阴阳动脉都有缓解。

2 月 18 日复诊：患者服药病退数日，未继续服药治疗，2 月 18 日又复发胃脘胀满兼有腹痛，按压中脘痛增牵连脐下两旁，已 5 天未有大便，时而出现阵发性发热心烦，舌见灰黄干燥，诊察左右脉口与人迎的动脉，亦类似上次的阴阳差异现状，但脉波的搏力较以前更甚。脉、证显象俱实，确诊手、足阳明经胃、肠道为实邪结聚，采用大承气汤治疗。

处方：制大黄 15g，枳实 14g，厚朴 25g，芒硝 10g，水煎服。1 剂药服完，排泄了 3 次大便，患者的症状消除。复查患者脉口、人迎的 4 处动脉，已转变为阴、阳平衡，随访 2 个月病未再发。

体会：大承气汤主治阳明腑实证，非证、脉俱实，不可轻投。仲景医圣云“欲行大承气，先与小承气，若腹中转矢气者，有燥屎也，可以大承气攻之”，此病例先用润燥通调法虽然在当时生效，病证减轻，但数日以后其燥实病证比以前更甚，故采用大承气汤以攻除实邪。方中的厚朴、枳实消除胃肠道的痞满，大黄清除胃肠道的结聚，芒硝理胃肠道的燥坚，四药共同起着通泻胃肠道的积聚闭塞，使燥热去、津液得以保全的作用，前贤谓“通可去滞，泻可去闭，使塞者利、闭者通而正气得舒，故曰承气”。治疗疾病，应着重于求本。五脏为本，六腑为标。调治疾病的方药，应以本为主、以标为次。有时标、本兼治，有时专于调本，有时专于治标，各适其所宜，所谓“缓者治其本，急者治其标”。此病例由于胃肠道充



实阻闭，而使周身的阴阳气机运行失调。经曰“胃为五脏六腑之海”，说明胃是人体的生化之源，故当消除胃肠道的闭塞症状，以利周身十二经脉的正负运行机能。大承气汤乃主治阳明经胃肠道的治标之方，是有下降通泻功能的药方，此患者服此方使胃肠道通利病愈。但值得注意的是，患者未服药之前，左右脉口的两尺部是沉而有力脉象，服药以后，左右两脉口之尺部的沉而有力脉象已转变成寸、关、尺三部脉波平等。由此可以证明，使阳面下降的药物，能够升举阴面；使阴面下降的药物，能够升举阳面。具有提升左侧之阴面的药物，即有降右侧的阴经之功；具有提升右侧之阴面的药物，就有降左侧的阴经之力。故贫道认为，左右、阴阳经脉的运行灵机，确实是左右、阴阳对立，而整体阴阳又是平衡的并有相互转化的机能。

病例 6

患者：蔡某某，女，44 岁，于 1996 年 4 月 16 日就诊。

症状：病者患流行性感冒，经用西药医治 10 天未愈，继后则出现头昏目眩、心慌短气、多汗、欲吐不能吐、不思饮食、精神疲乏、小便短少色黄、舌质红赤无苔等症。

脉候：左人迎动脉现沉象，右人迎动脉现浮象，左脉口关、寸二部的动脉浮散而尺部的脉波比寸、关部窄小，右脉口的寸部少脉而关、尺二部脉沉，脉搏微数，均显二倍的脉波，并呈现有促代脉象，或是十几动一促代，或二十几动一促代。细查促代的原因，每次都是左脉口动脉负运行时产生促代，右脉口动脉正运行时产生促代。结合症、脉诊断为左侧面肝肾阴虚不能摄阳所导致上盛下虚，肝风内动上升而生浮火于心，左脉口动脉在负运之时，其负运的能量不足产生促代脉象，所以病证表现为头昏目眩、心慌多汗。再由



于右侧的脾土衰无能化生肺金而形成中虚不能续接肺气，右脉口在正运之时的能量不足而产生促代脉象，所以出现短气呼吸难续、不思饮食、欲吐难吐及精神疲乏等症状。

治疗：白芍 20g，生地 24g，山萸肉 15g，茯神 15g，石决明 30g，沙参 25g，白术 17g，山药 15g，知母 15g，炒栀子 12g，甘草 9g，每日煎 1 剂，服 3 次，服用上方 5 剂病愈。用生地、白芍、山萸肉以滋养左侧的肝肾之阴兼收敛肝肾，佐以茯神安镇心神，以石决明潜左侧浮阳，使左侧面增加负运下达的机能运行；用山药、白术、沙参等补中益气药品，补充右侧脾土以生肺金之气，即能补助右侧正运上升的机能运行；用知母止汗，栀子清理浮阳，甘草调和诸药。此方调治的药物功能，是负运行左侧而正运行右侧。

体会：此患者为左侧面正运太过、右侧面正运不及而形成的疾病。凡是出现代脉、促脉、结脉等歇止脉象，多由于精、神、气、血亏损运行失常，导致动脉当至不至而间歇。此病例，根据其左右侧的脉象差异立法，调治左右两侧的气血运行使之运行平和。

病例 7

患者：吴某某，男，23 岁，北京人，于 1997 年 6 月 10 日就诊。

症状：近日来头晕多梦，全身酸软乏力，睡眠之后更觉疲倦。

脉候：左脉口之寸部浮散，寸部宽于尺部，右脉口之寸部脉弱而不及。

治疗：法当潜左侧之浮阳，补益右侧脾肺之气。

处方：五味子 10g，生地 15g，丹参 10g，石菖蒲 10g，云苓 10g，山药 18g，沙参 10g，党参 12g，杭菊 10g，栀子 15g，广木香 7g，炙甘草 7g，黄柏 5g，川续断 20g，白术 15g。服 1 剂症轻，2 剂



无病感，3剂收功而痊愈。

病例8

患者：丁某某，男，49岁，住新加坡，于1997年6月11日就诊。

症状：手足内侧三阴经所属循经的皮肤发赤红色风疹块，每天早上严重，午后症状减轻。在新加坡经中西医治疗一年有余而不能根治，在用西药注射治疗时，只能临时控制症状，停药后依然如故。

脉候：左手脉口显浮象，右手脉口显沉象，人迎两部皆现浮脉，大凡久病风疹面色转赤者，多为风邪深入血分，故当从血分引邪出表。

处方：川牛膝 15g，生地 30g，赤芍 15g，红花 9g，苍术 13g，桔梗 13g，地肤子 12g，苍耳子 15g，蝉蜕 9g，栀子 20g，连翘 30g，白芷 15g，防风 10g，追风草 12g，白鲜皮 10g，沙参 17g，黑小豆 2两，杉树皮 2两为引。此方连服4剂，其症已十去其八，继服上方4剂而愈。

病例9

患者：罗某某，女，本山居民，于1997年6月23日就诊。

症状：患者中风偏瘫，治疗数月其病已好十分之七八，现感腹部逐渐增大且胀满，饮食亦逐渐减少，两腿迈步乏力。

脉候：左脉口寸部脉浮而尺部虚弱，右脉口寸部脉沉而尺部脉实，两人迎寸部较旺，且比脉口的脉波实大。

处方：苍术 15g，山药 20g，千年健 13g，沙参 13g，白芍 12g，北山楂 10g，天麻 13g，川牛膝 15g，山萸肉 20g，枳实 9g，青皮



10g，厚朴 15g，瓜蒌子 13g，杭菊 10g，当归 7g，桑寄生 20g。经服上方 5 剂，两腿力增，腹部胀满已消。

病例 10

患者：刘某某，女，84 岁，于 1997 年 7 月 14 日初诊。

症状：自述 2 个月前跌跤，左背部受伤后牵连左肋下疼痛，后又产生右肩胛前部疼痛，不能向后方伸展臂膀，曾去医院医治无效而前来道教诊所就诊。

脉候：两脉口之寸部左浮右沉，而两人迎脉现盛大充实之象，高龄胃脉充盈虽属佳象，但充实太过宜当消导。

处方：青皮 10g，虎杖 20g，川牛膝 10g，丹参 10g，芍药 10g，青木香 10g，苍术 13g，黄柏 15g，制乳、没各 5g，枳壳 10g，薏苡仁 18g，防风 9g。并用风湿膏药 1 张贴于右肩痛处。

7 月 15 日复诊：经服上方 2 剂，其肋下疼痛减轻，右肩胛之痛亦觉缓和，臂膀能前后伸展，原方稍作加减续服。

处方：川牛膝 13g，虎杖 15g，芍药 13g，当归 9g，制乳、没各 5g，枳壳 10g，白术 7g，苍术 7g，党参 20g，防风 9g，薏苡仁 18g，青木香 10g，黄柏 15g。又施药 3 剂，后访自述药服完痊愈。

病例 11

患者：李某某，女，成人，本山村民，于 1997 年 8 月 10 日就诊。

症状：在 1 个月前患肾炎，腰痛较重，曾到十堰地区医院诊治，经治疗 1 星期其病减轻，但由于经济条件有限而返家，但归家不久，其腰痛复发严重，前来贫道处求治。

脉候：脉口左右寸部均旺于尺部，且脉象浮紧，两人迎脉亦是



寸部旺盛而脉紧。

治疗：紧脉主寒主痛，且尺部脉波衰弱，故当以温培下焦、祛寒通经为治则。

处方：川牛膝 15g，木瓜 15g，金毛狗脊 20g，茯苓 20g，山药 20g，炙甘草 9g，桂枝 9g，独活 9g，川断 13g，追地风 7g，桑寄生 20g，土茯苓 30g，五加皮 10g，桑树根 5 寸为引。3 剂药服完而痛止，病愈后至今未发。

病例 12

患者：李某某，女，88 岁，住河南省，于 1997 年 8 月 23 日初诊。

症状：3 年前因弯腰托门时腰部和脊柱受伤而久治未愈，现在疼痛加重，卧床难以转侧翻身，小腹内痛，饮食较少，大便 4~5 天一解且干燥不利排出，腰部脊椎命门穴处增生突出，按压则剧痛。

脉候：两脉口皆寸旺于尺部，两人迎亦是寸旺于尺部，但人迎脉的宽度比脉口动脉宽大一倍，其阴阳脉象皆显上盛下衰，乃因八旬以上高龄下焦精血不足故现此脉。老年之人贵在六腑健旺，青年贵在五脏健旺，故其人迎脉旺属佳象。

治疗：受伤之处压痛拒按乃属实证，故于最痛处用针刺后拔罐，吸出紫黑血 4ml 左右，拔罐后外贴自制跌打膏，并拟处方以填补下焦、行瘀止痛为治则。

处方：川牛膝 15g，鸡血藤 15g，生地 20g，桑寄生 20g，毛狗脊 25g，熟地 18g，炙甘草 10g，川断 13g，独活 10g，山萸肉 18g，赤、白芍各 7g，红花 7g，制乳、没各 5g，桂枝 5g，制方 2 剂。

8 月 26 日复诊：经服上方 2 剂各症减轻，然脉象依然如故，遂于原方加减续服。



处方：川牛膝 13g，木瓜 13g，川断 13g，鸡血藤 20g，毛狗脊 20g，桑寄生 20g，土茯苓 25g，独活 12g，肉苁蓉 15g，熟地 30g，山萸肉 18g，当归 10g，制乳、没各 5g，红花 6g，小茴香 5g，枳壳 9g。

制方 4 剂，服完后翻身自如，各症十去其八，因急于归家，遂按方购药带回，临走时持其脉，其脉口、人迎之尺部的脉波皆有增强现象。

病例 13

患者：刘某某，男，48 岁，湖北省公安县人，于 1998 年 6 月 15 日就诊。

症状：患者平日咳嗽时有咳血，腰腿酸软，精神疲乏不振，所食甚少，睡眠欠佳，面黄舌红少苔，经医院确诊为肺结核，经人介绍前来武当山治病。

脉候：左手脉口虚浮，重按不得，右脉口三部沉弱，左右人迎两寸部皆现浮脉。

处方：枸杞子 15g，南沙参 25g，甘草 7g，桔梗 7g，玉竹 15g，云苓 15g，生地 15g，山药 15g，白及 9g，百部 6g，白术 10g，白芍 15g，薏苡仁 10g，黄连 5g，鱼腥草 15g，薄荷叶 3g。

经服上方 5 剂，略有小效，然其睡眠依然不佳，故于此方加入夜交藤 20g，酸枣仁 15g，之后以上方连服 60 剂而病愈回乡。

病例 14

患者：黄某某，女，42 岁，潜江市人，于 2001 年 9 月 25 日就诊。

症状：患者有慢性支气管炎多年，痰清胸闷，咽喉不利。



脉候：两脉口的脉象左浮右沉，两人迎的脉象较平，寸旺于尺。

处方：天冬、茯苓各 20g，川牛膝、木瓜、威灵仙、党参、白术各 15g，陈皮 12g，麻黄 8g，桔梗、清半夏、杏仁泥各 10g，枳壳、前胡、甘草各 7g，初期每日服 1 剂，见效后 1 日半服 1 剂。后患者上山告诉贫道，共计服药 20 余剂病愈。

病例 15

患者：林某某，男，24 岁，南京人，于 2004 年 9 月 23 日就诊。

症状：患者患痫证 8 年，平素痰涎较多，如接触电脑的工作时间过长即觉精神极度疲乏，小便色黄，大便尚可，曾在当地经中西医医治无明显疗效，唯每天晚上服西药“妥泰”起镇静作用以维持现状。

脉候：两手脉口皆显沉而滑数，两人迎均显浮而滑数。

处方：柴胡 9g，当归 10g，前胡 15g，赤芍 15g，法半夏 12g，枳壳 9g，防风 7g，南沙参 20g，云苓 17g，陈皮 12g，炙甘草 5g，海浮石 9g，明矾如黄豆大 1 粒，青果 12g，生姜 3 片，地丁 9g，竹叶 10g 为引。每日 1 剂，分早中晚 3 次服，兼服用武当“八宝紫金錠”每天 1 粒。

9 月 27 日二诊：经服上方 3 剂后，头脑及精神比以前清晰，复查阴阳两方的脉象已有明显好转，方药既已对症，效不更方，再遵前方继服 3 剂，并嘱将“妥泰”减量三分之一。

10 月 5 日三诊：经服上方 7 剂，一切良好，但每天早上大便 3~4 次，痰涎依然颇多，即从上方去枳壳加九节菖蒲 9g，鲜竹沥口服液每次 1 支，与煎药同服。



10月13日四诊：又服药7剂反应良好，仅服药后腹内有微满之感，于前方中加枳壳7g，炒栀子10g，椿树皮6g，其他药依旧。

10月23日五诊：患者自觉全身轻松，精神愉快，每天早上习太极拳锻炼身体，“妥泰”已减量四分之三，病去十之八九，停药煎剂，处以“逍遥丸”3瓶、“二陈丸”3瓶一起服用，服药量按药瓶上说明的服药量各减半，每日服2次。12月份，患者痊愈归家。

病例 16

患者：熊某某，男，53岁，河南省驻马店人氏，于2004年12月11日就诊。

症状：患者胃脘胀满疼痛一年有余，大便干燥，睡眠困难，经西医诊断为十二指肠球部溃疡，经中西医结合治疗达一年有余而疗效欠佳。观其舌紫红，苔少微黄。

脉候：左手脉口寸部独显浮象，右手脉口之关、尺部脉沉而寸部近乎无脉，两人迎脉均现浮大而缓之象。

治疗：滋阴养液，润肠通便，调正左右上下阴阳脉象的偏差为主。

处方：生地、麦冬、南沙参各20g，酸枣仁17g，丹参25g，乌贼骨17g，薏苡仁30g，黄柏15g，柏子仁15g，苍术15g，枳壳8g，厚朴13g，党参15g，甘草7g。经服上方达20余剂，患者的胃脘胀满疼痛消除，大便转化正常而愈。

病例 17

患者：李某某，女，31岁，本山道教徒，于2004年12月11日就诊。

症状：两手掌心起红点样水疱且发痒，自言每年冬季即发此



病，且双手怕遇凉水，曾服他医之中药亦无效。

脉候：左脉口寸部盛于尺部，右脉口三部脉象平和无异；左右人迎之寸部均显涩而不清晰之感；总体脉象，两脉口盛于两人迎之脉。

治疗：两手心为心包经所主，水疱色红而痒，且左脉口寸部脉盛，当为心包经所主之血分蕴有湿热，湿热郁遏不得宣通，故发此红点样水疱。两人迎之寸部脉涩不明，乃阳部经气郁滞不得宣通所致。双手为诸阳之会，阳气涩而不畅故畏凉水接触，且寒凉更能郁遏不畅之表阳，法当除阴经之湿热并宣通阳经的抑郁为主。

处方：川牛膝 15g，木瓜 15g，知母 15g，云苓 15g，防己 15g，乌药 15g，土茯苓 25g，苦参 10g，灯心草 10g，荆芥 10g，防风 7g，炙甘草 7g，桑寄生 20g，苍术 12g，泽泻 12g，麻黄 5g。服上方 3 剂而病愈。

病例 18

患者：刘某某，男，29 岁，本山道教徒，于 2005 年 1 月 22 日就诊。

症状：因患风热感冒，自觉胸中发热而闷，并且大便干燥，不思饮食，常觉坐立不安，舌体胖而无苔。

脉候：两手脉口之尺部滑数有力而两寸部涩，两人迎皆是寸部旺于尺部。

处方：柴胡 13g，板蓝根 25g，炒栀子 25g，桔梗 12g，甘草 9g，连翘 25g，金银花 15g，玄参 20g，生地 20g，枳壳 7g，追风草 10g，患者 1 剂服完后诸症全消而愈。左脉口寸涩，用柴胡、板蓝根以疏肝解表；右脉口寸涩，用桔梗、追风草（与防风功效相似，为武当山地方草药）、甘草；两尺滑数有力，用玄参、生地以清热养阴通



便；左人迎寸旺于尺，用连翘以清热；右人迎寸旺，用金银花、梔子、枳壳。全方据脉从症严谨组方，故1剂而效，病虽小，立意却深，读者当融会其理而通治百病。

病例 19

患者：黄某某，男，48岁，居于河南许昌，于2005年2月15日就诊。

症状：胸闷异常，尤以左乳下方为重，进而影响作息不能入眠。观其舌苔中间厚腻而色黄，此湿热中生，从而阻遏气机运行。

脉候：左脉口之寸部浮大有力，右脉口之寸部却虚而无力。

治疗：拟从心火过旺、肺气虚弱兼以利湿热立方。

处方：丹参 30g，茯苓 15g，虎杖 25g，泽泻 15g，炒薏苡仁 30g，炙甘草 4g，党参 20g，白术 15g，防风 7g，桔梗 10g，苍术 12g，川牛膝 13g，红花 5g，黄柏 10g，枳壳 7g。患者连进5剂后病退而愈。

病例 20

患者：孙某某，女，湖北天门市多宝镇人，于2005年3月20日就诊。

症状：患者常头晕，口渴，大便干结6~7天一次，月经来潮时腹痛较甚，经中西医长期治疗，时轻时重而未能根除。观患者体瘦面黄，舌紫少津。

脉候：左手脉口三部脉浮，右手脉口三部脉沉，两人迎动脉均为寸部浮甚。

治疗：综合分析，乃阴虚阳亢所致，阴虚故口渴，大便干结为津液缺少，阳浮于上故头晕目眩，痛经乃阴虚血液虚少流行不畅所



致，拟从养阴通腑兼调左右上下阴阳运行之不平为法。

处方：石决明 25g，麦冬 20g，生地 20g，白芍 15g，天麻 15g，生薏苡仁 30g，生大黄 5g，滑石 10g，防风 9g，杭菊 10g，杏仁 10g，枳实 10g，火麻仁 15g，南沙参 17g，当归 10g，炙甘草 7g，上方司药 5 剂。待到次年 3 月，患者又到武当山朝拜，自述经服上方 5 剂后诸症痊愈。

病例 21

患者：周某某，女，54 岁，于 2005 年 4 月 4 日就诊。

症状：患者近几年来左肩、左侧腰部及左侧坐骨神经均感疼痛，常常在劳作时又牵连右腰及环跳穴处酸软而导致难以干活。检查患者左腿发现左腿外侧之静脉血络充盛，色呈紫黑，此瘀血阻络也。

脉候：左侧脉口与人迎皆为寸部脉浮，右脉口之尺部沉紧而右人迎的寸部脉显浮象。

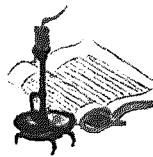
治疗：先用三棱针在左腿放瘀血，再用药物调治。

处方：川牛膝、木瓜、威灵仙、丹参、黄柏、苍术各 15g，生地 20g，当归 10g，羌活 10g，防风 10g，制乳、没各 12g，白术 12g，红花 7g，云苓 15g，鸡血藤 25g，炒薏苡仁 25g，党参 20g，炙甘草 5g。后与患者失去联系，故不知疗效如何。

病例 22

患者：朱某某，男，52 岁，住河南省新乡小吉镇，于 2005 年 4 月 20 日就诊。

症状：患者右侧胁肋部有麻木之感，并有头昏高血压病，血压常在 100 ~ 160mmHg 之间。



脉候：左脉口之寸部弱于关、尺二部，右脉口虚弱不及，左右人迎之寸部浮而有力。

处方：当归 15g，赤芍 17g，鸡血藤 25g，炒栀子 15g，薏苡仁 30g，羌蔚子 12g，防风 9g，杭菊 15g，南沙参 30g，槟榔 12g，白芷 15g，黄柏 15g，白术 15g，炒莱菔子 20g，槐米 20g，炙甘草 5g。

病例 23

患者：李某某，女，52岁，本山道众，于2005年5月26日就诊。

症状：两大腿外侧疼痛并且畏寒。

脉候：左手脉口之寸部浮紧，右脉口之关、尺二部沉紧而寸部少脉；左右人迎皆显浮而微紧，但较两手脉口的紧象缓和。

治疗：拟从寒湿凝滞经脉处治。

处方：川牛膝 15g，木瓜 15g，苍术 15g，威灵仙 17g，防风 10g，独活 10g，五加皮 10g，秦艽 10g，炒薏苡仁 25g，黄柏 15g，甘草 5g。

病例 24

患者：李某某，女，32岁，道协工作人员，于2005年5月29日就诊。

症状：患者有多年的腰痛史，自觉双膝及大腿骨内酸痛，并有发凉感觉，时轻时重，每逢经期第一天即腰腹疼痛。

脉候：左脉口浮紧，右脉口沉紧，两人迎均显沉紧之象。

处方：附片 10g，白芍 20g，白术 15g，黄芪 25g，桂枝 12g，甘草 5g，木瓜 15g，牛膝 15g，桑寄生 20g，独活 15g，巴戟天 20g，麻黄 6g，当归 10g，红花 7g，大枣 7枚，生姜 2片。2剂3天服完，兼



用风湿膏 1 片。服完药后，患者自述腰腿的症状大减，为了巩固疗效，再遵上方司药 2 剂。

病例 25

患者：陆某某，女，57 岁，本山紫霄村人，于 2005 年 6 月 5 日就诊。

症状：患者的第 3 ~4 腰椎疼痛，并牵连腰及臀部亦疼痛，自言卧床翻身困难，大小便自调无不适。

脉候：右脉口沉而迟，左脉口浮而迟，右人迎显浮象，左人迎亦显浮象。

处方：炮附片 7g，白术 12g，苍术 8g，党参 20g，防风 10g，威灵仙 5g，茯苓 15g，独活 15g，红花 7g，川牛膝 15g，木瓜 15g，黄柏 15g，山萸肉 15g，川断 17g，炙甘草 5g，薏苡仁 30g。

本症因寒滞经脉致阴阳表里升降失常，人迎浮者乃阳不潜降，治以黄柏、薏苡仁，而附片、川断温经逐寒通络，白术及诸风药以调治右脉口之沉迟，牛膝、木瓜、丹参、萸肉以调治左脉口之浮迟，从而对症下药。

病例 26

患者：杜某某，女，56 岁，寺院出家人，于 2005 年 6 月 28 日就诊。

症状：每日头昏，血压偏低，血压 60 ~ 80mmHg，逢阴雨天则腰部疼痛，观其舌苔薄白、舌质淡。

脉候：左脉口、左人迎之寸部均显浮而无力，右脉口、右人迎之寸部皆少脉而关、尺部脉显。

治疗：此病左侧下焦阴精不足致虚阳上浮，右侧表里气机虚弱



而致无能量上达头部，故致头昏，从虚弱论治。

处方：山萸肉 15g，白芍 20g，当归 12g，熟地 17g，丹参 13g，白术 15g，党参 20g，黄芪 30g，川断 15g，茯苓 10g，川牛膝 10g，桑寄生 20g，甘草 5g。

方中萸肉、白芍、熟地、当归、丹参、牛膝填补下焦精血以敛浮阳，白术、党参、茯苓、甘草四君子汤以补益右脉口不足之气机，桑寄生、黄芪以补益右人迎寸部不足之气机，川断、桑寄生能调治腰部酸痛。

病例 27

患者：戴某某，男，俄罗斯人，于 2005 年 8 月 9 日初诊，年龄不详。

症状：患者胸闷不舒，腰痛，兼有头昏，体型魁梧。

脉候：两手脉口之寸部均是脉弱不显，左人迎之寸部微显实象，右人迎脉象显弱而不足。

治疗：从补益气血为治。

处方：川芎 10g，当归 17g，赤芍 17g，薏苡仁 30g，扁豆 20g，黄芪 15g，桑寄生 20g，川断 20g，苍术 12g，党参 15g，太子参 15g，防风 7g，广木香 10g，枳壳 7g，炒莱菔子 15g，炙甘草 5g。3 剂。

8 月 13 日复诊：自述经服上方 3 剂，胸闷有所好转，但查脉依然同上，按前方加减。

处方：川芎 10g，当归 20g，赤芍 20g，薏苡仁 30g，扁豆 20g，枳壳 7g，炒莱菔子 15g，白术 9g，苍术 8g，黄芪 20g，桑寄生 20g，川断 20g，党参 25g，防风 7g，广木香 10g，益母草 10g，炙甘草 5g，照方 5 剂。该患者在武当学拳，后访病愈。



病例 28

患者：朱某某，男，58岁，湖北武汉市人，于2005年8月17日就诊。

症状：发荨麻疹4月有余，兼大便干结，经用中西医结合治疗无效前来求医。

脉候：右脉口及右人迎之寸部虚涩不及，左脉口寸部亦是虚弱，左人迎三部脉平。

处方：青风藤 15g，蝉蜕 13g，防风 10g，黄芪 30g，千年健 15g，炙甘草 5g，肉苁蓉 17g，威灵仙 13g。

病例 29

患者：李某某，男，39岁，本山南岩工作人员，于2005年8月20日就诊。

症状：患者常常流汗，特别是睡时明显，而头部又特别多汗，自言性功能减退，但无其他不适症状，此症状已有数年之久。

脉候：左脉口洪大兼缓，右脉口脉沉，左右人迎脉显不足且微有紧象。

治疗：拟从桂枝汤加减治疗。

处方：桂枝 10g，白芍 20g，黄芪 30g，生地 20g，生牡蛎 25g，地骨皮 20g，炙甘草 7g，小麦麸皮 0.5 斤，大枣 12 枚为引。

病例 30

患者：李某某，女，湖北省公安县杨场庙观道众，于2005年9月19日初诊。

症状：患者病已半年，呼吸气短难续，全身常觉疲乏无力，食



后胃脘则胀满，常有嘈杂欲食之感，食后稍安，大小便尚可，经中西医治疗疗效不显著，时好时坏。

脉候：左脉口及左人迎之寸部均显浮实，右脉口及右人迎之寸部均显弱而不及。

治疗：当降左升右为原则，拟用黄芪健中汤加减法治疗。

处方：黄芪 30g，桂枝 10g，白芍 30g，丹参 25g，红花 6g，乌药 12g，砂仁 7g，白蔻仁 10g，广木香 10g，炒莱菔子 12g，木瓜 15g，云苓 10g，炙甘草 5g，白术 7g，苍术 7g。处方 3 剂，药服完疗效甚佳。

9 月 22 日复诊：左右阴阳脉象之升降已近和平，气虚已变充实，唯感胃脘气滞不舒，拟方以调理气机为主。

处方：丹参 20g，茯苓 10g，苍术 12g，厚朴 15g，白蔻仁 10g，木瓜 15g，黄芪 15g，乌药 10g，枳壳 6g，砂仁 7g，青皮 6g，炙甘草 5g，青木香 7g。处方 2 剂以观疗效，如有效当继续服用，以愈为度。

病例 31

患者：花某某，女，43 岁，武当山古建筑维修施工队工作人员，于 2005 年 11 月 20 日就诊。

症状：患者周身起一分硬币大小的风疹硬块，在发病时甚痒，尤其下半身更痒，入夜后发痒加重。

脉候：左脉口之寸部脉紧，其他三部脉显沉紧而涩，且脉波无力。

治疗：拟从补虚散寒以祛风解表为治。

处方：薏苡仁 20g，党参 20g，黄芪 20g，威灵仙 20g，白术 20g，茯苓 20g，川牛膝 15g，白芷 15g，防风 12g，蝉蜕 12g，追风



草 10g，麻黄 7g，葛根 15g，炙甘草 5g，大枣 7 枚，生姜 3 片。后访患者，自述经服 3 剂而痊愈。

病例 32

患者：吴某某，女，中年人，于 2005 年 12 月 5 日就诊。

症状：近日以来夜晚睡觉即感觉胸中嘈杂不安，大便干结，舌质色紫。

脉候：左右脉口脉沉而搏力不强，左右人迎脉却超越了寸部。

治疗：据此异乎寻常之脉象，拟用四消丸中成药每次一袋 6g 量，兼用大黄苏打片每次 4 片同服。12 月 6 日，患者自述服上药 2 次后睡眠转安。然而经询问得知，其服药后并未产生大便稀和腹泻症状，按平常用此药的经验，用以上药量服 1 次即当便溏 2~3 次，然此患者服药 2 次并未有大便通利之反应，仅减轻了胸中嘈杂不安的症状，即嘱其继用上方 3 次以观后效。12 月 7 日，患者自述 3 次药服完，胸中之症状消失，但大便并未产生泻下。

体会：此症脉象特殊，如果仅凭两手脉口之沉而乏力脉象，往往易导致医者认为属气血虚的脉、证，就会用温补之剂治疗，导致用药不当产生不良反应。因为此病施用多次的泻下剂都未曾泻下，足见其阳明腑实太过，据此特殊脉、证，为医者当重视脉口与人迎之阴阳双诊，方能准确把握病因，从而对症施治，其人迎超越了寸部的本位乃是长脉，属特殊的太过之脉象，且大便干结，故当用泻法施治。

病例 33

患者：魏某某，男，28 岁，本山村民，于 2005 年 12 月 22 日就诊。



症状：患者患慢性鼻炎，时轻时重，常在感冒期间症状加重，平常睡眠时，在低位向枕一面的鼻孔易于堵塞，如左右轮换侧卧，依然是处于低位的鼻孔鼻塞气阻不畅。

脉候：两脉口之寸部均显不足，左人迎之寸部脉象浮大，右人迎亦是寸浮但比左人迎寸部搏力小。

处方：川芎 12g，赤芍 15g，当归 15g，白芷 15g，防风 10g，党参 25g，辛夷花 12g，黄柏 13g，炒栀子 20g，金银花 12g，连翘 20g，黄芪 15g，通草 4g，炙甘草 5g。后追访疗效，患者言服药 3 剂鼻息通畅而痊愈。

病例 34

患者：黄某某，女，34 岁，于 2006 年 1 月 10 日就诊。

症状：自言常头晕、头痛。

脉诊：左脉口之寸部旺于尺部，此乃左侧之经气正运太过而负运不及；右脉口之尺部旺于寸部，此乃右侧之经气正运不及而负运太过。

处方：天麻 15g，钩藤 25g，甘草 5g，白芍 12g，白芷 15g，防风 12g，党参 20g，生姜 2 片，大枣 7 枚为引。

病例 35

患者：张某某，女，40 岁，湖北省天门市张港镇初中教师，于 2006 年 3 月 8 日就诊。

症状：失眠，下肢酸软无力，下午尤甚，常自觉头昏目眩，有飘然上浮之感。

脉候：左侧脉口及人迎均显浮而有余，但左人迎脉比其他部脉独显缓而大；右脉口之寸部少脉不及，右人迎脉显浮象。



治疗：此患者的四部脉三部皆浮，可证阴虚于下，兼太阴脾土之正运不及而不能归藏万物，故共同促成以上诸症。

处方：茯神 15g，酸枣仁 20g，丹参 20g，五味子 6g，山茱萸 12g，麦冬 20g，南沙参 25g，杭菊 10g，炒栀子 15g，薏苡仁 25g，黄柏 12g，白术 15g，广木香 7g，清半夏 6g，炙甘草 7g。并传患者一法，每当左足落地时，令其意念有入地之感，以潜藏左侧浮越之阳。

病例 36

患者：刘某某，男，60 岁，山东省人氏，于 2006 年 3 月 15 日就诊。

症状：病人患糖尿病已达 16 年，平时口渴多饮，每天要喝一瓶半至二瓶开水，夜晚小便多达 6~7 次。两眼视物模糊不清，腰部酸痛，两腿麻木酸软，经多年治疗病情时进时退疗效不定。

脉候：左脉口寸部浮且寸旺于尺，右脉口沉涩而紧，关部无力而寸部脉微不显。

治疗：左脉口之寸浮者，为阴液虚少而阳浮，阴精不能上奉滋养眼目，故视物模糊；因肝肾阴虚，故两腰酸痛。右脉口沉紧脉涩不畅而无力，乃脾、肾阳气虚弱不得健运气机，故两腿麻木酸软；阳气虚不得化气行水以生津液，故索饮无度；脾、肾皆弱不得固摄，故饮多而小便亦多。此疾已达 16 年，正气甚虚，据脉从症，从虚弱治。

处方：炮附片 12g，白术 12g，苍术 10g，益智仁 8g，川断 20g，肉苁蓉 20g，巴戟天 15g，独活 15g，山萸肉 15g，葛根 10g，生地 20g，南沙参 20g。患者服上方 5 剂后，以上方改泡药酒，服用达 4 个月有余，疗效明显，每夜小便 1~2 次，且饮水量亦大为减少，其



他病证均明显好转，无任何不适反应。但到医院化验检查，其血糖虽比以前有减，但依然较高，嘱其方内增黄芪、柏子仁2味药续服，以观确切疗效。因病程已久，患者年事又高，非一朝一夕能图全功，唯缓缓调养以图安康。

病例 37

患者：陈某某，男，24岁，陕西蓝田县蓝关镇东场村人，于2006年3月16日就诊。

症状：患者于2004年12月18日夜晩开始产生幻听，并又凭空产生幻视图像。自述平日头部昏沉，思虑万千不能自控，以后逐步产生郁闷自闭现象，不爱与人言语沟通，常夜不能眠，每日白昼头脑昏沉，夜晚反而头脑清晰，自觉思虑过度精神疲乏，欲安静却不能，两年来经中西医治疗效果欠佳，至今依旧。

脉候：左右脉口脉波正运不能上达寸部，可证五脏阴气郁遏于内，而两人迎之脉正运不能下达尺部，可证六腑之阳气浮越于上而不能下交于阴。

治疗：阴阳之气机不能正常相交调和，白昼阳气外出于表，故在外之阳气愈盛，阳气浮热扰及神明，致白昼思虑不断而不能自控，所以神明因热而易昏沉，但至夜晚，一身阳气得天时之助而内潜于阴，故得以暂安。脾土主意主静，脾土不能正运上达以藏纳群阳，故失眠矣。脾犹坤土大地，在表之阳犹火日在天，坤土薄弱，不能行夜晚归藏炎日之职，坤土不升而炎日不落，始成此症。

处方：柴胡 9g，当归 15g，赤芍 18g，夜交藤 20g，茯神 15g，代赭石 20g，桔梗 10g，南沙参 20g，白芷 13g，清半夏 10g，远志 7g，麦冬 20g，天花粉 15g，炙甘草 5g。并传患者自我按摩的方法，每日按内庭穴多次，每次 18 下，同时按内关穴多次，每次 9 下，左



右均同，并嘱咐患者按先调左侧后调右侧的顺序按摩，以辅助调整阴阳气机。

病例 38

患者：荣某某，男，19岁，湖北省天门市张港人，于2006年3月18日就诊。

症状：常发头痛症，发则晕倒已达5年，今日便发病一次，特别是在受惊吓时易导致发病，头晕，常唾吐涎沫，舌尖有红点，舌心无苔微黄。

脉候：左右脉口关、尺有脉而寸部微弱近乎无脉，两人迎脉弦而寸旺于尺。

处方：柴胡15g，当归15g，茯苓18g，清半夏12g，青果20g，明矾3g，防风10g，党参20g，独活9g，羌活7g，白芷15g，陈皮15g，前胡12g，黄芩15g，枳壳13g，炙甘草5g，生姜3片为引。司药9剂，同时配合服用武当山“八宝紫金錠”30粒，每天1次，每次1粒，用薄荷煎水化服。

病例 39

患者：梅某某，女，60岁，河南平顶山人氏，于2006年4月23日就诊。

症状：病者患颈椎骨质增生压迫神经，致使双手双足麻木，全身有紧绷沉困之感，而肋下及腰部更甚，小便自遗难禁，但大便正常。

脉候：左脉口寸部浮而尺部脉弱，其他三部脉象均显沉而无力。

治疗：综合脉、证分析，全属身体气机虚弱不能运行通调一身



的气血所致。

处方：川牛膝 15g，木瓜 17g，当归 12g，红花 7g，鸡血藤 20g，云苓 10g，麻黄 5g，丹参 20g，党参 20g，白术 17g，川断 15g，益智仁 7g，益母草 10g，枳壳 12g。患者服药 3 剂后疗效不显，从而在原处方上增加桂枝 10g，黄芪 50g，又服 3 剂才开始有效，继服 3 剂各症减轻，嘱其带药方回家长期调理以痊愈为度。

病例 40

患者：李某某，女，成年人，本山村民，于 2006 年 5 月 16 日就诊。

症状：患者于元月份患右侧头痛，常常头晕，在发病时常服西药镇痛有所缓解，但不能根治。

脉候：右脉口及右人迎之寸部均显弱而不足，左脉口寸浮而尺涩，左人迎寸沉而尺部脉显。

处方：当归 10g，白芍 20g，钩藤 20g，黄芪 20g，党参 20g，白芷 17g，云苓 15g，白术 17g，羌活 10g，防风 12g，炙甘草 5g。

病例 41

患者：叶某某，男，21 岁，于 2007 年 5 月 26 日就诊。

症状：患者常常在晚上睡觉时，身体产生抽筋疼痛。

脉候：左手脉口、左人迎均呈浮象，右手脉口、右人迎均呈沉象。

治疗：此病为左边经脉（肝脉）升浮太过，以致遏制了身体右侧经脉能量的上升，治疗以降左升右为法。

处方：川牛膝 15g，木瓜 15g，炮山甲 7g，钩藤 20g，白芍 15g，威灵仙 15g，白术 15g，防风 8g，鸡血藤 20g，党参 20g，黄芪 20g，



茯苓 15g，伸筋草 15g，桂枝 10g，甘草 5g。

病例 42

患者：周某某，女，66 岁，湖北省监利县周沟村人，于 2007 年 6 月 8 日就诊。

症状：患者全身四肢的关节皆肿大变形，喜静恶动，劳累即关节肿痛加重，观其舌体胖嫩，苔白，边有齿痕。

脉候：左脉口、左人迎均显浮象，右脉口、右人迎均显沉象。

处方：川牛膝、木瓜、云苓、附片、仙灵脾各 15g，威灵仙 18g，虎杖 20g，细辛 5g，麻黄 7g，桂枝 12g，黄芪 25g，党参 20g，独活 12g，白术 20g，甘草 5g，生姜 15g，大枣 7 枚为引，兼服贫道自制的天罡风湿丸，以观后效。

体会：左边经脉易现升浮太过，左为青龙主阳气之疏泄升发，右为白虎主沉降肃杀，此天地自然之理，人亦应之，故左边经脉多易升浮太过，而右边经脉易导致上升不足。

病例 43

患者：韩某某，女，61 岁，居住在河南南阳油田，于 2007 年 6 月 18 日初诊。

症状：患者头部有频频震动之感，两膝关节疼痛，时而多汗，自述有高血压病史。

脉候：左右脉皆显一倍宽度之弦象，两手脉口之寸部太过明显，而左右人迎之寸部少脉不及。

治疗：弦为肝脉，今两手寸部太过，乃肝经能量升发太过，以致肝风内动，故头部为之震动，人迎为表，在表之阳气宣发不及故人迎寸部少脉。



处方：川牛膝 10g，白芍 20g，牡蛎 20g，龙骨 30g，知母 20g，桂枝 15g，桑寄生 20g，丹参 15g，乌药 10g，照方 3 剂。

6 月 22 日复诊：患者自述服药之后，头部震动明显减轻，但测量血压还是偏高。

处方：鸡血藤 20g，白芍 20g，桂枝 10g，知母 20g，川牛膝 15g，威灵仙 15g，乌药 10g，木通 10g，生牡蛎 25g，生龙骨 25g，桑寄生 20g，卷柏 12g，甘草 12g。

病例 44

患者：周某某，女，40 岁，湖北省监利县周沟人氏，于 2007 年 9 月 17 日初诊。

症状：患者于 1991 年起病，其左眼角睛明穴处长出一个红色疙瘩突起，随着手臂肘关节以下部位运行不畅受牵连性疼痛，经医院确诊为皮肤炎，经用“强的松”治疗数月而疼痛减轻，但却继发周身红色充血样疹块，并出现全身瘙痒，特别是后颈风府穴周围发奇痒。观其面部色红赤，体质十分瘦弱，因瘙痒缘故患者日夜不得安宁，异常苦恼，平素最畏蚊虫叮咬，如被叮咬一口便要大病发作，较平时更甚。自从患痒疹以来，一直服用“刺五加片”“黄芪片”“昆明山海棠片”及“泼尼松片”等药物，近几年来虽一直未曾断药，但终究不能解决一身之痒疹，病发严重时，唯有用“地塞米松”针剂注射及口服“息斯敏”可以暂时缓解。

脉候：左右脉口之寸部皆显不及，而关、尺脉滑；左右人迎之寸部皆显浮而太过之象。

治疗：拟从清热凉血、祛风解毒为法。

处方：当归 15g，赤芍 15g，生地 20g，连翘 20g，金银花 10g，茵陈 12g，薏苡仁 25g，桔梗 10g，防风 12g，南沙参 25g，白芷 15g，



薄荷叶 7g，蝉蜕 10g，升麻 10g，荆芥 8g，黄柏 15g，蒲公英 20g，鲜千里光 50g，甘草 7g。司药 10 剂，每天 1 剂，分 3 次服完，并嘱患者服完 2 剂后，用千里光 500 ~ 750g，薄荷叶 50g 煎汤沐浴，使周身微汗以排出毒素。

10 月 4 日复诊：按上方服用 10 剂药后，患者自述全身症状缓解，面部之红色也已大减，服用上方并无不适反应，遂将蒲公英增为 35g，并嘱如再发病痒甚时，用七星皮肤针扣破痒处，使之微微出血以泄毒外出而绝病根，外用千里光洗法照旧遵行，以观后效，因千里光乃是熏洗皮肤疾病发痒发红的圣药。

病例 45

患者：戴某某，男，21 岁，江苏常州市人，于 2007 年 11 月 17 日初诊。

症状：患者平素爱好气功修炼，但 5 年前由于修炼出现偏差，从而导致身体出现不良反应，患者的头顶百会穴处有热气结聚之感，胃脘部自觉寒凉，饮食无味，睡眠不佳，痰涎清稀较多，腰椎及颈椎骨质增生，导致腰颈椎发僵而不灵活，此病经中西医治疗 5 年其效不显。观其体质丰盛肤黑，舌质淡，苔白腻。

脉候：患者两脉口浮紧而两寸部皆显太过而有余，两人迎之脉均显沉涩。

治疗：从脉处方，当调整阴阳气机平衡。

处方：龙骨 30g，牡蛎 30g，山萸肉 15g，桂枝 15g，桑寄生 20g，淫羊藿 30g，黄芪 10g，乌药 15g，川断 15g，毛狗脊 30g，木通 10g，炙甘草 7g。

11 月 21 日复诊：经服上方 3 剂，其头顶处发热减轻十分之七，然而痰多依旧，乃于原方加“二陈汤”中 4 味药续服 5 剂，后访服



2 剂即痰少，5 剂服完病证若失。

病例 46

患者：高某某，男，50 岁，客运公司司机，住北京，于 2008 年 6 月 11 日就诊。

症状：患者曾患中风，未彻底治疗而留下后遗症，自觉头昏，全身乏力，畏寒怕风。

脉候：左右脉口以及左右人迎之阴阳四处的脉波皆显上升不足之象。

治疗：拟从虚证处治兼以祛风。

处方：桑寄生 20g，防风 10g，川芎 12g，白芷 15g，熟地 20g，黄芪 30g，当归 15g，羌活 9g，赤芍 15g，麻黄 7g，枳壳 15g，桂枝 10g，炒莱菔子 15g，巴戟天 18g，肉苁蓉 15g，炙甘草 7g，僵蚕 10g，乌梢蛇 15g，白附子 10g，生姜 3 片，大枣 7 枚。后来电言，经服上方 10 余剂精神好转，即嘱再按原方泡酒常饮，2 月后访自告痊愈。

病例 47

患者：周某某，女，34 岁，湖南常德人，时在广东东莞任小学教师，此医案乃她本人所写，因她丈夫毕业于广州军医大学，从事西医 17 年，精通西医医疗，故受丈夫影响，亦略通医道。以下为患者自书医案，其医案如下。

周某某于 2007 年 12 月 26 日在晨起时，陡然感到眩晕，并且右耳耳鸣严重。在当月 28 日上午用电脑办公时再度眩晕，入院诊断为“梅尼埃病”。在治疗的过程中，其症状却逐渐增多，相继出现食欲不振、睡眠不佳、体重下降。通过医疗出院后，其本人还是自觉精



神恍惚，睡眠噩梦不断，胆小恐惧，右耳耳鸣，眼花，身体极度虚弱无力。至2008年7月初再度产生眩晕，特别是走路时自觉飘飘荡荡，眼前所见一切似乎都在晃动，并且感觉自我身体内有一股气流从脚至头如同波浪般涌动，坐、行、立、蹲如坐舟车，起伏不止，时而头痛，后背肩部酸胀，而捶打时产生干呕，并出现嗝气，有时出汗，并且口吐清水，观舌发白而苔厚。每月行经提前1周，双乳微胀，经期时间延长，且经血量较多。在当地医院经过半年有余的中西医治疗，其病证时轻时重，因此特前来武当山道教诊所请祝华英道长治疗。

以上乃是患者自述其复杂的症状，当时贫道诊察她的阴阳脉象，诊得患者的左脉口浮越而超过脉体本位，寸部浮散而尺部不及；右脉口脉沉其尺部脉显，而关、寸部脉波不及；其左人迎的寸部现浮大之脉波，右人迎之寸部亦显浮大。初定降心火镇肝木、补脾肺肾兼降胃为大要治疗法则，拟方如下：明天麻15g，石决明30g，钩藤25g，地龙10g，山萸肉15g，代赭石15g，熟地20g，生薏苡仁40g，干姜12g，白术8g，苍术8g，党参20g，茯神15g，法半夏15g，酸枣仁25g，杭白菊12g，黄柏15g，生甘草7g。上药煎2次去渣，2次药液混合后分3次服下，每天服1剂，并嘱咐用辅助方法治疗：①用武当山道教遗传下来的“八宝紫金錠”15粒，在治疗期间每天用薄荷叶5g煎汤取汁，溶化1粒“八宝紫金錠”，然后分2次服下，以镇肝熄风，使不上扰神明；②平时走路，当左足落地时用意念注意到涌泉穴，而右足落地时忽略；③每晚在睡觉前用热毛巾热敷左足的涌泉穴5~7次，当毛巾凉时重复加温拧干再敷。但患者回家后却敷了左右两处的涌泉穴，敷了7天后没有减轻一点症状。后来电话里询问得知后告诉她只敷左足的涌泉穴，不敷右足的涌泉穴。经过2天的治疗，周某某给贫道来电话，她的一切症状



现在已经缓解。这说明，敷错了穴位，将有疗效的治疗效果给抵消了，而改正了治疗方法后却大见成效，在治疗方案中，真是差之毫厘，失之千里。患者敷左足不敷右足仅仅2天，上冲打嗝症状便得以缓解，1周之后其他各症均减。以下为患者自书医案：

服药后1月有余，我的精神、体质逐渐正常，睡眠有了改善，噩梦也少做了，吃饭也有了食欲，虽然还是有耳鸣、视物晃动，但觉得自己基本上已经能如一个正常人一样生活，而在此之前，总觉得飘飘然而思绪不听从自己的意志，不像个正常的人。于2008年9月，祝道医嘱咐在原方上再增加防风10g，山楂10g，砂仁10g，广木香10g，炒栀子12g，枸杞30g，于是又服药了1月，而症状又有了进一步的缓解，已经可以到学校里坚持着上班了。

在2008年10月国庆节放假期间，我又到武当山请祝道医复诊，现有症状如下：头痛头重，眼花，走路不稳有晃动感，畏光，怕声音吵闹，易疲劳，时常需要休息半小时，待精力略有恢复才能继续工作。祝道医为我诊脉后说我阴阳四处的脉波有所缓和，但依然有初诊时的偏差状况，而处方如下：芡实米30g，生薏苡仁40g，酸枣仁25g，代赭石15g，白扁豆25g，白芍15g，白术8g，苍术8g，党参20g，当归12g，夜交藤20g，合欢皮18g，黄柏15g，法半夏15g，砂仁10g，麦冬30g，甘草10g。经过服用此方1月，我身体的病证稍有缓解，精神也好转了一些，但还是特别怕光，在太阳光里不敢睁开眼睛，而月经依然是提前1周到10天左右。将以上的情况以电话告知祝道医，而祝道医嘱咐我加几味药：杭白菊15g，决明子20g，生石膏20g，服药之后畏光的症状有所缓解。之后于2008年11月22日祝道医电话又嘱咐用明天麻20g，芡实50~100g加适量盐和白糖煮汤喝，并于每天早上起床之后吃核桃3个，经过服药1个月左右，舌上的厚苔消失而月经也转化为正常。但是我每天上午



精神觉得较好，而到了下午常常觉得精神疲乏，因此于2009年1月15日祝道医电话通知我制“培元固本散”以协助培养我身体的虚损，处方如下：西洋参150g，广三七100g，莲子心40g，琥珀60g，鹿茸70g，胎盘粉300g，明天麻150g，共7味药加工成面粉状后装入胶囊，1天服2次，第1周1次服1g，第2周1次服1.5g，第3周1次服2g。另外于每天早上服六味地黄丸，晚上服天王补心丹。经服上方半年，人的精神逐渐好转，睡眠好，食欲正常，但我还是有一点轻微的症状，耳鸣、眼花、怕见光、看物体晃动，怕听广播。故于2009年8月3日又前往武当山请祝道医把脉处方，处方如下：丹参15g，白芍30g，熟地25g，五味子5g，桑寄生20g，酸枣仁25g，川断20g，茯神12g，巴戟天20g，白术10g，苍术5g，南沙参10g，党参13g，薏苡仁30g，龙齿7g，葛根10g，补骨脂15g，炒栀子10g，代赭石12g，甘草7g。经服用这最后的处方达3月，我的身体基本恢复了正常，在这里万分感谢祝华英道长！

周某某书于2009年12月20日。

这“梅尼埃病”的病案，乃是患者亲自所写，仅仅在中间的脉诊和处方上是贫道所加，所以此医案的百分之九十以上为周某某所述。据周某某的丈夫说，当今西医难以治愈这么严重的“梅尼埃病”，由于患者的病情复杂，且不知病证的来源，而贫道通过调和十二经脉的左右上下盛衰之不平而治愈了此症，可以证明将来的中医治疗水平要超越西医的治疗水平，可叹的是经络学说的机能机理还未受到当今医学界的认可。而在不久前贫道运用经络学的机理，治疗过一例“帕金森氏病”，患者的两腿不自主的震动而两足却不能迈步，贫道给他治疗了30多天，该患者便能活动散步达500米。但可惜的是因为特殊原因不能跟踪治疗。由此证明，这些神经性质的疑难杂症，利用经络学的机理治疗疗效非凡，也证明了研究十二



经脉的机能机理，其前景光明无量！

病例 48

患者：李某某，女，55岁，本山道协道人，于2009年1月20日就诊。

症状：近5天以来，自觉全身发胀，腰疼，胃肠不适，常发呃逆，食量减少，大便干涩不畅，小便色黄而量少。观其舌质深红，苔微黄。

脉候：左手脉口寸部有余而尺部不及，右手脉口关、尺有脉而寸部涩而不及。

治疗：此肝气过盛横逆侵犯中宫脾胃，以致脾胃升降失司所致，法当升脾降胃调和气机兼以平肝为治。

处方：苍术 15g，厚朴 15g，木瓜心 15g，茯苓 15g，瓜蒌子 12g，枳壳 12g，莱菔子 15g。2剂。后访2剂药服完而诸症痊愈。

病例 49

患者：李某某，女，37岁，本山职员，于2009年1月22日就诊。

症状：患者近一星期以来每天凌晨3点以后产生腹泻，此乃脾肾两虚之五更泻病证。

脉候：左手脉口寸浮，右手脉口寸沉；左人迎寸沉，右人迎寸浮。

治疗：拟从真武汤加减治疗。

处方：炮附子 12g，白术 12g，茯苓 12g，白芍 12g，五味子 5g，补骨脂 20g，川断 10g，砂仁 10g，黄柏 12g，晚蚕沙 10g。新疾易愈，后访经服2剂应药而愈。



病例 50

患者：黄某某，男，58岁，现居深圳市，为伤科医生，于2009年3月1日就诊。

症状：患者往年曾患痰饮症，经治愈后今又复发，自觉有一股寒凉的水气从脑后下降进入咽喉，并伴有背部胀痛，此症状严重时则呕吐痰涎，经多方医治无效，因自己也行医多年，故在近期自服“香砂六君丸”而疾病有所缓解，但不能根除症状。

脉候：左右两脉口之寸部均显不及，且右寸比左寸更弱；左人迎三部脉显，右人迎脉显不及，重按有弦紧之感。

治疗：医圣张仲景师言“病痰饮者，当以温药和之”。

处方：桂枝 15g，黄芪 15g，乌药 10g，党参 10g，广陈皮 12g，当归 10g，吴茱萸 3g，茯苓 30g，法半夏 12g，炒白术 20g，干姜 10g，炙甘草 7g，生姜 3片，大枣 3枚为引。之后，该患者电话告知，经服上方 15 剂而各症均减去十之七八，且初服 3 剂则背痛已愈，嘱继续服药以善后，方才能巩固疗效。

病例 51

患者：吕某某，女，74岁，原籍河南，现居于武当山镇，于2009年3月20日就诊。

症状：患者因突发中风经医疗救治后留下卒中后遗症，自觉身体左侧上肢异常发热，左腿左足僵化不灵，行步艰难，平素吃饭进食以右手为主，左手不能灵活自如。

脉候：患者之左手脉口三部脉浮，右手脉口三部脉沉，两人迎脉亦浮。

治疗：拟潜肝阳健脾肺为治疗大法。



处方：川牛膝 30g，代赭石 25g，白芍 20g，天冬 20g，钩藤 30g，生、熟地各 10g，山萸肉 15g，防风 8g，白术 15g，白僵蚕末 10g，党参 20g，独活 9g，知母 18g，生石膏 35g，天麻 20g，丹参 15g，牡蛎 15g，甘草 7g。处方 20 剂，10 剂煎服，10 剂作丸服用。

病例 52

患者：赵某某，女，42 岁，原籍东北抚顺市人，于 2009 年 8 月 28 日初诊。

症状：患者的生理形态较好，可是患有头痛、背部发凉 10 余年，长治不愈，常常使用西药以镇痛而维持现状，但是近 4 年以来，每日大便 2~3 次，便稀兼有腹痛，特别是小便次数多，在小便以后马上又想去厕所，在工作中非常苦恼，并且有腰痛，左侧重右侧轻，每逢阴雨天前胸连后背有穿刺性疼痛，日常怕饮水增加小便。

脉候：左脉口之寸部浮紧而尺部不及，左人迎脉沉涩；右脉口及右人迎之寸部均沉而无力；其阴阳脉波的寸部均不及而几乎无脉。

治疗：凭脉从症全属一派阴寒之证，拟从温阳化气通滞兼约束小便为治则。

处方：川牛膝 15g，白芍 15g，五味子 5g，附子 10g，干姜 12g，桂枝 15g，黄芪 30g，白术 20g，党参 25g，鹿角霜 20g，川续断 20g，巴戟天 20g，补骨脂 20g，独活 15g，益智仁 10g，覆盆子 7g，山药 15g，白芷 15g，防风 7g，甘草 7g，生姜 3 片，大枣 5 枚为引。

9 月 12 日复诊：经服上方 13 剂后，其小便的次数减少，头痛减轻，患者已经在紫霄宫道教武术学院上班做炊事员，其阴阳的脉象虽然搏力有点增强，但阴阳的偏差还是如上。在原处方中减去覆盆子、白芷、防风、附子，并增加山萸肉 15g，桑寄生 20g，后守此



方又服了20余剂而病愈，追访到2010年的1月份，患者的病情未再复发，其疗效巩固。

病例 53

患者：罗某某，女，60岁，河南省人氏。

症状：患者近3年来每日小便频繁，有时多者半日便要如厕3~4次，腰部酸痛乏力。

脉候：左脉口脉显浮缓，寸部旺于尺部，右脉口及两人迎之脉均显沉细无力，全无升举之阳气。

治疗：气因虚而下陷，失其固摄提升之力，拟升补气机并培补肝肾兼收涩小便为法。

处方：山萸肉30g，生地20g，丹皮12g，茯苓10g，黄芪40g，党参30g，白术18g，升麻10g，小茴香5g，乌药10g，补骨脂20g，桂枝12g，炙甘草7g，金樱子8g，覆盆子10g，川断20g，桑寄生15g。

病例 54

患者：李某某，女，55岁，住湖北宜昌市。

症状：患者下肢两小腿常年水肿，胸腹胀满，饮食甚少，精神不振，全身乏力。

脉候：左侧之脉口与人迎皆显寸部旺于尺部，右脉口及右人迎皆是寸部虚弱而尺部脉沉，法当降左升右为治。

处方：木瓜15g，山萸肉15g，牡蛎15g，青皮6g，虎杖18g，椿根皮9g，炙甘草5g，黄芪20g，云苓15g，苍术7g，白术13g，乌药15g，白芍15g，广木香7g，防己13g。经服上方3剂病退十分之七，嘱其继服3剂以巩固善后。



病例 55

患者：杨某某，男，28岁，住湖北潜江市。

症状：患者病发后经北京协和医院体检诊断为肝血管瘤，其体积大小为3cm×4cm。

脉候：左右脉口两寸部均显不足，两人迎之寸部均显太过有余之象。

治疗：该患者体内的肝血管瘤，是阴阳机能正运不及而负运太过所形成的，拟从小柴胡汤之意处方，以从枢机和畅法调理阴阳，并司药“九玄丹”（自制）60粒协助治疗。

处方：柴胡9g，当归15g，赤芍17g，连翘25g，夏枯草15g，南沙参20g，防风8g，苍术13g，枳壳12g，山慈姑7g，重楼8g，山楂15g，茯苓15g，炙甘草5g，黄芪10g，乌药10g。服药数天后，患者自我感觉良好，遂将处方与药物带回家中调治。

病例 56

患者：李某某，男，40岁，住本山宫观。

症状：近期半月内小便发黄，且小便时阴茎中疼痛并尿血。

脉候：左脉口及左人迎脉之寸部均显浮越，右脉口脉沉且寸部不及少脉，右人迎脉浮而缓。

治疗：拟从清热利湿为治。

处方：生地20g，怀牛膝15g，生薏苡仁20g，虎杖20g，车前子20g，茯苓18g，苍术10g，黄柏15g，广木香10g，南沙参7g，仙鹤草15g，甘草7g。后走访患者，第1剂药服后其病证明显减轻，当第2剂药服完而愈。



病例 57

患者：张某某，女，32 岁，本山村民。

症状：近日患感冒，左侧太阳穴处疼痛，并牵连左目亦痛，饮食量少，大小便自调，曾经医治未见好转。前医处方：柴胡 12g，麻黄 10g，葛根 15g，生石膏 30g，竹叶 12g，甘草 10g，知母 10g，曾服以上处方 2 剂，并配合肌注柴胡注射液 2 支、安基比林 2 支、维生素 B₆ 1 支未效。

脉候：两手脉口之寸部少脉而尺部脉显沉滑。

治疗：拟从疏肝理脾和解法为治。

处方：川芎 15g，柴胡 12g，薏苡仁 25g，黄芩 13g，连翘 20g，防风 10g，党参 20g，白芷 15g，炙甘草 5g，青果 10g。服药 1 剂后，患者自言头痛十去其八，于上方加入当归、赤芍、白术各 10g，再服 1 剂，后访药尽而病愈。

病例 58

患者：余某某，男，39 岁，本山居民。

症状：患者感冒伤风，自服感冒药 7 天未愈，于几天前突然转化为每日下午头痛，寒热往来如疟状。

脉候：两手脉口之寸部涩而不及，两人迎之寸部太过而有余。

治疗：宗小柴胡汤意，和解少阳以调整阴阳气机的平衡。

处方：柴胡 15g，法半夏 10g，党参 20g，黄芩 15g，栀子 15g，防风 12g，连翘 25g，金银花 15g，桔梗 10g，板蓝根 30g。服完 1 剂即病愈。



第三节 注射药物治疗病例

病例 1

患者：李某某，男，50岁，建筑工人，于2002年8月27日就诊。

症状：患者在工作时突然腹部疼痛，出凉汗兼腹泻，不到一小时去4次厕所，大便清稀，面色青，四肢发凉无力。

脉候：两脉口沉、迟、小而寸部涩，两人迎脉虚弱无力。

治疗：症、脉结合诊断，全属寒邪内侵而病，急用药物在穴位注射治疗。取山莨菪碱10mg，地塞米松5mg，维生素B₁100mg，先注入患者的气海穴，然后注射左右阴陵泉穴，药物量3穴平等。10分钟后复查患者脉象，患者两脉口脉搏有明显增强，人迎的迟脉现象消失，腹疼痛等症减轻，半小时后痊愈。

体会：患者的脉、证全属急性虚寒所导致的疾病，故选激素药地塞米松，并补充维生素B₁以激发生理能量，又配合山莨菪碱以散寒止痛，选取属阴经之海的气海穴以及脾经之合穴的阴陵泉穴，所以才能迅速解除疾患。

病例 2

患者：刘某某，男，41岁，木工，于2003年7月15日就诊。

症状：患者的胃部阵发性疼痛，每天早上反胃欲吐，大便稀，病程3个月，曾服过胃必治与庆大霉素片无效，又服用中成药香砂六君丸配合黄连片，只减轻症状，未痊愈。

脉候：左脉口与左人迎的三部脉搏平和，但右脉口脉沉、寸部



衰弱少脉，右人迎脉浮、尺部衰弱少脉。

治疗：确诊为右侧的足太阴脾经的经气虚弱，上升的能量不足，右侧的足阳明胃经下降的能量不足，导致以上病证。在继续服用以上中成药的同时，取维生素 B₁ 100mg、维生素 B₁₂ 0.5mg 混合，注射于右阴陵泉、右血海穴，又取维生素 B₆ 100mg 注射右足三里、右上巨虚穴，隔日注射一次，经过 2 次穴位注射之后，患者病愈。

体会：患者右侧的足太阴脾经上升的功能不足，故取维生素 B₁ 与维生素 B₁₂ 混合注射于阴陵泉、血海穴，以补充其不足的上升能量。患者右侧的足阳明经之下降的功能不足，因维生素 B₆ 有止吐的药效，故认为此药品有协调肠胃的下降功能，选取维生素 B₆ 注射于足三里、上巨虚穴是促进胃、肠的功能下达。

病例 3

患者：杨某某，女，40 岁，本山道协工作人员，于 2005 年 5 月 23 日初诊。

症状：患者自述每月经来必痛，但尚能忍受，时至今日月经来潮小腹疼痛难忍而呻吟不已。

脉候：两手脉口沉而细紧，并呈现左右两手振振摇摆颤抖之象。

治疗：贫道常见此类脉象之疼痛患者，经西医检查多称痉挛性疼痛，患者因难以忍受而痛得两眼流泪，拟用西药穴位注射治疗，希望能快速止痛。取复方氨林巴比妥注射液 2ml，复方当归注射液 2ml，地塞米松 1ml，三药分取混合之后，先注入左右阴陵泉各 1.5ml，后注入关元穴 2ml，注射完毕立刻用湿热毛巾敷关元穴，使药物迅速发挥作用，约 10 分钟后疼痛缓解而愈。

6 月 18 日复诊：患者又痛经甚重，且呻吟不止。脉候：两脉口



之寸部沉涩，两人迎脉浮，脉显迟象。此脉象显示因寒凝经脉，导致足三阴经从足走腹之正运受阻，气血流行不畅故痛甚，然而足三阳从头走足之正运亦受阻不能下达故人迎脉浮而迟，拟调足三阴正运为治。处方：用复方当归注射液 2 支、地塞米松 5mg 1 支、复方安林巴比妥 2ml 1 支、山莨菪碱半支混合，先在关元穴注射 3ml 以促足三阴正运，再于双侧的下巨虚各注入 1ml 以促进足三阳正运，余药臀部肌注，经注射 10 分钟后疼痛缓解。患者于次日又发生疼痛，其左右脉口之寸部脉浮，尺部脉小而紧，两人迎脉涩不畅。取复方当归注射液 2 支、复方安林巴比妥 1 支、地塞米松 5mg 1 支混合，先在左右三阴交各注入 1ml，次取大杼穴各注入 1ml，余药臀部肌注，约 10 分钟后疼痛缓解。地塞米松注入人体后有类似温肾的中药作用，注入三阴交，亦能很快地提升三阴经正运，从而温经通络。

病例 4

患者：解某某，女，36 岁，本山工作人员，于 2005 年 6 月 22 日就诊。

症状：经来小腹疼痛。

脉候：两手脉口之寸部脉虚而涩，关尺部脉显；左右人迎之寸部脉显，尺部脉涩不畅。

治疗：复方当归注射液 2 支 4ml，地塞米松 5mg 1 支 1ml，复方安林巴比妥注射液 1 支 2ml，先在关元穴注入 4ml，次取左右下巨虚穴各注入 1ml，后访经注射后其疼痛随即缓解。

病例 5

患者：徐某某，男，45 岁，道协临时工人，于 2005 年 6 月 27



日就诊。

症状：患者于25日晚病发呃逆，经过2天以来不停。

脉候：两脉口之寸部少脉，关、尺两部亦显虚而不实之象；两人迎之寸部均显浮大而尺部脉微。

治疗：拟用药物穴位注射，以调整脾胃阴阳表里的经气平衡。取维生素 B₁ 2ml、维生素 B₁₂ 1ml，两药混合注射于中脘穴以提升脾脏经气；再取维生素 B₆ 2ml 分别注入左右足三里穴，以导引阳明胃经上逆之气机下行，注射完毕其呃逆即止。

病例 6

患者：张某某，男，17岁，湖北云梦县人，于2005年8月23日就诊。

症状：患者近3年来常患失眠，即使入眠也易惊醒，精神萎靡不振，小便色黄，大便自调，平素胆小易惊，自言从小父母亲管制较严，从而导致性格暴躁，自觉精神压力一直较大。

脉候：左脉口尺部紧而寸部涩，右脉口寸部虚弱不及，左人迎之寸部盛，右人迎之寸部虚。

处方：拟用中西医结合治疗以观疗效。龙胆泻肝丸每次服9g，于右侧肌注黄芪注射液10ml，睡眠前在左侧阴陵泉穴注射安林巴比妥，同时给予西药如下：扑尔敏2片，维生素 B₁ 2片，维生素 B₆ 2片，异丙嗪1片半。次日走访，自述昨夜睡眠达8小时，第2天依然遵上法治疗。第3天走访，自述睡眠达6小时，遂改用中药调理。处方：柴胡10g，当归15g，赤芍15g，枳实8g，黄芪25g，党参20g，茯苓15g，清半夏12g，陈皮12g，桑寄生20g，薏苡仁15g，黄芩10g，竹茹10g，生姜3片，大枣9枚为引。第4天早上走访，自述睡眠尚好，但感觉还不能进入深度睡眠。至第7天患者服完3



剂中药，睡眠已大有改善，诊其脉左寸之脉已出，但右脉口与右人迎之脉仍显不足，守上方用黄芪 40g，太子参易党参 25g 继续调治以巩固疗效。

病例 7

患者：王某某，女，52 岁，来武当山朝山的香客，于 2005 年 11 月 11 日晚就诊。

症状：患者前来武当山朝山进香途中发生胃脘疼痛，并伴有多次呕吐。

脉候：左右两脉口之寸部少脉不及，两人迎之寸部明显盛于尺部。

治疗：先以按摩手法点穴，取左右内关及足三里穴各 6 下，后用维生素 B₁ 2ml、维生素 B₁₂ 1ml、维生素 B₆ 2ml，3 种药液混合，先于右足三里穴注射 1ml，次于左足三里穴注射 1ml，再取中脘穴注射 0.7ml，次日走访患者病愈。

病例 8

患者：邹某某，男，48 岁，住本山紫霄村，于 2009 年 7 月 15 日就诊。

症状：患者之右侧后第二上牙日夜疼痛无法入眠，并牵连耳前至发际的三叉神经亦痛。

脉候：左右脉口之寸部均虚涩少脉，左人迎三部脉波往来均匀，右人迎脉波寸、关之部显浮大而缓。

治疗：经云“别于阳者，知病处”，此病右人迎盛于寸、关，可证胃中实火上炎于右侧，因足阳明胃经之上部气盛，故导致牙齿疼痛。据脉口和人迎阴阳脉象之盛衰显象，拟定西药注射穴位治



疗，以补阴经、泻阳经为治则。取维生素 B₁ 2ml、维生素 B₁₂ 1ml 二药混合，取左右阴陵泉穴各注入 1.5ml，以提升左右脉口正运不及，次以钢针取右侧头维、颊车、气舍穴行泻针法，再以注射器吸取庆大霉素注射液 4 万单位 1ml、鱼腥草注射液 2ml 于右颊车穴注入 1ml，于右人迎穴注入 2ml，注射完毕静息 10 分钟复查四部脉象，左右脉口之寸部脉波已明显增加，右人迎寸、关部浮大太过之象亦明显有减。次日追访疗效，患者言 3 小时后其症平息而愈。

小结：用药物注射穴位治病疗效显著，既有药物发挥的作用，又有刺激经穴的针感效应，能取得双重性的治疗效果。由此认为利用穴位注射治病的前景光明，将来会引起医学界重视，应予开拓发展。可是据贫道研究十二经脉的阴阳正负运行机理认为，一定要确诊出阴阳脉象的紧、缓、大、小、滑、涩及升、降、盛、衰的现象，又要研究出各种药品的寒、热、补、泻及升、降、浮、沉的药物性能，才能拟定出合理选药以及恰当穴位注射的治疗方法。

第四节 西药治疗的病例

病例 1

患者：戴某某，男，19 岁，河南人，彩画工人，于 2005 年 5 月 20 日就诊。

症状：胃脘疼痛欲呕，大便偏稀。

脉候：左脉口及左人迎三部平和，右脉口之寸部微弱无力，右人迎之寸部盛于尺部。

处方：此脾胃升降紊乱所致，用药物调理二者的正运达到正常即可。处方：维生素 B₁ 3 片，维生素 B₆ 2 片，土霉素 2 片，胃必治



2 片，庆大霉素 2 片，司药 5 次，随访服后病愈。方中维生素 B₁ 与土霉素入脾以补升气机，其他三药以降胃经为主，维生素 B₆ 主治欲呕而胃气上逆，胃必治主治疼痛，庆大霉素及土霉素主治大便偏稀。

病例 2

患者：李某某，男，56 岁，本山人，于 2007 年 5 月 27 日就诊。

症状：因感冒发热头痛，全身疲乏无力。

脉候：两脉口之寸部脉弱不及，两人迎之寸部脉盛有余。

治疗：维生素 B₁₂ 2 片，以补益左脉口之寸部；维生素 B₁ 2 片以补益右脉口之寸部，地塞米松 1 片，感冒清 3 片，去痛片 1 片半以发表止痛，服 3 次而愈。

第五节 用药物治疗的心得

在药物治疗方面，祖国医学历史悠久，历代的明贤为后世积累了丰富的经验医方，对各门医科和各种类型的病证都创立了很多医疗方剂。特别是受到历来医家一致公认的有效方剂，都是当今有价值的药方，对于每一种药品入走何经脉前人多有记载，但还应进一步研究证实。

贫道认为，将中药配成了复方使人服下以后，即产生药物作用而能运转人体内外的阴阳经脉。例如：“四君子汤”“理中汤”多侧重于调理人体的右侧，“四物汤”“佛手散”多侧重于调理人体的左侧，“小柴胡汤”与“逍遥散”都属疏理左右中上二焦的和解阴阳之方，“麻黄汤”“桂枝汤”“葛根汤”皆主升散发表于三阳经，



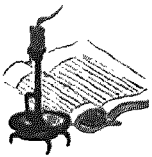
“四逆汤”等专主回阳温里于阴经，“大分清饮”“小分清饮”都是从阳经下降而通利小便，“大承气汤”“小承气汤”皆是由阳经下降而通利大便，“补中益气汤”乃补充左右中上二焦之方，“真武汤”能负运左侧的三阴经和正运右侧的三阴经，“平胃散”可正运右侧的足太阴脾经并且正运胃经、小肠经、大肠经，“崔氏八味丸”“六味地黄丸”是补助左右下焦肾经之药。

贫道认为，凡是能充实和镇摄下焦阴经的方药，都有助于十二经脉的负运之功；凡是能补充和升举上焦阴经的方药，皆有助于十二经脉的正运之力。

中医名方甚多，还有左右阴阳兼调之方，寒温互用之方，升降相济之方，表里并治之方，攻补兼施等等众多方药，难以尽述。所以，研究中医必须测验出各名方在人体的阴阳经内所起到的正负运行作用，以便在临床辨证施治中按理、法、方、药来恰当选用而调治疾病。

治疗疾病，应根据阴阳、表里、寒热、虚实的症状，并结合阴阳脉象的太过与不及以确定虚实而恰当地选方用药。在处方用药时，必须将药品配伍得能够纠正患者体内阴阳盛衰的偏差，才是调整阴阳经脉的正确治疗。凡是七情六欲所致内伤的疾患；均要按这种调平阴阳的原则处治。属于六淫所伤的外感之病，在治疗上应以驱邪为主；如果病人的正气亏损，亦当结合阴阳脉象的虚实和辨别正邪的盛衰给予攻补兼施合理的选方择药。

本书前面所举出的病例，是贫道研究十二经脉之正负机理的认识，病例大多是一般的疾病，所用的治疗药方都是大众皆知的常见方药，因为所采用的方药能与患者的病机契合，故皆能治愈。因为利用经络学治病，可以不用药物，即使用药也不完全依赖药物治疗，可以说其疗效甚高，医疗费用低廉，真值得传遍城镇乡村。贫



困乡村医疗条件甚差，最适合用经络学理论疗病，贫道出生在乡村，深知农民的艰辛，这也是贫道撰写此书的心愿。

为何有的病人请某医生医治没有治愈，而请另外的医生治疗却医治好了呢？这治好病人的医生并非是采用了什么世间稀有的药物，还是采用平常的药物，只不过是其药方的配伍及所施用的药量，正好与患者的病机相投而已。故在临床辨证施治中，根据患者的脉、证，如与古代名方的脉、证符合，当遵古方施用，若见脉、证另有差别，可以增减药物，或自出心裁而立出对症治疗药方。立方原则，或遵仲景医圣的“六经”模式立方，或按温病的“三焦”立法，故上、中、下三焦与阴、阳六经可作为自立方药的规矩绳墨，历来一切治疗疾病的药方，都是从这阴阳六经及三焦的总纲之中化出。

前面转抄的 19 个历代中药祖方是调治上、中、下脏腑阴阳正负运行的代表方剂，因人体之内十二经脉的运行，只有左右、正负、阴阳、升降四种类型，故研究用中药治病，要研究阴阳两性的药品投入人体之后所发挥或升或降的正负药物功能，所以要根据阴阳脉象的往来盛衰对症选方。

《素问·阴阳应象大论》云“味厚者为阴，薄为阴之阳。气厚者为阳，薄为阳之阴”，这是古圣先哲将一切药物概括为四性，因古圣们知无形的阴阳道机，十分了解生天、生地、生人、生物全属一理。又云“味厚则泄”，如大黄、芒硝、甘遂、芦荟之类；“薄则通”，如当归、川芎、防己、木通之类；“气薄则发泄”，如麻黄、羌活、荆芥、防风之类；“厚则发热”，如干姜、附子、肉桂、吴茱萸之类。古圣们认为，一切药物之中不外乎阴、阳、升、降四性及酸、甘、苦、辛、咸五味。药物投入人体之后，即在伴随阴阳十二经脉升降往返的运行中，根据药物组方的正负能量发挥药物作用。



所以择方选药定要根据脉口、人迎的阴盛阳衰或阳盛阴衰的出入升降偏差为纲，并结合浮、沉、迟、数、缓、紧、大、小、滑、涩等脉象，以确诊阴、阳、表、里、寒、热、虚、实而立出对症的药方，其药物组成要有益弱抑强的药物转化功能来调和阴阳。

贫道根据以上用中药治病的认识，在 20 世纪 70 年代做第一次试验，选择了 20 种中草药即桂枝、柴胡、薄荷叶、川芎、附子、干姜、白芍、生地、白术、党参、黄连、黄芩、知母、麦冬、杏仁、法半夏、甘草、茯苓、枳壳、大黄等来调治常见疾病，无论是寒证、热证、表证、里证、虚证、实证均在这 20 种药中选药立方，能够取得百分之八十的疗效。

贫道在 20 世纪 90 年代又做第二次试验，并在以上 20 种药品的基础上，又选择了 39 种中药即防风、白芷、荆芥、独活、牛膝、木瓜、山药、苍术、连翘、金银花、桔梗、黄芪、芒硝、厚朴、沙参、丹参、黄柏、栀子、泽泻、茵陈、制川乌、防己、延胡索、乌药、当归、红花、桃仁、秦艽、威灵仙、石决明、生石膏、五味子、天花粉、蒲公英、石菖蒲、虎杖、贝母、陈皮、香附子等，共合为 59 种中药来医治一切常见疾病，能取得百分之九十以上的疗效。

根据两次用中药试验的结果，贫道深刻地体悟到，调治百病不在于某一种药品的重要，而在于组合药方的能量，能纠正人体十二经脉之阴阳运行机能的偏差。只要用十二经脉机理作指南，准确地针对患者的病证配合恰当的组方，充分发挥其药物作用和组方功能，就能调治一切常见疾病，并取得满意的疗效。

多年来，贫道用中药治病的理性指导，主要根据脉口、人迎的升降、浮沉、盛衰现象来立方用药，但是要注意“外表有邪之浮脉”不可用收摄与下降治法，“邪结在腑里之沉脉”不可用补助与



提升治法，其他杂病都可以按照脉口、人迎的阴阳、升降、盛衰给予调治平衡，病必衰去。

现将以上有表、里邪气之浮、沉脉象的辨证治疗经验介绍如下：

却说浮沉经验语，
全凭脉口论浮沉；
脉浮有邪当解表，
浮脉无邪培下元；
脉沉腑结应通利，
沉脉滑泄补中下。

贫道根据多年实验结果，证明识方用药不在于多，而在于随机应变运用处方。经云“无阴则阳无以化，无阳则阴无以生”，所以医者在治病处方上，定要注重左右阴阳相互转化机理，所施用的方药若能关照到阴阳四方，即是比较周全的处方。

假如有4个病人病证各不相同：第一个胸闷咳嗽痰多；第二个两侧头痛，心胸不安，愠愠欲吐；第三个咽喉发炎疼痛；第四个情志郁闷，头昏嗜卧，胸膈痞满。但4个病人的阴阳脉象大致相同，左右脉口都是关、尺两部脉显而寸部少脉，左右人迎都是寸部盛于尺部，脉波的宽度比脉口稍大。这就说明阴阳脉波的升降运行，负运比较有余，而正运却不足。对这种脉同而症状不同的病人拟定治疗处方如下：第一，治疗胸闷咳嗽痰多病人的处方：用柴胡、当归以助左侧阴经的正运功能；用桔梗、甘草、苏叶以助右侧阴经的正运功能；用茯苓、陈皮、生姜、法半夏、前胡、枳壳为反佐，从阳经降逆化痰以助阳经的正运下达功能，共同起着协调阴阳、止嗽化痰、宽胸的作用。第二，治疗两侧头痛、心胸不安、愠愠欲吐病人的处方：用柴胡、川芎以助左侧阴经的正运功能兼治头痛；用白



术、防风、白芷以助右侧阴经的正运功能兼治头痛；用法半夏、生姜、黄芩为反佐，从阳经降逆以助阳经正运下达功能；共同起着协调阴阳、止头痛、理心胸及降逆的作用。第三，治疗咽喉发炎疼痛病人的处方：用当归、柴胡、板蓝根以助左侧阴经的正运功能；用沙参、桔梗、薄荷叶、甘草、玄参以助右侧阴经的正运功能；用麦冬、金果榄、山豆根为反佐，从阳经降逆以助阳经正运下达功能；共同起着协调阴阳及清热止喉痛的作用。第四，治疗情志郁闷、头昏嗜卧、胸膈痞满病人的处方：用柴胡、当归、香附子以助左侧阴经的正运功能；用苍术、党参、甘草以助右侧阴经的正运功能；用枳壳、黄芩、青木香、瓜蒌子为反佐，从阳经降逆以助阳经正运下达功能；共同起着协调阴阳、消除痞满及疏肝达脾的作用。以上4例的处方用药，均是以调整阴阳升降为核心，所以调治道理全是统一的，但药物的组成各有不同，虽然他们的脉象相同，但病证各异，故药物的组成就不能统一。

各类药物虽然只具有阴、阳、升、降四种性能，但各药物之中所含的药物元素不相同，因而对某些疾病的疗效各有所长。虽然按人体左右、阴阳、正负升降的机理为调治的总纲，来研究各门医科选择良效组方的治疗方药，其药品的组成定会各有所不同，但调治阴阳升降的道理却是一致的。以上4例调治阴阳的用药拟方，可作为用中药调治阴阳升降、治病处方的模型，但亦是呆板的方案举例，是不足为用的。如要做到正确地用药处方治病，还应当从阴阳脉象的寸、尺不足或有余的基础上，再结合辨清浮、沉、迟、数、缓、紧、大、小、滑、涩等脉象，以确定阴、阳、表、里、寒、热、虚、实之后，才能遵照古圣人所倡导的“寒者热之、热者寒之、温者清之、清者温之、散者收之、抑者散之、燥者润之、急者缓之、坚者软之、脆者坚之、衰者补之、强者泻之”等要求有原则



性地调治方药。

在用药的定量上，除含剧毒性药物应当用适当的定量外，其他性质的药物可根据病人脉象的高、中、低、强、弱等，来决定大、中、小多少适宜的药物用量。例如谱曲，只有1、2、3、4、5、6、7七个音符，但灵活、巧妙地运用高、中、低音度的变化，配合不同主题意义的音律与节奏，能变化出百千万不同的歌韵。医者亦然，根据患者脉象的甚微差别，灵活地掌握多少不同的药物用量，亦可取得非常广泛的效果。例如张仲景医圣的“桂枝汤”方，在原汤方的基础上，加重芍药三两，并仅加入一味属生活物质的饴糖，即变化为“建中汤”，将一个治外感的方剂，转变为疗内伤的方药，仲景医圣虽然用药品极少，但变化多。

贫道多年来观察发现，当前中西医治病用药有不足之处。中医由于对人体左右十二经脉的道理不明，没有原则性的阴阳运行机理作指导，在用药治病的过程中，仅依靠经验药方难免有不当之处。西医利用现代医疗仪器，可以检查出人体器官及各组织的病灶，但由于不知十二经脉和阴阳五行的道理，故用药只对准有形质的病灶进行治疗，即是头痛医头、脚痛医脚，却没有关照到无形无象的十二经脉之整体阴阳的机能与正负能量，虽治疗许多急性疾病有速效，但对那些久治不愈之慢性疾病的治疗往往有副作用或不良反应。

所以，唯有将中西医的医理、医术、医药结合起来，各取所长、互相利用，才是比较完美和理想的治病方针。如果没有真理，便难立出真法。贫道反复论述了人体十二经脉的运行机理，将非常复杂的医理简化到了极点（仅仅只有左右正负的运行），但它是中西医学都应当遵循的真理。望医学界的同人利用现代科技实验，探索出药物在人体阴阳经内所发挥的正运或负运作用，从而研制出治疗各科疾病的特效药方。



第十四章 运用十二经脉理论替代手术治疗

人体的脏腑阴阳经脉若长期运行失调，就会产生脏腑疾病，有的甚至病情严重，需要手术切除。贫道认为，如利用十二经脉的理论长期治疗，部分患者是可以不需手术而病除。例如在治愈的患者中，有数例脏腑器官病变的患者病情甚重，都经过大医院确诊需要手术治疗，但经过贫道利用十二经脉的机理给予调治而愈。

病例 1

患者：冯某某，女，50岁，住公安县红旗大队。

症状：患者右肾部常有轻微疼痛，小便频数，排尿时疼痛增加而尿量较少，经医院检查诊断为右肾结核。患病三年有余，常用中西医药治疗而病证时轻时重，未能解除病患。后来其病证逐渐加重，又通过沙市市两个人民医院检查诊断均确诊为右肾坏死，皆决定手术切除右肾。因患者畏惧开刀治疗，经人介绍请贫道医治。

治疗：通过阴阳脉象诊断之后，嘱咐患者每天用毛巾浸入70℃左右温水内，在拧干水分后热敷右太溪、右委中穴，兼敷疗左右足三里穴。敷疗时，需温度适中以不烫伤皮肤为度，如毛巾温度太高可隔衣物外敷，毛巾变凉则重复加温，每次敷疗35~50分钟，并配制一料调正阴阳气血的中成药丸，日服2次以辅佐治疗。经过60多天理疗，患者略见微效；经过半年理疗，患者才觉得肾部疼痛减轻，小便次数减少；理疗到达一年半时间，诸症悉除，来告痊愈。患者再到医院检查，其右肾已恢复正常。追访8年病未再发，并能



操持家务，身体健康。

体会：用十二经脉的机理治病，是在脏腑阴阳经脉循环的路线上调治疾病，能持久调治即可将脏腑阴阳经脉的偏差调正而愈，而不是头痛医头、脚痛医脚，也不是仅仅对某一症状或某一局部的病变现象治疗，而是按阴阳运行升降规律全面性调整，如果调治到阴阳平衡即告痊愈。利用脏腑阴阳经脉的整体观点能持久调治脏腑的疑难病证，亦能治愈需手术治疗的脏腑疾患病人。当今经过手术切除脏腑的病人甚多，贫道深感可悲可悯，特殊的患者若不经手术治疗难以生存，但有部分患者如用十二经脉的原理是可能治好的，若采用了手术切除治疗，既是给患者们带来不应有的痛苦，也可以说是医疗致残。因为通过手术治疗不但使患者受到手术之苦，而且使患者丧失了完整的脏腑阴阳生理功能。曾见到有些患者经过手术治疗以后，往往又相继发生手术后遗症，并且很难医治。所以医者治疗脏腑等疾病，应尽可能地利用十二经脉的阴阳机理进行调治，来挽回不必要的手术治疗。

病例 2

患者：蔡某某，男，44 岁，湖北蒲圻市赤壁镇东风村人，于 1991 年 6 月 16 日就诊。

症状：患者于 1991 年 5 月份被湖北省肿瘤医院确诊为肺癌，准备用手术切除病灶治疗，可是手术切开时鳞状肺癌已扩散到整个肺系，由此便不能采取手术治疗只得缝合伤口，调养多日伤口愈合抽线之后，劝慰病人出院用中药治疗。今经人介绍来武当山道教诊所治疗，但见患者面黄体瘦，舌苔少津。

脉候：左脉口平，微有数象，而左右人迎脉均显浮数，唯独右脉口之寸部虚涩不及。



治疗：拟方从清热解毒、凉血止血、育阴生津为法。

处方：玄参 18g，麦冬 18g，连翘 18g，蒲公英 15g，南沙参 15g，夏枯草 12g，桔梗 10g，生甘草 10g，浙贝母 10g，丹皮 10g，冬桑叶 10g，七叶一枝花 6g，郁金 6g，枳壳 6g，薄荷叶 5g。每天服 1 剂，分 3 次服用，并配合自制的“九玄丹”药物，每天服 1 粒半，每次服半粒，禁忌一切鱼肉荤腥等食物以及烟酒等刺激性物质。

9 月 2 日复诊：患者自述回家后按上方每天服 1 剂，其病证逐渐轻，而且饮食一切正常，大小便可。所幸大见成效，因经上处方药性和平而且剂量不大，现病情已退，服药量当减少，嘱咐患者以后每 2 天服 1 剂，每日服 2 次，配合服用“九玄丹”每天 1 粒，禁忌同上。又经过半年之后，蔡某某来感谢信说，他的鳞状肺癌病通过医院复查已经完全治愈。贫道一直追访到 2010 年，蔡某某依然健在，并且一直从事体力劳动，真想不到他有如此彻底的疗效。由于蔡某某近 20 年来疗效巩固，所以他介绍来多例癌症患者，可是多是经肿瘤医院医疗之后难愈的病人，在初始阶段服药都有明显疗效，但到后期死亡率多而治愈率极少，所以肿瘤疾病也是未来医者们当大力攻关的难题。

体会：一、肿瘤疾病初始阶段不疼不痛，没有痛苦的感觉，所以容易被患者们忽视。但患者们一旦感觉有不良疾患反应时，恶性肿瘤已经发展到中晚期，因此患者们多不能获得早期的医疗而丧失了良机。二、贫道近年以来，对部分肿瘤疾病之左右、阴阳、正负的脉象诊察发现，均有不同程度的偏差不平，这便证明肿瘤疾病也是由左右阴阳运行的偏差导致的疾病，从而证明所有的疾病均是有“道”而来的，医者们当反其道地调正而去之。故医者要抓住这最好的医疗良机，一旦发现患者体现出左右阴阳的不平，便及时地给予纠正以调平阴阳。如此的诊疗可称为“上工治未病”之举，肿瘤



疾病如果延迟到中晚期治疗，即是“下工治已病”而凶多吉少。然而贫道年岁已高，研究条件有限，仅提出治疗肿瘤疾病的观点。

病例 3

患者：郝某某，女，54 岁，住河南新乡小吉镇。

症状：患者多年来咳嗽，痰多色黄，时兼咳血，久治无效，曾到医院透视确诊为痰液阻塞肺叶，建议手术切除治疗，患者畏惧，经人介绍来武当山医治。自述口渴多汗，每到夜晚咳嗽加重，至清晨减轻，每逢咳嗽必痰多汗多，观其舌苔黄而腻。

脉候：滑数缓长，右手脉口之寸部少脉不及，而右人迎、左脉口及左人迎脉均为浮滑缓长之象。

治疗：经云“缓者多热”，且兼滑数，必热痰无疑。因久咳痰多汗多，耗伤肺之津气，故右脉口寸部脉弱不及，兼咳血，乃气血二分皆热也，必是长年心、肝、胃积热，心火刑金烁肺始成此症，拟从久病热痰顽症处治。

处方：南沙参 17g，鱼腥草 20g，桔梗 12g，款冬花 10g，仙鹤草 18g，知母 25g，杏仁 12g，黄芩 12g，云苓 15g，枳壳 10g，麻黄 3g，生甘草 15g，生石膏 80 克（碾碎煎），另每 3 剂药配合甘草合剂 1 瓶、鲜竹沥 9 支同服。

复诊：经服上方 15 剂，诸症皆有好转，然脉象依旧如故，药已中的，唯积热已深，非久治不能根除。

处方：南沙参 17g，鱼腥草 20g，桔梗 12g，款冬花 10g，知母 25g，生石膏 20g，黄芩 12g，杏仁 12g，枳壳 10g，茯苓 15g，防风 7g，生甘草 15g。并配合甘草合剂及鲜竹沥，服法同上。后因服药时间长，于上方加减紫菀、陈皮、胖大海、苏叶等，服上方历时一年有余，其咳嗽病证及痰多逐步减轻而愈，后遇小发病时，又服原



方而愈。

体会：此病左右人迎及左脉口脉皆滑数缓长，人迎主表主六腑，脉口主里主五脏，实乃表里皆积热深厚，使肺不能行使清肃水液下行之功，而致灼液为痰始成此症，其热之深厚实属罕见，余平生所遇仅此一症。关于缓脉，有曰为热，有曰为气虚有湿，虽俱为缓，然缓长者为热，缓而无力者为虚也，二者需详为分辨，虚实自明。



第十五章 略论动静功健身法

疾病危害人类，而健康的生命在于动静结合，即身体要适当运动以通行经络，使气机周行不殆，而精神要恬淡虚寂内守而使正气存内、神气充足。要减少和预防疾病，应以修养为主，治疗为辅，前圣先哲早有定论，所以《素问》开章即论“道生之理”，接着第二章即提倡“四时调神”保健，证明古圣人非常重视养生，使人精气充沛健康不病，故《素问》将之安排在首章的位置。

如果人体生病，阴阳失调无法恢复即需医治，还待医治以观疗效如何，故古圣人将诊疗治病置于次要地位。愿世人争取道德修养，也是我们道家所推崇的保健方法。因善于养生之人可以祛病延年，能获得身体健康减少疾病，应提倡和发扬锻炼修养，才是我国的优良传统。虽然我们人体的生理结构与宇宙大道的运行规律相同，但是宇宙大道是没有意识的自然之道，而我们人类在日常的生活中全是以人道处世，故而受到认识、记忆、思维、感觉、反应以及七情、六欲、名利、嗜好等等干扰，所以与自然之道运行频率不同而有差距。

如《灵枢·五十营》论人一日一夜的呼吸为“一万三千五百息，气行八百一十丈”，若不明修炼的道理，就会认为这“一日一夜的一万三千五百息”有错误而不符合实际。因为一日一夜行一万三千五百息，乃是指古圣人与“周天运行合度”的“道体”呼吸，并不是指我们常人之呼吸所说的。我们平常人的呼吸息数，一日一夜可达到“二万三千多个呼吸”左右。如想修养得与宇宙的自然之



道同频率，必须有正确的生活规律，每天当认真负责做好本职工作，在业余时间里应清心性、淡私欲，每天坚持2~3小时的静功修养，心无挂碍即可获得身心健康，若能刻苦精进，修行的境界将是非常玄妙而无止境的。

由于当今世人多爱好练功健身，故各门各派都在传授修炼功法，虽所获得的层次境界和体验反应颇不一致，但都能取得一定的健身效果。各门各派的功法虽不同，贫道认为其作用皆无外乎静化身心，使人体十二经脉通过安静造化的运行机能，来自行协调达到阴阳共济，从而健康长寿并能使思想得到升华，故常清常静的静化修养才是最佳的保健护身方法，愿世人自勉。

世界上运用动功的健身法甚多，贫道认为唯有太极拳健身效果最佳。武当太极开创于张三丰祖师，三丰祖师不但拳技绝伦，而且精通道术，故发明太极拳的道理，是以太极化阴阳两仪，以两仪化四象，以四象演八卦而变化无穷。太极拳的主要原则，是在人体内运用精神意念行功，须排除妄想，意志专一，气沉丹田，尾闾正中，含胸拔背，虚灵顶劲，以心神领气练拳，提手举足挥发拳路皆要运用神到、意到、形到。以上的心神内用等项，被称为“内家拳”。每天早晚练习一套太极拳，可使全身的筋骨灵活、气血流利，并使十二经脉通畅无阻。如能恒常练习，可以助长精神、和悦颜色、减少疾病、益寿延年，长年身患慢性疾病之人锻炼太极拳，体胖者可减肥，体瘦者可使肌肉增长发达。

何以太极拳有如此显著的功效？由于太极拳的每一招一式，皆符合人体左右侧十二经脉的运行规律。练习太极拳左右手足的动作是：当左侧出手向上方运行拳式时，右侧出手即向下方运行拳式；正当右侧出手向上方运行拳式时，左侧出手即向下方运行拳式，左右手足动作协调而轮换不已，正好与人体十二经脉的机理相一致，太极拳实合乎人体阴阳经脉的运行规律，故能获得优良的健身之效。



第十六章 运用十二经脉理论的心得体会

第一节 诊疗疾病的心得体会

前面简略地论述了对五脏六腑与风、寒、暑、湿、燥、火的辨证，是为了让初学医者引进辨证论治的观点，详细的辨证论治，当参阅现代医籍。当今盛世百家争鸣、名人辈出，现代的医籍已汇集了古今明贤的智慧，对各类疾病辨证分类十分详细，真是应有尽有，无所不备。

贫道根据自己的诊疗经验认为，对各种疾病不应该仅凭脉口脉象就拟定出治疗方案。譬如贫道在未明十二经脉机理之前治病，全依靠医书上的古今名方治病，在疗效上有的患者有效而有的患者无效，有效率仅百分之六十。这就说明药方要与患者的病机相合才能有效，若药方与患者的病机不合便不能见效。张仲景医圣的药方人人都赞扬，若按方投之不合病机亦不会有效；如果与病机相反，甚至还有不良反应。故方药所发挥的能量，必须恰好与患者的病因相投才是对症的真正药方。

贫道现在治病，全依靠十二经脉的道理作指导。在未诊察病人脉象之前，其心中是空白的（但必须具备中医的基础知识），没有任何治疗疾病的方案和方法，经望、闻、问、切诊断之后，根据患者的病因病证，并结合十二经脉的正负运行规律从而得出调治阴阳的治疗方法。多年来贫道在临床上，利用这种左右双向、正负循环



的运行机理，结合阴阳脉象的太过与不及来诊断治疗，无论是用针灸、按摩，还是用中药配方，都能取得满意的效果，有效率能达百分之九十以上。实践证明，利用十二经脉的运行规律作临床指导，其实用价值是不可估量的。

多数患者的脉、证是变化不定的，有些病人脉象相同而病证不同，有些病人的病证相同而脉象又不同，凡临床多的医者都会有这种体验。病人的脉与证是变化无常的，所以采用治病的方药也不应当有一定之规。按教条所规定的中药治病配方或针灸的穴位组方，只可以适应一部分病人，而不能符合所有病人。

贫道最尊重这一随十二经脉的机变其治法亦变的“灵活药方”，预先所规定的对症药方是次要的，可作临床选择的参考药方，唯此才符合实事求是的临床辨证诊疗原则。这个随十二经脉机变其法亦变的“灵活药方”，是贫道多年来在探讨十二经脉道理中的心得体会，还将是贫道未来治病的总方针，但是这个符合每一个病人的真正对症药方是不可能预先说得出来的，读者们若询问这个最合理的治疗药方，已寓于十二经脉的机理之中。经言“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起”，故应潜心钻研十二经脉的正负运行机理，从中取得真正的调治方法。

本书中有数例用针灸和药物调治疾病的医案，这数例医案虽然是贫道在探讨十二经脉过程中的肤浅认识；在本次出版中，贫道又增加了大量的各类诊疗医案，从中或多或少能参悟到十二经脉的玄机。由于十二经脉机理无形无象，类似我们玄门谈道一样，真是只可意会，实难言传。因此，对十二经脉的道理有低层的参悟认识，就能起到低层次作用，有中层次的参悟认识，就能起到中层次作用，有高层次的参悟认识就能起到高层次作用，前贤云“神而明之，存乎其人也”。



贫道十分尊重这个随机应变拟出的处方，但并非反对经验拟方，贫道最喜欢收集民间的治病验方。贫道收集到一个疗水、火烫伤的验方，其疗效要比任何治疗烫伤方效高，而且方法简单，随时随地都能取得应用。如被水、火烫伤后，速用药棉裹住患部，或者用好的卫生纸重叠8~10层裹住患部，再用50度以上的大曲酒（好白酒亦可），蘸上充足酒量以湿敷患部，如干燥就要加酒。一般水、火烫伤采取此法及时3天可愈，如属烫伤的轻症1天可愈，而且蘸上白酒10分钟止痛，用之皆验，真是疗效非凡。由于白酒只能变化气体挥发，所以不污染烧伤的疮面，能保持烧伤处清洁卫生。如用其他外用药方，必定污染疮面，真可谓是烧伤良方。可是当时若不用此方，采用其他烧伤方导致发炎，再用此方却难见效，这是临床的经验。治疗小面积浅表性的烧烫伤疗效非凡，但未曾使用于大面积的烧烫伤患者，故大面积的烧烫伤患者当慎用此法。

从古达今之经验拟方，有出自于终身研究医学的结晶，有从历代的验方再进一步的改进，有受师傅传授的，有祖祖辈辈行医在治疗中偶然所得或者是苦思冥想而千虑一得。世人有很多保守的特效秘方确实是不可否认的，但一些经验药方比较片面，只能对某一种性质的病证特效，对其他的疾患不能够起作用，所以其经验方只能是偏方结晶的成果，是不能够以偏概全的。此外，因为各怀私心，有良效的秘方一般都十分保守。由此贫道还是十分敬佩这个随机应变的处方，所以才大力地发掘、提倡它，这样作为医生才能真正做到随机应变、有的放矢。

第二节 中医辨证的心得体会

祖国中医学历史悠久、源远流长，历代医家所著医籍甚多，各



峭自家的心得已见，若聚集起来真是条理纷纭、浩如烟海，令习中医者眩目畏难。贫道初学医时，见到各家的医理立言颇不一致，真感到遵此则失彼、遵彼即失此，故常迷惑于医道之中。后蒙道机赐缘，使贫道明白了人体之中这个潜藏难得的简捷阴阳机理之总纲，才能理解各家创论的独到之处乃是阴阳化象所分之目，所以若把握这十二经脉的阴阳总纲再去观目，即可一目了然、胸有定见。

古今的贤哲总结经验，将寒、热、虚、实、阴、阳、表、里之八纲辨证作为中医的诊疗规则。贫道认为，八纲的显象乃是十二经脉运行所转化出的枝叶表现，虽然在临床辨证中能起到诊断作用，但是由于人体十二经脉的生理及病理机能犹如树身树根，所以更应该了解这树身树根之阴阳发源处的道理，才不致为阴阳之极化分象和乖变所惑。医道皆言调平了人体之内的阴阳疾病即愈，如果不明人体十二经脉之正常的阴阳运行规律，怎能有目的地去调整不正常的阴阳偏差呢？所以中医了解十二经脉的机理是至关重要的。

因为人只要有生命，体内的十二经脉就恒常存在运行不息，故依据人体内在的这个阴阳命蒂之正负机理，就可以随机应变地去医治百千万种疾病。《灵枢·经脉》云“经脉者，所以能决死生，处百病，调虚实”，所以敬望读者潜心参考，根据人体之阴阳正负机理来定方立法，从而拟定出治风、治痰、治气、治血、治虚、治实、治寒、治热、治湿、治燥等的对症药方或针灸调治的穴位选择。

人体之内这个无形无象的十二经脉结构之名称，在《素问》《灵枢》中称它为十二经脉，在现代医学中称它为神经组织系统，但现代医学解剖学所说的神经组织只不过是十二经脉正负运行所促使人体组织的动态而已。因为神经组织乃现代医学中的精神感觉生理系统，如果人死之后解剖观察，其有知感的“阴阳出入灵机”已



经消逝离体，经云“出入废则神机化灭，升降息则气立孤危”，所以只可以见到十二经脉的运行途径，而不能够见到这无形无象之“阴阳神机”，故现代医学所说的神经组织路线，与古圣人所论述十二经脉的“灵枢”运行路线是有差异的。经云“所言节者，神气之所游行出入也，非皮肉筋骨也”，说明古圣特别重视人体之内这个无形质的游行出入神机。

在20世纪70年代出版的个别中医书籍，对“肝藏魂、肺藏魄”多有删除，就失掉了祖国医学的精华。这魂与魄是人体内精神活动的代名词，亦如人体十二经脉的机能活动一样，虽然见不到它的形象，但在人体之中却有它的实际能量。仅提浅而易明的道理来说，例如精神病人因精神错乱，则时喜、时怒、时悲、时恐，动作失常而不能自控，这难道不是人体之内的精神变态事实吗？

医学理论定要尊重事实，在临床中不能有半点含糊。祖国医学理论是古圣人对宇宙大自然阴阳之道的认识，结合人体的阴阳生理结构与宇宙同体，认为我们的人体是宇宙的一个缩影，故全是以天人合一的理论观点来概述宇宙间与人体内的生理联系，都是有事实道理而确实存在的立论。

经云“随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄”，按医理定位，肝属东方，心属南方，东南方位属阳，隶属于人体的左侧，故肝藏魂、心藏神是人体左侧精神往来活动的代名词。由于人体左侧属阳主升，人怒则气上、喜则气缓皆是受情志刺激使精神提升之故，所以喜、怒过度则伤害人体的左侧精神。肺属西方，肾属北方，西北方位属阴，隶属于人体的右侧，故肺藏魄、肾藏精是人体右侧精神出入活动的代名词。由于人体右侧属阴主降，人悲则气消、恐则气下全是受情志刺激使精神下降之故，所以悲、恐太甚则伤害人体的右侧精神。人的精神意识在正常情况时，即属魂、属



神、属魄、属精，在反常情况时，即转化为怒、喜、悲、恐等，这全属人体之内无形的精神转化所致，故为医者必须了解其原因，在临床诊疗精神变态的疾病时，当以精神理论分析来作诊断依据。但医生治病，对于精神和物质均要重视，物质靠精神来转化，精神赖物质以濡养，精神与物质相互依存、互相转化是不可分割的，在诊疗中必须二者兼顾才能获得良效。

《素问·上古天真论》中所论述的“天癸至”之言，历来的医家有的认为是指妇女生长到 14 岁时期的“月经至”所说的，由于又见到论男子生长到 16 岁时期亦有“天癸至”之论，所以有的医家才认为“天癸至”并不完全是指妇女的月经所说的，只能怀着不可理解的疑团而已。直到现在，有了现代的科学仪器对男性和女性的生殖系统作观察证明，才认识到《素问》中所说的“天癸至”乃是指女性生长发育到达排卵期、男性生长发育到达排精期。如果没有进化发展到现代科学仪器观察出来，这个疑问将会永久难以得到解释。由此，这不能不令人惊讶，数千年以前的解剖实验等科技十分落后，古圣们对人体之内却了解得多么精微透彻！就如这一“天癸至”之例，一直到今天高科技时期才证实无虚，就可证明古圣先哲们有无量的大智大慧，才著作出《灵枢》与《素问》。

再根据贫道所取得的十二经脉机理，更能证明古圣的著作中没有一句虚言，全是论述有事实存在的真理。如果我们还不能了解其中的道理，只能说我们的研究认识还没有达到古圣所认识的境界，不能以个人观点来否认。贫道相信依靠现代科学研究核实，就能使祖国的医学理论逐步地被人类所承认并发展，在不久的将来会圆满成功运用于临床。



第十七章 十二经脉理论是契合 中西医的桥梁和诊疗指南

《素问·阴阳应象大论》曰“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也”，阴主地气其气上腾，阳主天气其气下降，阴阳交合而生万物，故阴阳乃天地之道也；大地万物的生、长、收、藏都是根据阴阳消长的变化进行的，所以说阴阳是万物之纲纪；在春、夏、秋、冬四季中阴阳气候互相交替演化，世界上的万物及生命就会产生出千变万化，所以说阴阳是变化之父母；随着年、月、日、时的阳生阴长、阳杀阴藏的阴阳盛衰规律，万物及生命均受此阴阳制约而由生到死，所以说阴阳是生杀之本始。

宇宙自然界之无形无象而又有大能量的“阴阳之道”养育着天地万物的生命，人体之内亦存在着这无形无象而又有大能量的十二经脉阴阳之道，它运化着人体的头、身、四肢、脏、腑内外的新陈代谢与生死过程，故十二经脉乃人身之道。

玄门道经云“一阴一阳之谓道”，我们的道祖太上老君传教玄门弟子“返璞归真”即是真道，所以追溯简朴乃“归真”的需要，追求分化道理是“应物变态”的需要，追求世俗分化道理是“应物应变”的需要。

现代医学在微观现象上已将人体的各器官各组织研究得非常清楚，却缺少这无形无象十二经脉之宏观的阴阳道理。故贫道认为，



在当今医学理论上，也要学习我们道祖的“返璞归真”，十分需要反归到最“简朴本原”之十二经脉的阴阳道理。因为道生一，一生二，二生三，三生万物，如果只注意于万物各式各样的复杂现象，却忘掉了这个最本原的“一”，就会受众象所惑。

贫道认为，人体之有形的众象表现可作为“标”的诊断，简单无形的十二经脉机理可作为“本”的诊候，“标本互用”才是最周全、最准确、最合适、最完整的诊疗原则。

人体产生疾病，皆因十二经脉运行不平。如因阴阳经气虚弱而遭受风、寒、暑、湿、燥、火六淫的不正之气犯人，则病由外入；若由喜、怒、忧、思、悲、恐、惊之七情所伤害人，则病从内生。人体患病均是受内、外的因由而感染，其内、外因由的疾病，都是有道而来的，医者治病即可以有道而排除。人体患病种类甚多，实难确定其数量，但人体之内十二经脉的运行仅只有“一升一降”的正负机能。从古到今的中药医方不下千万种之多，药物投入人体之后，只有靠五脏六腑吸收转化到阴阳经脉才能发挥作用。由此证明，唯有掌握这个最简捷最本原之十二经脉的阴阳正负机理，才能灵活应变而处治一切疾病。

贫道认为，发现了十二经脉的阴阳正负之本原机理，犹如世间发现了“阴阳电理”一样，各行各业的科研根据这阴阳电流道理作思路，便可设计研制出各行各业能起作用的科研仪器。各门医科如能循着这无形无象之阴阳正负机理的“公式”作思路，亦可能研究出各门医科的正确治疗方法。贫道在 30 余年中采用针灸、按摩及药物治疗能取得良好的效果，全是以十二经脉的核心理论作指导。贫道根据多年的实践认为，以上的理想是能够实现的，所以确定十二经脉的阴阳机理，是各门医科诊疗疾病的方向盘、指南针。

中西医结合在治疗上已创造出很多可贵的成效，故中西医结合



是将来医学发展必然的趋势，可是由于中医、西医的理论体系不同，故在医理上很难结合起来，因中西医的医理上存在着两类不同的性质。

1. 西医治疗理论的指导，是以人体各器官组织的正常生理指标为准则。当人患病时，在诊疗上是通过各类医科仪器检查及化验，根据检查出的异常现象及化验出的异常指标来辨证施治。

2. 中医治疗理论的指导，是运用望、闻、问、切四诊及阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八纲，分别从上、中、下三焦及手足阴阳六经来辨证施治。

这说明中医治病完全是依靠医者主观的神识辨证以整体观点而进行治疗的，而西医治病完全是依靠化验室显象的科学证据，从形态解剖学观点而进行治疗的，因此便形成两类不同理性的医理。可是，中医辨证施治理论的阴阳、五行、三焦、六经等无形象的结构却拿不出来，不能用现代科学仪器进行检验，因此中医、西医在医学的理性上就难以融合起来。

中医与西医治病都有疗效，实践证明中西医疗各有长处，应在中西医的理性上相互地渗透，互相地了解。贫道认为，特别要了解人体唯一生命机能之十二经脉的结构，以了解人体生命的本原机制，才能互相地开拓医学和发展医学，又才能逐步地提高中西医的诊疗水平。

贫道通过研究人体之内十二经脉的阴阳正负机理，认为世界上所有生物的体内，均潜藏着这种既自然又自如相对应性的生命生机，所有生物这种对应性机能一旦脱离了形体，其形体生命即告终结。人体内十二经脉的正负运行机理，是各门医学拯救生命、治疗疾患之内在最重要的根本原理，此原理是中西医理论结合的桥梁，能使中西医学互不矛盾地结合起来而共同前进。因此，贫道特提出



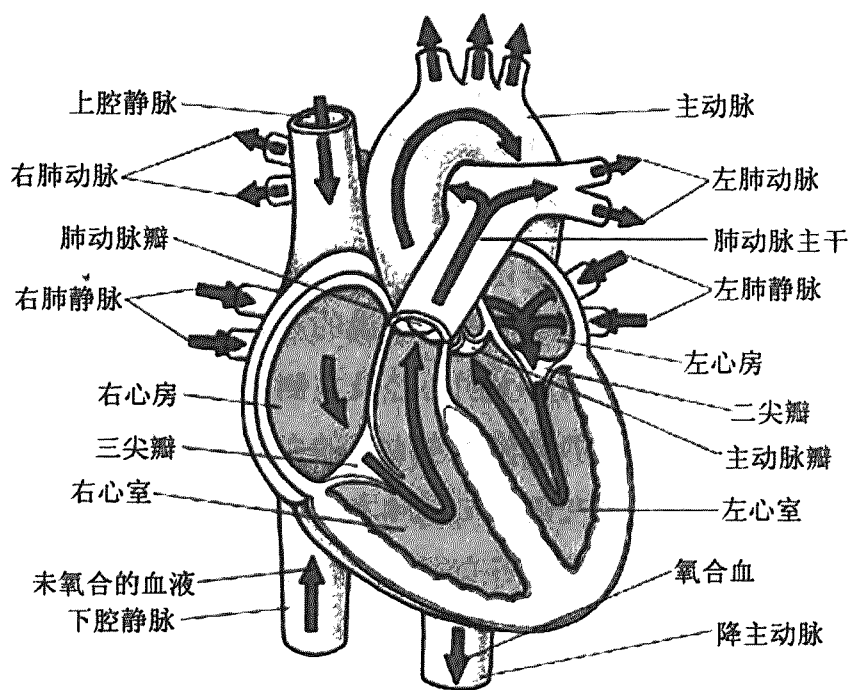
所研究的观点如下。

西医利用医科仪器所观察到人体的心脏，是由左右心房和左右心室所组成的脏器，是通过左右心室、心房的房室瓣有规律地开放与关闭的机能，来驱动人体的血液循环，这说明现代的西医仅知道人体心脏的形态组成和血液循环运行的机能显象，而并不了解左右心房、心室这种有机能规律之原动力的发源处。贫道研究认为，确实是人体内十二经脉之左右、阴阳、正负运行的震动频率，导致心脏机能的血液循环现象。现代医学所说的左心室输出动脉的血液循环运行，认为即是左侧的手少阴心经及左侧十二经脉之正运机能所促成的血流形态表现；静脉输入左心房的血液循环运行，即是人体左侧的手少阴心经以及左侧十二经脉之负运机能所促成的血流形态表现。按以上的机理类推，右心室与右心房的血液循环运行亦与左侧的机理相同。人体心脏的左右心房、心室有节奏有规律的血液循环运行，全是人体内十二经脉之左右阴阳正负的机能节奏频率所推动的，故心脏的血液因受阴阳经脉之左右正负机能频率的制约，从而形成有节奏有规律的血液出入循环。因人体的血液是红色，故利用现代医科仪器比较容易观察出它的运行现象。

由于人体十二经脉的生理机能无形无象，就是利用现代高科技仪器亦难查出它的全貌，故贫道反复思考，研究出一个可以侦察出人体十二经脉的正负运行的方法：根据人体十二经脉之左右阴阳正负机能的节律推理认为，人体的左心室与右心室的开放和关闭是不同秒分的节律时间，左心房与右心房的开放和关闭亦是不同秒分的节律时间，但是左心室与右心房之开放与关闭的机能节律是同时进行的，右心室与左心房之开放与关闭的机能节律是同时进行的，心脏的这种机能运行现象已经得到现代医科仪器检测落实。这虽然未获得无形无象之十二经脉的本质，却可以对人体十二经脉的左右阴



阳正负运行机理作出鉴定，若更进一步的研究开拓，便能挖掘出人体十二经脉之生命科学的真相。(图十一)



图十一 心脏的组织结构及工作原理示意图

再如现代医学所论鼻、咽喉、气管、肺之相对立的一呼一吸气体交换机能，肠、胃消化道之相对立的舒缩蠕动机能，五脏、六腑的交感神经与副交感神经之相对立的双重支配相互协调机能，以及用血压计所验测出相对立的收缩压、舒张压之升降生理的数据等，全都是受人体手足阴阳十二经脉之正负运行频率所导致的种种相对立的机能现象与病理现象。

由此认为，中医十二经脉的阴阳正负运行机理确实与现代西医的理论相默契。所以，弄清中医理论中之十二经脉的本原机理，中西医结合理论的结合即不存在什么问题。现代医学仅从微观上研究人体有形有质之五脏六腑等等相对立的生理现象与病理现象，并发现



很多正常生理细胞的组织与不正常的病菌组织及所衍化出的种种微观生物现象，没有从中医的宏观上来了解阴阳十二经脉的正负运行之“平”与“不平”所导致的一切生理生化现象。由此证明，人体阴阳十二经脉的左右正负机理，确实是中西医学诊疗疾病之唯一简捷的医学理论公式。《灵枢·经别》云“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起，学之所始，工之所止也”，这说明人体十二经脉机理的作用，既是人体生理机能的根本活力，又是治愈疾病所遵循的理性之一，还是初习医生必须具备的基础医理知识，亦是研究医学知识到达尖端的止境。十二经脉的左右阴阳正负机理，既是中医学的本原真理，又是深藏在西医背后之潜隐性的本原真理，确实是中西医理的本中之本，亦是中西医学之理论结合的桥梁，祖国医学的经络学说是当代 21 世纪中西医学发展前进方向的唯一目标，所以中西医各界人士对人体阴阳十二经脉的研究均要特别地重视。



对中医十二经脉的研究总结只有一句话，即
人体内十二经脉左、右、手、足、阴、阳、正、
负灵活往返、轮回交替的机能机理。

——祝华英

责任编辑：孙志波

封面设计：张雅娣

对十二经脉的研究总结只有一句话，即：
人体内十二经脉左、右、阴、阳、正、负
灵活往返，轮回交替的机能机理

——祝华英

ISBN 978-7-5152-1383-5



9 787515 213835 >

定价：48.00元